

REPORT · 25–27 АВГУСТА 2026

НЕ ПРОСТО НАКОРМИТЬ

Научно-аналитический доклад для межрегионального семинара
«Пространство Новых Идей 2.0»

ДДИ Дом-интернат для детей с инвалидностью ЦСОН Центр социального обслуживания населения ФЗ Федеральный закон НПА Нормативный правовой акт Индивидуальная программа предоставления ИППСУ социальных услуг КПРИ Конвенция ООН о правах инвалидов СанПиН Санитарно-эпидемиологические правила и нормы ТР ТС Технический регламент Таможенного союза ЕАЭС Евразийский экономический союз НМЦК Начальная (максимальная) цена контракта Hazard Analysis and Critical Control Points (система HACCP анализа рисков) IDDSI International Dysphagia Diet Standardisation Initiative ESPEN European Society for Clinical Nutrition and Metabolism НОК Независимая оценка качества RACI Responsible / Accountable / Consulted / Informed

Глава 1. Один обед — пять конфликтов

• Собирательная ситуация, составленная для анализа; не описание конкретного учреждения.* Обед. В столовой — сто человек. У кухни — две позиции основного блюда, но одна закончилась до подхода третьего отделения. Один житель не ест рыбу. Другой быстро заглатывает пищу, не жуя. Третий получает протёртую диету по назначению врача. Четвёртый убеждён, что еду отравили, отодвигает тарелку. Пятый не может сказать, чего хочет, но отворачивается от одной тарелки и тянется к другой. Шестой просит добавку, хотя диетолог ограничил

I	
ДДИ	Дом-интернат для детей с инвалидностью
ЦСОН	Центр социального обслуживания населения
ФЗ	Федеральный закон
НПА	Нормативный правовой акт
ИППСУ	Индивидуальная программа предоставления социальных услуг
КПРИ	Конвенция ООН о правах инвалидов

СанПиН	Санитарно-эпидемиологические правила и нормы
ТР ТС	Технический регламент Таможенного союза
ЕАЭС	Евразийский экономический союз
НМЦК	Начальная (максимальная) цена контракта
НАССР	Hazard Analysis and Critical Control Points (система анализа рисков)
IDDSI	International Dysphagia Diet Standardisation Initiative
ESPEN	European Society for Clinical Nutrition and Metabolism
НОК	Независимая оценка качества
RACI	Responsible / Accountable / Consulted / Informed

калорийность. Седьмой сидит в инвалидной коляске, у него тремор — он не может нести ложку ко рту, помощник отсутствует, потому что отделение не укомплектовано санитарками. Восьмой — недееспособный инвалид, его опекун — само учреждение. Кто-то из персонала заполнил за него лист выбора ещё утром. Кто здесь выбирает: человек, санитар, диетсестра, врач, кухня, контрактный управляющий или региональная норма? За этой сценой стоят пять конфликтов, которые нельзя решить ни лозунгом о достоинстве, ни отдельным приказом директора, ни увеличением финансирования. Их можно только увидеть, назвать и работать с каждым.

Конфликт 1. Выбор и безопасность

Житель хочет то, что ему нельзя. Сахар — при диабете. Рыбу с костями — при дисфагии. Сырые овощи — при гастрите. Шашлык — при постельном режиме и атонии пищевода. Здесь сталкиваются два права: право на уважение автономии и право на охрану здоровья. Ни одно из них не абсолютно. Прямого запрета на коррекцию выбора в пользу безопасности в законодательстве нет. Но и абсолютного права «выбирать всё, что хочется» — тоже. Что делает директор: □ разделяет «выбор блюда» (повседневное бытовое решение) и «выбор, противоречащий

медицинскому назначению» (вопрос медицинской компетенции); □ обеспечивает, чтобы у каждого жителя была карта питания с указанием разрешённого и запрещённого; □ обучает персонал распознавать «красные флаги» (удушье, аспирация, острая аллергия); □ документирует каждый случай замены блюда по медицинским основаниям.

Конфликт 2. Предпочтение и медицинское назначение

Житель выбирает блюдо, противопоказанное по диете. Что важнее — его вкус или назначение врача? Что делает директор: □ устанавливает процедуру врачебного консилиума в спорных случаях; □ разъясняет жителю (в доступной форме) суть ограничения; □ фиксирует информированный отказ, если житель дееспособен; □ не превращает «отказ от диеты» в автоматическое основание для дисциплинарных мер.

Конфликт 3. Индивидуальность и массовое производство

Кухня — это конвейер. Она не может приготовить 100 разных супов на 100 человек. Персонал отделения не может нести 100 разных тарелок одновременно. Бюджет не может покрыть 100 разных рационов. Что делает директор: □ проектирует меню как «несколько линий», а не «много уникальных блюд»; □ использует блочную сборку (основа + вариативный компонент); □ стандартизирует то, что должно быть стандартизировано, и варьирует то, что должно быть индивидуальным; □ не путает индивидуализацию диеты (медицинская необходимость) с индивидуализацией выбора (организационная возможность).

Конфликт 4. Достоинство и институциональный режим

В учреждении все едят в одно время, в одном месте, в одном темпе. Это не достоинство, это режим. Житель, который привык есть позже, не встающий до обеда из-за седативных препаратов, не успевающий поест из-за медленной подачи, — лишается не просто еды, а привычного ритма жизни. Что делает директор: □ выделяет «окно завтрака» для поздно просыпающихся; □ обеспечивает круглосуточный доступ к воде и лёгким перекусам; □ не превращает «время приёма пищи» в дисциплинарный инструмент; □ даёт возможность перекуса в отделении для тех, кто не

может есть в общей столовой.

Конфликт 5. Управленческая инициатива и ответственность директора

Директор хочет сделать хорошо. Но при пищевом отравлении — ч. 3 ст. 236 УК РФ (до 7 лет лишения свободы при смерти двух или более лиц). При аспирации — ст. 109, 118 УК РФ. При хищении средств подопечных — ст. 159, 160 УК РФ. Любая инновация — это управляемый риск, и директор — тот, кто его несёт. Что делает директор: □ документирует каждый шаг; □ согласовывает с учредителем то, что требует согласования; □ не решает единолично то, что требует врачебного или юридического решения; □ ведёт переписку о дефиците ресурсов; □ формирует «защитный контур» — комплект документов, подтверждающих добросовестность.

Глава 2. Кто сидит за столом: неоднородность жителей

Любое обобщение «жители ПНИ/ДСО» — это упрощение, опасное для принятия решений. За столом — люди с принципиально разными потребностями, способностями и рисками.

2.1. Психические расстройства

В ДСО/ПНИ проживают люди с: □ шизофренией, шизоаффективными и бредовыми расстройствами; □ биполярным аффективным расстройством; □ рекуррентным депрессивным расстройством; □ тяжёлыми тревожными расстройствами; □ расстройствами личности (пограничное, шизоидное, эмоционально неустойчивое); □ посттравматическим стрессовым расстройством; □ психическими расстройствами вследствие эпилепсии, черепно-мозговых травм, инфекций, интоксикаций. Каждое из этих состояний влияет на пищевое поведение по-своему. Психотическая симптоматика может сопровождаться бредовыми интерпретациями еды (отравление, наблюдение, магическое воздействие). Депрессия — снижением аппетита вплоть до отказа от еды. Мания — перееданием и нецелевым расходованием средств. Тревожные расстройства — избирательностью, страхом подавиться.

2.2. Когнитивные нарушения

Деменция — вторая по частоте причина проживания в ДСО/ПНИ после шизофрении. Виды: □ болезнь Альцгеймера; □ сосудистая деменция; □ деменция с тельцами Леви; □ лобно-височная деменция; □ деменция при

болезни Паркинсона. Каждый вид имеет свои особенности. При деменции с тельцами Леви — выраженные колебания внимания и зрительные галлюцинации (в том числе в отношении еды). При лобно-височной — расторможенность пищевого поведения, переедание, навязчивое поглощение одной и той же пищи. При сосудистой — ступенчатое снижение, риск инсульта во время еды.

2.3. Интеллектуальные нарушения

Уровни: □ лёгкая умственная отсталость — большинство жителей с этим уровнем обслуживаются на дому или в ЦСОН; в стационарных ДСО — единично; □ умеренная — частичная самостоятельность, требуется поддержка; □ тяжёлая — минимальная самостоятельность, требуется полная помощь; □ глубокая — почти полная зависимость от помощника.

2.4. Расстройства аутистического спектра

Специфические проблемы: □ жёсткая избирательность по текстуре, цвету, запаху, температуре; □ ритуалы, связанные с едой; □ сенсорная перегрузка в шумной столовой; □ трудности с изменением привычного.

2.5. Сочетанные нарушения

Многие жители имеют комбинацию: шизофрения + умственная отсталость + эпилепсия + соматическая патология. Это означает, что один и тот же житель может нуждаться одновременно в: □ диете при сахарном диабете; □ текстурной модификации при дисфагии; □ ограничении соли при гипертонии; □ исключении глютена при целиакии; □ помощи при приёме пищи при треморе; □ наблюдении при риске аспирации; □ специальной подаче при нарушениях поведения.

2.6. Коммуникативные ограничения

Часть жителей не говорит или говорит ограниченно. Причины: □ последствия инсульта (афазия); □ тяжёлая умственная отсталость; □ расстройства аутистического спектра; □ поздние стадии деменции; □ избирательный мутизм при психозах. Для этих жителей выбор требует альтернативной коммуникации: карточки с фотографиями, пиктограммы, «Talking Mats», жесты, наблюдение за поведением.

2.7. Маломобильность

Часть жителей: □ на креслах-колясках; □ с нарушением координации; □ с тремором; □ с гемипарезом; □ с контрактурами. Для них критически важна адаптация столовых приборов, посуды, мебели. Это не вариативность, это базовая доступность.

2.8. Институциональные привычки

Часть поведения — не болезнь, а привычка, сформированная годами жизни в учреждении: □ привычка к определённому времени; □ привычка к определённому месту; □ привычка к определённой пище; □ привычка не выбирать. Эти привычки можно менять, но медленно, через постепенное расширение опций, без насилия. Таблица 2.1. Распределение жителей по основным диагностическим группам и его влияние на питание

Иллюстративное распределение. Реальные цифры зависят от конкретного учреждения. Доля в популяции Главный риск для питания Главная возможность выбора

Группа (илл.) питания для выбора Побочные эффекты Стабильные

Шизофрения, 30–40% нейрорептиков (вес, предпочтения, могут

стабилизированная дислипидемия) выражать выбор Отказ от еды при

Шизофрения с частыми Ограниченный, через 10–20% обострения, бред

обострениями наблюдения отравления 15–25% Умеренная/тяжёлая

Дисфагия, переедание, Поддерживаемый выбор

Группа	Доля в популяции (илл.)	Главный риск для питания	Главная возможность для выбора
Шизофрения, стабильная	30–40%	Побочные эффекты нейрорептиков (вес, дислипидемия)	Стабильные предпочтения, могут выражать выбор
Шизофрения с частыми обострениями	10–20%	Отказ от еды при обострениях, бред отравления	Ограниченный, через наблюдение
Умеренная/тяжёлая	15–25%	Дисфагия, переедание,	Поддерживаемый выбор
умственная отсталость избирательность через карточки			

Деменция разной Дисфагия, риск П оддерживаемый выбор
15-25%
этиологии аспирации, потеря веса через рутину
Побочные эффекты
Стабильные
Эпилепсия 5-10% антиконвульсант ов,
предпочтения
взаимодействия
Сенсорная перегрузка, Жёсткая избирательность
РАС 1-5%
ригидность — учитывать
Прочие (органические,
5-10% Различны Различны
последствия травм)

Глава 3. Что значит «накормить»: шесть функций питания

Питание в ДСО/ПНИ — это не «доставка калорий». Это одновременно шесть функций, каждая из которых имеет свои требования к организации.

3.1. Физиологическая функция

Обеспечение организма: ☐ энергией (калорийность); ☐ нутриентами (белки, жиры, углеводы, витамины, минералы, клетчатка, вода); ☐ биологически активными веществами. Требования: Соблюдение натуральных норм (Приказ Минтруда 520н от 13.09.2022; региональные акты). Контроль калорийности и нутриентного состава. Документирование.

3.2. Безопасность

Исключение рисков: ☐ пищевого отравления (микробное, химическое, физическое);

умственная отсталость		избирательность	через карточки
Деменция разной этиологии	15-25%	Дисфагия, риск аспирации, потеря веса	Поддерживаемый выбор через рутину
Эпилепсия	5-10%	Побочные эффекты антиконвульсантов, взаимодействия	Стабильные предпочтения
РАС	1-5%	Сенсорная перегрузка, ригидность	Жёсткая избирательность — учитывать
Прочие (органические, последствия травм)	5-10%	Различны	Различны
☐ аллергической реакции;			

□ аспирации;

□ дисфагии;

□ отравления лекарственных-пищевыми взаимодействиями.

Требования:
НАССР.
Соблюдение СанПиН 2.3/2.4.3590-20.
Текстурная

модификация.
Учёт аллергий.
Взаимодействие с врачом.

3.3. Удовольствие

Еда — источник удовольствия. Без удовольствия снижается аппетит, уменьшается потребление, нарастает дефицит нутриентов. Особенно важно для жителей с депрессией, апатией, когнитивными нарушениями. Требования: Вкус. Запах. Температура. Подача. Учёт предпочтений.

3.4. Социальная функция

Приём пищи — социальный акт. За столом происходят коммуникация, поддержание отношений, ритуалы. Изоляция в отделении во время еды — форма социальной депривации. Требования: Общая столовая. Семейная подача (при возможности). Сопровождение. Гостевой режим (для родственников).

3.5. Автономия

Возможность выбирать — элемент обычной взрослой жизни. Лишение выбора — форма зависимости, насилия. Требования: Информирование. Поддержка выбора. Учёт воли.

3.6. Терапевтическая функция

Еда может быть: □ лечебной (при диабете, дисфагии, почечной недостаточности); □ симптоматической (при кахексии, ожирении); □ ритуальной (при расстройствах пищевого поведения); □ сенсорной (для жителей с сенсорной депривацией). Требования: Врачебная оценка. Индивидуальный план. Мониторинг. Таблица 3.1. Шесть функций питания и индикаторы их выполнения

Функция	Что проверяем	Кто проверяет	Документ
Физиологическая	Калорийность, БЖУ, Витамины	Диетсестра, технолог	Меню-требование, ТК
Безопасность	НАССР, аспирация, аллергия	Технолог, медсестра, врач	Журналы, акты
Удовольствие	Вкус, температура, аппетит	Сами жители, соц. работник	Анкеты, жалобы

Присутствие в столовой, Социальная Соц. работник Наблюдение контакт Автономия Выбор, информирование Соц. работник, психолог Журнал выбора ИППСУ, мед. Терапевтическая Диета, мониторинг Врач документация

Глава 4. Лестница вариативности: семь уровней

Сведение вариативного меню к формуле «два блюда вместо одного» — упрощение, которое выгодно краткосрочно, но проигрывает долгосрочно. Реальный выбор — это семь уровней, и многие жители получают пользу от первого уровня больше, чем от пятого.

Уровень 1. Выбор, что есть в пределах поданного

Функция	Что проверяем	Кто проверяет	Документ
Физиологическая	Калорийность, БЖУ, витамины	Диетсестра, технолог	Меню-требование, ТК
Безопасность	НАССР, аспирация, аллергия	Технолог, медсестра, врач	Журналы, акты
Удовольствие	Вкус, температура, аппетит	Сами жители, соц. работник	Анкеты, жалобы

Социальная	Присутствие в столовой, контакт	Соц. работник	Наблюдение
Автономия	Выбор, информирование	Соц. работник, психолог	Журнал выбора
Терапевтическая	Диета, мониторинг	Врач	ИППСУ, мед. документация

Житель видит перед собой тарелку и решает, есть ли её. Если нет — отказ фиксируется, остаётся пить воду, перекус. Это — самый минимальный уровень. Он доступен всем. Что нужно: Без изменения меню, без дополнительных затрат. Только фиксация отказов и предложение альтернативы (если есть). Кому подходит: Всем жителям, включая неговорящих (отказ тоже регистрируется).

Уровень 2. Выбор между двумя равноценными вариантами

Житель выбирает из двух блюд одного уровня. Например: гречка или рис, говядина или курица, чай или компот. Что нужно: Технологические карты на оба варианта. Параллельное приготовление. Учёт. Согласование с диетсестрой. Кому подходит: Жителям с сохранной когнитивной функцией, способным выразить выбор.

Уровень 3. Выбор количества порции

Житель решает, сколько съесть. Маленькая порция — для тех, у кого снижен аппетит, большая — для тех, кто хочет добавки. Остатки уходят в списание. Что нужно: Стандартные выходы, контроль остатков, гибкая калькуляция. Кому подходит: Жителям с анорексией (после депрессии, при приёме нейрорепараторов), жителям с ожирением (при контроле калорийности), жителям с гиперфагией (при деменции).

Уровень 4. Выбор времени приёма пищи

Житель решает, когда поесть — в 7:00 или в 9:00, в 12:00 или в 14:00. Это — не «отказ от режима», а учёт индивидуального ритма. Что нужно: Гибкий график. Отдельный буфет для отделений. Возможность подогрева. Кому подходит: Жителям с поздним пробуждением (седация), жителям с нарушением циркадного ритма (деменция), жителям с гипогликемией

(диабет — приём пищи через равные интервалы).

Уровень 5. Выбор места приёма пищи

Житель решает, где поесть — в общей столовой, в отделении, в комнате, на улице (в тёплое время). Что нужно: Мобильный сервис. Посуда для подачи в отделение. Помощник. Кому подходит: Жителям с выраженной тревогой, сенсорной перегрузкой, с тяжёлой деменцией, после инсульта, с инфекцией.

Уровень 6. Выбор способа еды и поддержки

Житель решает (или с ним решают), как он ест — самостоятельно, с помощью прибора, с адаптированной посудой, с поддержкой помощника, через зонд. Что нужно: Адаптированные приборы (утяжелённые, с толстой ручкой, нескользящие). Обучение персонала помощи. Согласование с логопедом/врачом. Кому подходит: Жителям с тремором, нарушением координации, гемипарезом, деменцией.

Уровень 7. Участие в планировании, приготовлении, оценке

Житель участвует в работе пищевого совета, в дегустациях, в обсуждении меню, в малых формах — в покупке и приготовлении пищи. Что нужно: Пищевой совет. Протоколы заседаний. Дегустации. Кулинарные мастер-классы (при возможности). Кому подходит: Жителям с сохранной когнитивной функцией, мотивированным к участию. В малых формах проживания — шире. Главный практический тезис

- Вариативное питание — это не максимальное число блюд. Это максимальный реальный выбор, который конкретный человек способен сделать безопасно в пределах ресурсов учреждения.** Это — не норма закона. Это — аналитическая формула доклада, проверенная практикой учреждений, внедривших разные уровни. Таблица 4.1. Сопоставление уровней вариативности с ресурсами

Уровень	Кто реализует	Типичный KPI	Ресурсы
1. Выбор в пределах % отказов, объём 0 руб.	Персонал отделения	поданного	остатков
2. Выбор из двух +5-10% к стоимости	Технолог, диетсестра	вариантов сырья	вариантов
3. Выбор количества 0 руб.	Персонал отделения	Объём остатков	
Гибкий график, доп.	4. Выбор времени	Старшая медсестра	% опоздавших к завтраку
оборудование	% жителей,	Мобильный сервис,	доп.
5. Выбор			

места Соц. работник принимающих пищу в персонал столовой
 Адаптированная посуда, % жителей, способных б. Выбор способа Логопед,
 эрготерапевт обучение есть самостоятельно Пищевой совет, мастер- %
 жителей, участвующих 7. Участие Соц. работник, психолог классы в совете

Уровень	Дополнительны е ресурсы	Кто реализует	Типичный KPI
1. Выбор в пределах поданного	0 руб.	Персонал отделения	% отказов, объём остатков
2. Выбор из двух вариантов	+5-10% к стоимости сырья	Технолог, диетсестра	% использования вариантов
3. Выбор количества	0 руб.	Персонал отделения	Объём остатков
4. Выбор времени	Гибкий график, доп. оборудование	Старшая медсестра	% опоздавших к завтраку
5. Выбор места	Мобильный сервис, доп. персонал	Соц. работник	% жителей, принимающих пищу в столовой
6. Выбор способа	Адаптированная посуда, обучение	Логопед, эрготерапевт	% жителей, способных есть самостоятельно
7. Участие	Пищевой совет, мастер- классы	Соц. работник, психолог	% жителей, участвующих в совете

Глава 5. Десять моделей организации выбора

Модели перечислены от минимальной к развитой. Для каждой даны: кому подходит, что нужно, риски, доказательность.

Модель 1. Единое меню без альтернатив

□ **Кому подходит:** При кадровом дефиците, при отсутствии поддержки учредителя. □ **Что нужно:** Базовое меню, учёт. □ **Риски:** Формальный режим, отказы от еды, потеря веса. □ **Доказательность:** Не улучшает потребление.

Модель 2. Замена при отказе

□ **Кому подходит:** Как первый шаг после единого меню. □ **Что нужно:** Процедура замены (каша → хлеб, суп → кефир). □ **Риски:** Минимальные. □ **Доказательность:** Снижает отказы, не снижает удовлетворённость.

Модель 3. Выбор напитка

□ **Кому подходит:** Всем, как первый видимый шаг. □ **Что нужно:** Несколько напитков на раздаче. □ **Риски:** Минимальные. □ **Доказательность:** Повышает удовлетворённость.

Модель 4. Выбор гарнира

□ **Кому подходит:** При наличии параллельного приготовления. □ **Что нужно:** Два гарнира. □ **Риски:** Дополнительная нагрузка на кухню.

Модель 5. Выбор первого блюда

□ **Кому подходит:** При разнообразии первых блюд. □ **Что нужно:** Два супа. □ **Риски:** Дополнительная нагрузка, остатки.

Модель 6. Выбор основного блюда

□ **Кому подходит:** Как основной видимый шаг. □ **Что нужно:** Два основных блюда. □ **Риски:** Нагрузка на кухню, калькуляция.

Модель 7. Два полноценных варианта обеда

□ ****Кому подходит:**** Учреждения, готовые к системной перестройке. □ ****Что нужно:**** Полный параллельный цикл: 14-дневное меню А и Б. □ ****Риски:**** Значительная нагрузка.

Модель 8. Предварительный заказ на следующий день

□ ****Кому подходит:**** При наличии IT-инфраструктуры. □ ****Что нужно:**** Терминалы, формы, учёт. □ ****Риски:**** Сложность, формальность без контроля.

Модель 9. Выбор непосредственно на раздаче

□ ****Кому подходит:**** При наличии ресурсов на постоянное обновление. □ ****Что нужно:**** Живая очередь, выкладка, помощник. □ ****Риски:**** Ажиотаж, формальность.

Модель 10. Визуальный выбор

□ ****Кому подходит:**** Для неговорящих, для когнитивно нарушенных. □ ****Что нужно:**** Фотографии, карточки, «Talking Mats». □ ****Риски:**** Необходимость обучения, длительность. Дополнительные модели

Модель 11. Буфетные элементы

Салат-бар, нарезка, напитки в свободном доступе. Кому подходит: Для отделений с достаточным штатом. Риски: Контроль количества, перекрёстное загрязнение.

Модель 12. Семейная подача за общим столом (family-style)

Блюда в общей посуде, жители накладывают сами. Кому подходит: Для малых групп, для когнитивно сохранных. Доказательность: Исследования показывают повышение потребления (PubMed). Риски: Гигиена, объём порций.

Модель 13. Finger food

Кусочки, удобные для еды руками. Кому подходит: Для жителей с тремором, деменцией, уставших от ложки. Доказательность: Повышает самостоятельность. Риски: Аспирация при плохом жевании.

Модель 14. Выбор внутри текстурно-модифицированной линии

Пюре из разных овощей, разных мясных блюд. Кому подходит: Для жителей с дисфагией. Доказательность: IDDSI поддерживает разнообразие. Риски: Безопасность.

Модель 15. Индивидуальное меню по медицинским основаниям

Полностью определяется врачом. Кому подходит: Тяжёлые случаи. Это не вариативность в нашем понимании — это диета.

Модель 16. Участие жителей в пищевом совете

Кому подходит: Всем. Что нужно: Положение, протоколы, поддержка. Доказательность: Повышает удовлетворённость. Риски: Формальность без обратной связи.

Модель 17. Участие в покупке и приготовлении (малые формы)

Кому подходит: Сопровождаемое проживание, малые группы. Доказательность: Поддерживает навыки. Риски: Безопасность, гигиена.

Сводная таблица моделей

Стоимость	Модель	Кадры	Доказательность	Подходит для (индекс)
1. Единоe	1,00	Минимум	Низкая	Временный вариант
2. Замена	1,01	Минимум	Средняя	Первый шаг
3. Напиток	1,02	Минимум	Средняя	Видимый шаг
4. Гарнир	1,05 +1	повар	Средняя	Развитие
5. Первое	1,06 +1	повар	Средняя	Развитие
6. Второе	1,08 +1	повар	Высокая	Целевая модель
7. Два обеда	1,15 +2	повара	Высокая	Зрелая модель
8. Предзаказ	1,20	IT	Средняя	IT-готовность
9. На раздаче	1,25	+помощник	Высокая	ресурсов
10. Визуальный	1,10	Обучение	Средняя	Для неговорящих
11. Буфет	1,15 +1	повар	Высокая	Салат-бар
12. Family-style	1,08	Уборка	Высокая	Малые группы
13. Finger food	1,12	Подготовка	Высокая	Деменция, тремор
14. Текстуриный	1,15	Разработка	Высокая	Дисфагия
15. 2,0+	Врач	Высокая	Мед. показания	Индивидуальный

16. Совет 1,01 Координатор Высокая Все 17. Кулинария 1,10 Мастер Средняя Сопровожд.

Модель	Стоимость (индекс)	Кадры	Доказательность	Подходит для
1. Единое	1,00	Минимум	Низкая	Временный вариант
2. Замена	1,01	Минимум	Средняя	Первый шаг
3. Напиток	1,02	Минимум	Средняя	Видимый шаг
4. Гарнир	1,05	+1 повар	Средняя	Развитие
5. Первое	1,06	+1 повар	Средняя	Развитие
6. Второе	1,08	+1 повар	Высокая	Целевая модель
7. Два обеда	1,15	+2 повара	Высокая	Зрелая модель
8. Предзаказ	1,20	IT	Средняя	IT-готовность
9. На раздаче	1,25	+помощник	Высокая	При избытке ресурсов
10. Визуальный	1,10	Обучение	Средняя	Для неговорящих
11. Буфет	1,15	+1 повар	Высокая	Салат-бар
12. Family-style	1,08	Уборка	Высокая	Малые группы
13. Finger food	1,12	Подготовка	Высокая	Деменция, тремор
14. Текстурный выбор	1,15	Разработка	Высокая	Дисфагия
15. Индивидуальный	2,0+	Врач	Высокая	Мед. показания
16. Совет	1,01	Координатор	Высокая	Все
17. Кулинария	1,10	Мастер	Средняя	Сопровожд.

проживание

Иллюстратив
ный расчёт,
не
являющийся
нормативом.

Глава 6. От мономеню к двум равноценным вариантам: что это значит технологически

Два варианта — это не «суп с фрикадельками и суп с клелями». Это два полноценных цикла на 14 дней, обеспечивающих равную калорийность, равный нутриентный состав, равное разнообразие.

6.1. Принципы построения

- ****Равенство по пищевой ценности.**** Калорийность каждого варианта — в пределах 5% от средней. Белки, жиры, углеводы — сбалансированы.
- ****Равенство по разнообразию.**** Одинаковое число видов мяса, рыбы, овощей, фруктов, круп.
- ****Равенство по приёмам пищи.**** Если вариант А — завтрак из каши, то и вариант Б — из каши, не из яичницы.
- ****Равенство по ограничениям.**** Оба варианта должны соответствовать диетам, на которые есть назначения (с поправкой на конкретный вариант).
- ****Взаимозаменяемость.**** Каждый продукт в варианте А имеет аналог в варианте Б (по таблице замен Приложения 11 к СанПиН 2.3/2.4.3590-20).

6.2. Технологические карты

На каждое блюдо варианта А и варианта Б — отдельная ТК. Расчёт: □ рецептура; □ выход;

	проживание
□ калорийность;	
□ БЖУ;	
□ витамины (по возможности);	
□ стоимость.	

6.3. Параллельное приготовление

Кухня должна: □ иметь достаточное количество рабочих мест; □ иметь достаточное количество оборудования (плиты, пароконвектоматы,

фритюрницы); ☐ иметь достаточное количество персонала; ☐ обеспечить товарное соседство; ☐ обеспечить маркировку (А или Б).

6.4. Учёт

На раздаче — фиксация выбора (кто что выбрал). В журнале — количество выданного. На складе — списание. В бухгалтерии — отдельный учёт по вариантам.

6.5. Контроль

Бракераж — на оба варианта. Суточная проба — на оба варианта. Температура на раздаче — на оба варианта.

6.6. Где два варианта не нужны

☐ Когда население < 50 человек — экономически нецелесообразно. ☐ Когда нет параллельного приготовления (одна плита, один повар). ☐ Когда нет финансирования на дополнительный персонал. Таблица 6.1. Чек-лист готовности кухни к двум вариантам

Элемент	Есть	Нет	Что делать
Параллельные рабочие	☐	☐	Оборудовать места
Достаточно плит	☐	☐	Приобрести
Достаточно персонала	☐	☐	Нанять/перераспределить
Технологические карты	☐	☐	Разработать на оба варианта
Маркировка	☐	☐	Внедрить
Учёт	☐	☐	Настроить
Бракераж	☐	☐	Обучить комиссию
Суточная проба	☐	☐	Обучить
Согласование диетсестры	☐	☐	Получить
Согласование с ☐	☐	☐	Получить учредителем

6.7. Где два варианта особенно полезны

☐ Деменция с избирательностью — больше шансов, что житель выберет что-то подходящее. ☐ Шизофрения с бредом отравления — смена позиции иногда снимает бредовую фиксацию. ☐ Аутизм с ригидностью — два варианта позволяют сохранить привычное. ☐ Культурные/религиозные предпочтения — два варианта дают больше опций.

6.8. Где два варианта могут ухудшить ситуацию

☐ Жители с выраженной тревогой — больше выбора = больше тревоги. ☐ Жители с нарушением принятия решений — парализует. ☐ Жители с дисфагией — если оба варианта не текстурно-модифицированы.

Элемент	Есть	Нет	Что делать
Параллельные рабочие места	☐	☐	Оборудовать
Достаточно плит	☐	☐	Приобрести
Достаточно персонала	☐	☐	Нанять/перераспределить
Технологические карты на оба варианта	☐	☐	Разработать
Маркировка	☐	☐	Внедрить
Учёт	☐	☐	Настроить
Бракераж	☐	☐	Обучить комиссию
Суточная проба	☐	☐	Обучить
Согласование диетсестры	☐	☐	Получить
Согласование с учредителем	☐	☐	Получить
Решение: Начинать с минимального уровня, наращивать постепенно,			
мониторить реакцию.			

ЧАСТЬ III. ЛЮДИ

Глава 7. Психические нарушения и пищевое поведение

7.1. Шизофрения: стабилизированная фаза

Что персонал видит. Жители этого профиля могут вести себя внешне упорядоченно, есть самостоятельно, выражать предпочтения. Часть из них годами находится на одном и том же меню и не выражает недовольства, что не означает согласия. Особенности пищевого поведения. □ Многие нейрелептики (особенно атипичные — оланзапин, кветиапин, клозапин) вызывают набор массы тела, повышение аппетита, нарушения липидного и углеводного обмена. □ Снижение мотивации и ангедония (неспособность получать удовольствие) могут снижать аппетит. □ Бредовые идеи (отравление, наблюдение, специальное воздействие на еду) могут возникать при обострении и приводить к отказу. □ Фобия приёма пищи в присутствии других может быть симптомом. Красные флаги. □ Резкий отказ от еды при стабильном ранее поведении. □ Жалобы на «отравление» с признаками параноидной симптоматики. □ Резкий набор или потеря массы тела. □ Появление ритуалов, связанных с едой (тщательное мытьё, проверка, переключивание). Что директор может сделать завтра. □ Обеспечить регулярное взвешивание (не реже 1 раза в месяц). □ Включить в ИППСУ раздел «Пищевое поведение» с указанием рисков и предпочтений. □ Согласовать с врачом-психиатром перечень «продуктов-триггеров» (при наличии бреда). □ Не превращать отказ в дисциплинарный инцидент — это симптом. Что нельзя решать приказом директора. Изменение нейрелептической терапии, назначение диеты по соматическому статусу. Документы. ИППСУ с разделом «Питание»; карта динамики массы тела; журнал наблюдений за пищевым поведением.

7.2. Шизофрения с частыми обострениями

Что персонал видит. Непредсказуемость. Житель может сегодня есть нормально, завтра — отказываться. Может отбирать еду у других (при бреде голода), прятать, выбрасывать. Особенности. □ При обострении — неспособность адекватно оценить ситуацию. □ Возможны кататонические симптомы: ступор, мутизм, отказ от еды без объяснения. □ Возможны

импульсивные действия: выбрасывание еды, агрессия за столом. Что директор может сделать завтра. □ Обеспечить индивидуальное сопровождение во время еды при обострении. □ Зафиксировать в карте типичные проявления обострения конкретного жителя. □ Согласовать с врачом алгоритм действий при отказе от еды в период обострения. Что нельзя. Применять силу, наказывать лишением еды, принудительно кормить без медицинского заключения.

7.3. Тяжёлая умственная отсталость

Что персонал видит. Часть жителей не говорит, не понимает сложных инструкций, не выражает предпочтения вербально. Привычки — стойкие, ригидные. Могут часами сидеть за столом, ожидая «своего» блюда. Особенности. □ Повышенный риск дисфагии (из-за нарушения координации глотания). □ Повышенный риск аспирации. □ Избирательность в еде, особенно при расстройствах аутистического спектра. □ Сниженное чувство насыщения — риск переедания. □ Пикацизм — стремление к поеданию несъедобного. Красные флаги. □ Поперхивание, кашель во время еды. □ Удержание пищи за щекой. □ Повторяющиеся жевательные движения без еды. □ Стремление к поеданию непищевых продуктов. □ Резкое увеличение массы тела. Что директор может сделать завтра. □ Обеспечить текстурно-модифицированное питание по назначению логопеда/врача. □ Обучить персонал распознавать признаки аспирации. □ Исключить доступ к опасным непищевым продуктам. □ Вести пищевой дневник (что ест, сколько, как). □ Использовать визуальные карточки для предложения выбора.

7.4. Деменция

Что персонал видит. Прогрессирующее ухудшение. Житель может «забывать», что уже поел. Может класть еду в рот и не жевать. Может есть несъедобное. Может переедать. Может отказываться от еды, не узнавая её. Особенности по типам. Болезнь Альцгеймера. □ Постепенная потеря навыков: сначала — пользование ножом, потом — вилок, потом — ложкой. □ Забывание о еде. □ Снижение обоняния и вкуса. Сосудистая деменция. □ Ступенчатое ухудшение. □ Высокий риск инсульта во время еды. □ Часто — псевдобульбарный синдром (дисфагия). Деменция с тельцами Леви. □ Выраженные зрительные галлюцинации (в том числе в отношении еды — «вижу червей в каше»). □ Колебания внимания. □ Риск падений при попытке встать из-за стола. Лобно-височная деменция. □

Расторможенность пищевого поведения. □ Переедание, навязчивое поглощение одной и той же пищи. □ Стереотипное жевание. □ Отсутствие чувства сытости. Красные флаги. □ Поперхивание. □ Неузнавание еды. □ Агрессия при попытке кормить. □ Резкое снижение массы тела. □ Отказ от жидкости. □ Застревание пищи. Что директор может сделать завтра. □ Finger food для жителей с утратой навыков. □ Частые маленькие порции (5-6 раз в день). □ Постоянный доступ к воде. □ Адаптированная посуда (с толстой ручкой, контрастного цвета). □ Сопровождение при приёме пищи. □ Консультация логопеда для оценки глотания.

7.5. Расстройства аутистического спектра

Что персонал видит. Жёсткая избирательность, ритуалы, сенсорная перегрузка. Особенности. □ Отказ от незнакомой еды. □ Фиксация на одной и той же пище (например, только белый хлеб). □ Сенсорная перегрузка в шумной столовой. □ Трудности с изменением привычного. Что директор может сделать завтра. □ Предлагать выбор в спокойной обстановке. □ Использовать визуальное расписание питания. □ Избегать резких изменений. □ Исключить сенсорные триггеры (запахи, звуки, свет).

7.6. Сочетанные нарушения

Многие жители имеют 2-3 и более диагнозов. Например: шизофрения + эпилепсия + умственная отсталость + ДЦП + сахарный диабет. Это означает, что одна и та же еда должна одновременно: □ соответствовать диете при диабете; □ быть текстурно-модифицированной при дисфагии; □ исключать провоцирующие факторы при эпилепсии (низкоуглеводная кетогенная диета — только по назначению невролога); □ быть безопасной при взаимодействии с психотропными препаратами; □ учитывать калорийность при наборе массы от нейролептиков. Это — индивидуальная задача, решаемая врачом и диетсестрой. Директор обеспечивает условия.

7.7. Практическая таблица: что видим — что делаем

Вероятная причина	Что сделать	Что видим	Кого привлечь	Что нельзя
Немедленно	Внезапный отказ от	Психоз, депрессия,	Врач-психиатр,	Наблюдение, Наказывать, еды
Соматика	терапевт	ИППСУ, фиксация	принуждать	Психиатр, Нейролептики,
Пересмотр	диеты, Сажать на диету	Набор массы	диетсестра, гиподинамия	активность самостоятельно

эндокринолог Депрессия, Обследование, Потеря массы Врач, логопед
Игнорировать деменция, дисфагия добавки Текстуриная Оставлять без
Поперхивание Дисфагия Логопед, врач модификация изменений Тактика,
фиксация, Обострение Уговаривать, Бред отравления Психиатр
индивидуальный психоза спорить подход Психиатр Торопить, трести
Кратковременные Кататония, Ожидание,

Что видим	Вероятная причина	Кого привлечь	Что сделать не медленно	Что нельзя
Внезапный отказ от еды	Психоз, депрессия, соматика	Врач-психиатр, терапевт	Наблюдение, ИППСУ, фиксация	Наказывать, принуждать
Набор массы	Нейролептики, гиподинамия	Психиатр, диетсестра, эндокринолог	Пересмотр диеты, активность	Сажать на диету самостоятельно
Потеря массы	Депрессия, деменция, дисфагия	Врач, логопед	Обследование, добавки	Игнорировать
Поперхивание	Дисфагия	Логопед, врач	Текстуриная модификация	Оставлять без изменений
Бред отравления	Обострение психоза	Психиатр	Тактика, фиксация, индивидуальный подход	Уговаривать, спорить
Кратковременные	Кататония,	Психиатр	Ожидание,	Торопить, трести
ступоры депрессия безопасная поза				
Деменция, психоз, Психиатр, До зирование,				
Переедание Лишать еды				

лекарства диетсестра маленькие порции
РАС, деменция, Уважение к
Избирательн ость Психолог Насильно менять
привычки пр едпочтениям
Умственная
Безопасная среда,
Пикацизм отсталость, Психиатр Иг норировать
наблюдение
деменция

7.8. Что нельзя решать приказом директора

□ Изменение лекарственной терапии. □ Изменение диеты по соматическому/психическому статусу. □ Принудительное кормление (без судебного решения по ст. 29 Закона о психиатрической помощи). □ Установление диагноза. □ Оценка дееспособности.

7.9. Что директор может решить сам

□ Режим питания (время приёма пищи, последовательность). □ Форму подачи (порционная, family-style, буфет). □ Способ информирования (карточки, устно, письменно). □ Состав пищевого совета. □ График дежурств персонала. □ Маркировку блюд. □ Оформление столовой. □ Атмосферу приёма пищи (без спешки, без шума).

ступоры	депрессия		безопасная поза	
Переедание	Деменция, психоз, лекарства	Психиатр, диетсестра	Дозирование , маленькие порции	Лишать еды
Избирательность	РАС, деменция, привычки	Психолог	Уважение к предпочтениям	Насильно менять
Пикацизм	Умственная отсталость, деменция	Психиатр	Безопасная среда, наблюдение	Игнорировать

Глава 8. Дисфагия, аспирация и текстурно-модифицированное питание

8.1. Что такое дисфагия

Дисфагия — нарушение глотания. Может быть: □ орофарингеальная (трудности на уровне рта и глотки); □ пищеводная (трудности на уровне пищевода); □ нейрогенная (после инсульта, при болезни Паркинсона, деменции); □ механическая (опухоли, стриктуры); □ лекарственная (ксеростомия — сухость во рту — от антихолинергических средств, нейролептиков).

8.2. Кто в группе риска

□ Жители после инсульта (до 50% имеют дисфагию). □ Жители с болезнью Паркинсона (до 80% на поздних стадиях). □ Жители с деменцией (до 45% на поздних стадиях). □ Жители с ДЦП. □ Жители с тяжёлой умственной отсталостью. □ Жители с поздними стадиями бокового амиотрофического склероза (БАС). □ Жители с опухолями головы и шеи. □ Жители, длительно принимающие нейролептики (ксеростомия).

8.3. Признаки дисфагии

□ Поперхивание. □ Кашель во время или сразу после глотания. □ «Влажный» голос после питья. □ Остатки пищи во рту. □ Длительное жевание без проглатывания. □ Слюнотечение. □ Снижение массы тела без видимой причины. □ Рецидивирующие пневмонии. □ Затяжное время приёма пищи. □ Отказ от еды (может быть связан с боязнью подавиться).

8.4. Что должен делать персонал

□ Наблюдать за каждым приёмом пищи жителей группы риска. □ Фиксировать признаки аспирации. □ Немедленно сообщать медсестре и врачу. □ При признаках удушья — экстренная помощь (приём Геймлиха). □ Обеспечивать правильную позу: сидя, спина прямая, голова слегка наклонена вперёд. □ Не торопить. □ Не кормить лёжа. □ Исключить разговоры во время еды. □ Давать жидкость загущённую (по назначению

логопеда).

8.5. Текстульная модификация: уровни

Существует несколько классификаций. Самая распространённая — IDDSI (International Dysphagia Diet Standardisation Initiative), 8 уровней: Уровень Название Описание 0 Жидкая Обычная жидкость 1 Слегка густая Как молоко, слегка гуще воды 2 Умеренно густая Как молочный коктейль 3 Очень густая Можно есть ложкой, не пить 4 Пюре Однородное, без комочков

Уровень	Название	Описание
0	Жидкая	Обычная жидкость
1	Слегка густая	Как молоко, слегка гуще воды
2	Умеренно густая	Как молочный коктейль
3	Очень густая	Можно есть ложкой, не пить
4	Пюре	Однородное, без комочков
5	Мягкая	Можно размять вилкой
6	Мягкая и кусочками	Мягкие кусочки до 1,5 см
7	Обычная	Обычная пища
В РФ IDDSI не является обязательным стандартом, но используется многими учреждениями как ориентир.		
Альтернативная российская практика — стандартные диеты (ОВД, ЩД,		

ВБД, НБД, НКД),
разработанные для
медицинских
организаций.
Применимы к

ДСО с медицинской
лицензией; для
учреждений без
лицензии — как
ориентир.

8.6. Что директор может сделать завтра

☐ Утвердить локальный акт о порядке текстурной модификации. ☐ Обучить персонал распознаванию признаков дисфагии. ☐ Организовать доступ к консультации логопеда (в штате, по договору, через телемедицину). ☐ Обеспечить загустители для жидкостей. ☐ Обеспечить адаптированные приборы. ☐ Внести в ИППСУ каждого жителя группы риска отметку о текстуре и позе.

8.7. Красные флаги

☐ Поперхивание жидкостью. ☐ «Влажный» голос после питья. ☐ Повторные пневмонии. ☐ Потеря массы тела. ☐ Страх еды. ☐ Кашель после каждого глотка.

8.8. Что нельзя решать приказом директора

5	Мягкая	Можно размять вилкой
6	Мягкая и кусочками	Мягкие кусочки до 1,5 см
7	Обычная	Обычная пища
☐ Назначение конкретной текстуры конкретному жителю.		
☐ Перевод на зондовое питание.		

☐ Принудительное
кормление.

8.9. Алгоритм при поперхивании (краткий)

□ Прекратить кормление. □ Дать прокашляться. □ При продолжающемся удушье — приём Геймлиха. □ Вызвать скорую помощь. □ Сообщить врачу. □ Зафиксировать в журнале. □ Провести разбор (комиссия).

Глава 9. Психотропные препараты, аппетит, масса тела и режим питания

Раздел носит общий информационный характер. Конкретные назначения — прерогатива врача.

9.1. Уровни осторожности в формулировках

В этом разделе используются следующие уровни: Уровень Что означает Источник Инструкция к лекарственному Установленное противопоказание Запрет в инструкции к препарату препарату Клинически значимое Изменение концентрации или Клинические рекомендации, взаимодействие эффекта систематические обзоры Описано в литературе, Возможное взаимодействие Научные публикации клиническое значение варьирует

Уровень	Что означает	Источник
Установленное противопоказание	Запрет в инструкции к препарату	Инструкция к лекарственному препарату
Клинически значимое взаимодействие	Изменение концентрации или эффекта	Клинические рекомендации, систематические обзоры
Возможное взаимодействие	Описано в литературе, клиническое значение варьирует	Научные публикации
Рекомендация по стабильности Не взаимодействие, но изменение		

Экспертные рекомендации
потребления потребления влияет на метаболизм
Регулярный контроль
Необходимость мониторинга Клинические рекомендации
лабораторных показателей
Логичное наблюдение, но без
Организационная гипотеза Авторский анализ
подтверждения

9.2. Антипсихотики и масса тела

Установленный факт. Атипичные антипсихотики (оланзапин, кветиапин, рисперидон, клозапин) вызывают набор массы тела у значительной части пациентов (в среднем 2–5 кг за первые 6–10 недель, по разным данным). Что это означает для директора. □ У жителей, получающих эти препараты, повышен риск ожирения, сахарного диабета 2 типа, дислипидемии. □ В ИППСУ должен быть раздел «Мониторинг массы тела» с ежемесячным взвешиванием. □ Диета должна быть согласована с эндокринологом или диетсестрой. Что нельзя решать директору. Самостоятельно менять диету для снижения массы тела без согласования с врачом.

9.3. Клозапин и кофеин

Установленный факт. Кофеин может повышать концентрацию клозапина в крови (по данным ряда исследований, на 20–60% при значительном потреблении). Что это означает для учреждения.

Рекомендация по стабильности потребления	Не взаимодействие, но изменение потребления влияет на метаболизм	Экспертные рекомендации
Необходимость мониторинга	Регулярный контроль лабораторных показателей	Клинические рекомендации
Организационная гипотеза	Логичное наблюдение, но без подтверждения	Авторский анализ
□ Резкие изменения в потреблении кофеина (с кофе на чай, увеличение/уменьшение количества чашек) могут влиять на уровень клозапина. □ Это не запрет кофе. Это — рекомендация стабильности потребления. □ Конкретные рекомендации — у врача-психиатра. Что нельзя. Запрещать кофе без клинического основания; разрешать любое количество без учёта. Документы. ИППСУ с указанием на приём клозапина; в ИППСУ — отметка о необходимости стабильного потребления кофеина.		

9.4. Литий и водно-солевой баланс

Установленный факт. Концентрация лития в крови зависит от водно-солевого баланса. Обезвоживание, бессолевая диета, жаркая погода, диарея, рвота, лихорадка — повышают концентрацию лития и риск интоксикации. Что это означает для учреждения. □ Обеспечить достаточное потребление жидкости. □ Обеспечить обычное потребление соли (не бессолевую диету без показаний). □ Следить за признаками обезвоживания. □ При признаках интоксикации (тремор, тошнота, спутанность) — экстренно информировать врача. Документы. ИППСУ с указанием на приём лития; мониторинг потребления жидкости; журнал.

9.5. Ингибиторы МАО и тирамин

Установленный факт. Классические неселективные ингибиторы МАО (фенелзин, транилципромин) требуют жёсткой диеты с ограничением тирамина: выдержанные сыры, копчёности, ферментированные продукты, красное вино, пиво, бобовые, квашеная капуста, соевый соус, вяленая рыба. Нюанс. Селективные ингибиторы МАО-В (селегилин в форме пластыря, разагилин) не требуют такой жёсткой диеты. Что это означает для учреждения. □ Если житель получает классический ИМАО — необходима тираминовая диета (по назначению врача). □ Если селективный — обычная диета. □ Решение принимает врач.

9.6. Грейпфрут и психотропные препараты

Установленный факт. Грейпфрут (и помело, и севи́льский апельсин) ингибирует CYP3A4 в кишечнике и может повышать концентрацию ряда препаратов (бензодиазепины, некоторые антидепрессанты, атипичные антипсихотики — для конкретных препаратов проверять инструкцию). Нюанс. Не все психотропные взаимодействуют с грейпфрутом. Нужна проверка по конкретному препарату. Что это означает для учреждения. □ Не запрещать грейпфрут «для всех жителей с психиатрическим диагнозом». □ Для конкретного жителя — уточнить у врача. □ Если есть взаимодействие — убрать грейпфрут из рациона конкретного жителя, остальным оставить.

9.7. Антипсихотики и метаболический синдром

Установленный факт. У значительной части пациентов на атипичных антипсихотиках развивается метаболический синдром (ожирение + инсулинорезистентность + дислипидемия + гипертония). Что это означает для учреждения. □ Регулярный мониторинг: масса тела, окружность талии,

АД, глюкоза крови, липидограмма (по назначению врача). □ В ИППСУ — раздел «Мониторинг метаболических показателей». □ Диета — по согласованию с эндокринологом/диетсестрой.

9.8. Седативный эффект и режим питания

Установленный факт. Многие психотропные препараты (бензодиазепины, седативные антидепрессанты, некоторые нейролептики) вызывают сонливость, особенно в первые часы после приёма. Что это означает для учреждения. □ Жители могут пропускать завтрак из-за позднего пробуждения. □ Жители могут засыпать за столом. □ Жители могут есть медленно, с перерывами. Что директор может сделать завтра. □ Предусмотреть «поздний завтрак» для опоздавших. □ Не торопить. □ Обеспечить возможность дремать после еды. □ Исключить оценку «адекватности» по скорости еды.

9.9. Влияние на глотание, слюноотделение, запоры

Установленный факт. Нейролептики (особенно хлорпромазин, клозапин) могут вызывать гиперсаливацию (ночной слюнотечение). Антихолинергические средства — сухость во рту (ксеростомия). Нейролептики и антидепрессанты — запоры. Что это означает для учреждения. □ Обеспечить уход за полостью рта при ксеростомии. □ Обеспечить достаточное потребление жидкости и клетчатки при запорах. □ Обеспечить чистое постельное бельё при гиперсаливации. □ Наблюдение за актом глотания.

9.10. Практическая таблица: препарат — риск — действие

Препарат/группа	Возможный пищевой риск	Действия учреждения
Набор массы, метаболический синдром	Взвешивание ежемесячно	Оланзапин, кветиапин, клозапин
ИППСУ, диета	Стабильное потребление кофеина	Клозапин
Взаимодействие с кофеином	не запрещать	Зависимость от водно-солевого баланса
Достаточная жидкость, соль, Литий	мониторинг ИМАО (классические)	Тираминовый синдром
Специальная диета по назначению	Бензодиазепины	Седация, снижение аппетита
Поздний завтрак, неторопливость	Уход за полостью рта, клетчатка,	Антихолинергические
Ксеростомия, запоры	жидкость	Антипсихотики

Гиперсаливация (ночью) Чистое бельё, гигиена Вальпроаты Набор массы, тошнота Дробное питание, по назначению

9.11. Что нельзя решать приказом директора

□ Изменение лекарственной терапии. □ Отмена препарата. □ Запрет на конкретный продукт «для всех на этом препарате» (без подтверждения взаимодействия для конкретного препарата). □ Назначение диеты.

Препарат/группа	Возможный пищевой риск	Действия учреждения
Оланзапин, кветиапин, клозапин	Набор массы, метаболический синдром	Взвешивание ежемесячно, ИППСУ, диета
Клозапин	Взаимодействие с кофеином	Стабильное потребление кофеина, не запрещать
Литий	Зависимость от водно-солевого баланса	Достаточная жидкость, соль, мониторинг
ИМАО (классические)	Тираминовый синдром	Специальная диета по назначению
Бензодиазепины	Седация, снижение аппетита	Поздний завтрак, неторопливость
Антихолинергические	Ксеростомия, запоры	Уход за полостью рта, клетчатка, жидкость
Антипсихотики	Гиперсаливация (ночью)	Чистое бельё, гигиена
Вальпроаты	Набор массы, тошнота	Дробное питание, по назначению

9.12. Что может директор

□ Обеспечить регулярный мониторинг массы тела. □ Обучить персонал наблюдению. □ Обеспечить наличие в рационе продуктов, необходимых для стабильности потребления (по согласованию с врачом). □ Организовать гибкий режим питания. □ Документировать все наблюдения.

9.13. Главный принцип

Любые решения о взаимодействии конкретного препарата с конкретным продуктом — за врачом. Директор обеспечивает условия для выполнения врачебных назначений и информирует врача о наблюдениях. Глава 10. Сложные ситуации: отказ, переедание, пикацизм, быстрое заглатывание, конфликты за столом

10.1. Отказ от еды

Причины (по группам): Медицинские: ☐ обострение психоза (бред отравления); ☐ депрессия (ангедония, отсутствие аппетита); ☐ кататония; ☐ соматическое заболевание (ОРВИ, обострение гастрита); ☐ побочные эффекты лекарств; ☐ дисфагия (страх подавиться); ☐ деменция (неузнавание еды); ☐ седация (невозможность проснуться к завтраку). Психологические: ☐ стресс; ☐ конфликт с персоналом или другими жителями; ☐ госпитализация в психиатрический стационар в прошлом (ассоциации); ☐ потеря близкого. Социальные: ☐ непривычная еда; ☐ непривычное время; ☐ непривычное место; ☐ отсутствие выбора. Системные: ☐ конец порции; ☐ холодная еда; ☐ невкусно; ☐ еда остыла. Алгоритм действий при отказе от еды: ☐ ****Немедленно (минуты).*** Не уговаривать. Спросить «что случилось?» (если житель может ответить). Зафиксировать отказ. ☐ ****В течение часа.*** Сообщить медсестре. Оценить состояние. ☐ ****В течение дня.*** Если отказ повторяется — осмотр врачом. Исключить соматику. Оценить психический статус. Выяснить причину (если возможно). ☐ ****В течение 2-3 дней.*** Если отказ продолжается — консилиум. Оценить нутритивный статус. Рассмотреть дополнительное питание (сипинговые смеси, пюре, жидкости). ☐ ****В течение недели.*** Если нутритивная недостаточность нарастает — рассмотреть зондовое питание (по решению врачебной комиссии, с учётом воли пациента или его законного представителя). Что нельзя делать. ☐ Принуждать. ☐ Наказывать. ☐ Унижать. ☐ Кормить насильно без медицинского основания. ☐ Квалифицировать отказ как «отказ от лечения» без клинической оценки. Документы. Журнал отказов; запись в ИППСУ; протокол осмотра врача.

10.2. Переедание, ночное питание, гиперфагия

Причины. ☐ Деменция (отсутствие чувства сытости). ☐ Побочные эффекты нейрорептиков. ☐ Психогенная гиперфагия (при тревоге). ☐ Привычка. Что делать. ☐ Дробное питание (маленькие порции 5-6 раз в день). ☐ Убрать свободный доступ к высококалорийным продуктам. ☐ Заменить «еду от скуки» на активность. ☐ Исключить еду как способ успокоения (заменить

другими формами). Что нельзя. □ Лишать еды. □ Запирать холодильник без клинического основания.

10.3. Пикацизм

Определение. Поедание несъедобных веществ: мел, земля, песок, бумага, металлические предметы, глина, краска, пластик, фекалии. Кто в группе риска. □ Жители с тяжёлой умственной отсталостью. □ Жители с деменцией. □ Жители с РАС. □ Жители с железодефицитной анемией (редко). Что делать. □ Исключить доступ к опасным несъедобным веществам. □ Обеспечить постоянное наблюдение. □ Обучить персонал. □ Проверить уровень железа, цинка (по назначению врача). □ Рассмотреть поведенческую терапию. Документы. ИППСУ с указанием риска; журнал наблюдений; акты инвентаризации опасных веществ.

10.4. Быстрое заглатывание пищи

Причины. □ Поведенческие расстройства (гиперактивность, импульсивность). □ Деменция (нарушение контроля). □ Конкуренция за еду (привычка «недоедания»). □ Бредовые переживания (страх, что еду отберут). Что делать. □ Маленькие порции. □ Подача по одной ложке. □ Исключить отвлекающие факторы. □ Сопровождение. □ Finger food (еда руками) для снижения скорости. Что нельзя. □ Оставлять без наблюдения. □ Позволять «запихивать» еду.

10.5. Удержание пищи за щекой

Причины. □ Дисфагия. □ Поведенческие привычки. □ Бредовые переживания («спрятать»). Что делать. □ Проверить полость рта после еды. □ Текстульная модификация. □ Обучение персонала.

10.6. Конфликты за столом

Причины. □ Конкуренция за еду (при ограниченных порциях). □ Бредовые переживания. □ Поведенческие расстройства. □ Бытовая агрессия. Что делать. □ Рассадка с учётом совместимости. □ Достаточные порции. □ Сопровождение. □ Правила поведения за столом (объяснённые, а не просто «нельзя»).

10.7. Кража еды

Причины. □ Гиперфагия. □ Бред. □ Привычка. □ Когнитивные нарушения. Что делать. □ Хранение еды в недоступном месте. □ Достаточные порции. □ Поведенческая терапия. □ Не унижать жителя.

10.8. Использование еды как успокоения

Проблема. Персонал может использовать еду (особенно сладкое) для «успокоения» возбуждённого жителя. Это — подкрепление нежелательного поведения. Что делать. □ Обучить персонал альтернативным способам успокоения. □ Обсудить с психологом. □ Не запрещать сладкое вообще, но не использовать как инструмент управления.

10.9. Позднее пробуждение из-за седации

Что делать. □ «Поздний завтрак» до 11:00. □ Гибкий график. □ Индивидуальный подход. □ В карте — указание на приём седативных препаратов.

10.10. Пропуск завтрака

Причины. □ Седация. □ Депрессия. □ Психоз. □ Сон. Что делать. □ Гибкий график. □ Поздний завтрак. □ Документирование.

10.11. Потребность в адаптированных приборах

Кому нужны. □ Жителям с тремором (утяжелённые, с толстой ручкой). □ Жителям с гемипарезом (адаптированные для одной руки). □ Жителям с артритом (с мягкой ручкой). □ Жителям с нарушением координации (с фиксацией). Что делать. □ Закупить набор адаптированных приборов. □ Обучить персонал. □ Подобрать индивидуально.

10.12. Индивидуальные религиозные и культурные предпочтения

Кто. □ Мусульмане (халяль, пост Рамадан). □ Иудеи (кошер, посты). □ Православные (посты, вегетарианские дни). □ Буддисты (вегетарианство). □ Другие конфессии и традиции. Что делать. □ Выяснить при поступлении. □ Зафиксировать в ИППСУ. □ Учесть в меню. □ Пост — не обязательно соблюдать, если есть медицинские противопоказания (решение врача).

10.13. Сводная таблица: ситуация — действие — кто решает

Ситуация Действие Кто решает Отказ от еды Журнал, осмотр, диетолог Врач
Переедание Дробное питание, активность Психиатр + диетсестра
Пикацизм Безопасная среда Врач + персонал Маленькие порции, Быстрое заглатывание Персонал сопровождение Конфликт за столом Рассадка, правила Соц. работник + психолог

Ситуация	Действие	Кто решает
Отказ от еды	Журнал, осмотр, диетолог	Врач
Переедание	Дробное питание, активность	Психиатр + диетсестра
Пикацизм	Безопасная среда	Врач + персонал
Быстрое заглатывание	Маленькие порции, сопровождение	Персонал
Конфликт за столом	Рассадка, правила	Соц. работник + психолог
Кража еды Хранение, поведенческая терапия		Психолог
Использование еды как		
Обучение персонала		Психолог + старшая медсестра
успокоения		
Позднее пробуждение		
Поздний завтрак		Старшая медсестра
Потребность в адаптации	Подбор	Эрготерапевт / логопед
Религиозные предпочтения	Учёт в меню	Диетсестра + соц. работник

Глава 11. Как предложить выбор человеку, который не говорит

11.1. Кто не говорит

□ Жители после инсульта с афазией. □ Жители с тяжёлой умственной отсталостью. □ Жители с РАС. □ Жители с поздней деменцией. □ Жители с избирательным мутизмом. □ Жители в остром психозе (мутизм). □ Жители после тяжёлой ЧМТ.

11.2. Формы предложения выбора

11.2.1. Простая устная формулировка Подходит, если житель понимает речь, но не говорит (афазия, мутизм). Примеры: □ «Чай или компот?» □ «Суп или каша?» □ «Картошка или гречка?»

Кража еды	Хранение, поведенческая терапия	Психолог
Использование еды как успокоения	Обучение персонала	Психолог + старшая медсестра
Позднее пробуждение	Поздний завтрак	Старшая медсестра
Потребность в адаптации	Подбор	Эрготерапевт / логопед
Религиозные предпочтения	Учёт в меню	Диетсестра + соц. работник
□ Да/нет: «Хотите суп? Кивните. Не хотите? Покачайте головой.»		
11.2.2. Выбор из двух, а не из многих		
Два варианта — оптимально для когнитивно нарушенных.		

Не предлагать 5 блюд — вызовет тревогу и отказ.

11.2.3. Фотографии реальных блюд учреждения

☐ Снимать на телефон при готовке.

☐ Распечатывать на цветном принтере.

☐ Ламинировать.

☐ Обновлять при смене меню.

Не использовать. Стоковые фотографии из интернета — они обманчивы.

11.2.4. Показ порций

☐ Показать реальную тарелку с супом.

☐ Показать реальную тарелку с кашей.

☐ Спросить «это?».

11.2.5. Пробная ложка

☐ Предложить попробовать.

☐ Посмотреть на реакцию.

Когда нельзя. При подозрении на аспирацию, при аллергии с неизвестным статусом.

11.2.6. Жесты

☐ Кивок = да.

☐ Покачивание головой
= нет.

☐ Поднятие руки = хочу.

☐ Отвод взгляда = не
хочу.

11.2.7. Взгляд

☐ Проследить, куда
смотрит житель.

☐ При деменции —
обращать внимание на
направление взгляда.

11.2.8. Указание рукой

☐ Помочь направить
руку.

☐ Поднести руку к
тарелке.

11.2.9. Коммуникативные карточки

☐ Фотографии или
пиктограммы.

☐ Лэмпорт, PECS, GoTalk.

☐ Ламинированные
карточки.

11.2.10. Последовательное предъявление

☐ Показать первое
блюдо.

☐ Подождать 30 секунд.

☐ Показать второе.

☐ Зафиксировать
реакцию.

11.2.11.
Дополнительное время

☐ Не торопить.

☐ Дать время на решение.

11.2.12. Повторное предложение

☐ Если отказался — предложить через 10–15 минут.

☐ Не настаивать.

11.2.13. Наблюдение за фактическим потреблением

☐ Что житель ест охотно?

☐ Что оставляет?

☐ Ведение пищевого дневника.

11.2.14. Сведения от родственников и прежних сопровождающих

☐ Анкета при поступлении.

☐ Беседа с родственниками.

☐ Информация от прежних сопровождающих (при переводе из другого

учреждения).

11.2.15. Пищевая биография

☐ Любимые блюда в детстве.

□ Привычки, связанные с едой.

□ Религиозные и культурные предпочтения.

□ Аллергии и непереносимости (даже субъективные).

11.2.16. Стабильные предпочтения и ситуативный выбор

□ Стабильные — отражают личность (например, «не ест рыбу с детства»).

□ Ситуативные — зависят от настроения, состояния, дня.

11.3. Матрица «Способность — форма — поддержка — фиксация — риск

подмены» Форма Способность Поддержка Фиксация Риск подмены
Проверка предложения Дееспособный, Подпись Устно Без Журнал выбора
Минимальный говорит жителя Дееспособный, Журнал с Высокий Карточки
+ Перепроверка не говорит Помощник фиксацией от (можно устно
реакцией (афазия) персонала подменить) Ограниченно Карточки +
Помощник + Согласование с Журнал Средний дееспособный устно опекун
опекуном Помощник Высокий Недееспособны Фото + пробная Журнал
Сопоставление

Способность	Форма предложения	Поддержка	Фиксация	Риск подмены	Проверка
Дееспособный, говорит	Устно	Без	Журнал выбора	Минимальный	Подпись жителя

Дееспособный, не говорит (афазия)	Карточки + устно	Помощник	Журнал с фиксацией от персонала	Высокий (можно поделить)	Перепроверка реакцией
Ограниченно дееспособный	Карточки + устно	Помощник + опекун	Журнал	Средний	Согласование с опекуном
Недееспособны	Фото + пробная	Помощник	Журнал	Высокий	Сопоставление
й, реагирует ложка на блюдений с потреблением					
Родственники,					
Наблюдение,					
Тяжёлая прежнее					
пищевая Помощник Журнал Высокий					
деменция сопровождающ					
биография					
ие					
Тяжёлая					
Карточки, Сопоставление					

умственн
ая Постоя
нная
Журнал
Высокий

повторен
ие с
реакцией

отсталост
ь

11.4. Способы проверки реальности выбора

□ ****Перепроверка реакцией.**** Предложить ещё раз через 15 минут — реакция должна быть похожей. □ ****Сопоставление с фактическим потреблением.**** Если житель «выбрал» суп, но не ест его — выбор не настоящий. □ ****Независимый наблюдатель.**** Соц. работник, не участвующий в кормлении, наблюдает. □ ****Сопоставление с пищевой биографией.**** Если житель всю жизнь не ел рыбу, а сегодня «выбрал» рыбу — вероятно, подмена. □ ****Родственники.**** Спросить, похоже ли это на их близкого. □ ****Аудит.**** Выборочная проверка записей (не менее 10% жителей в месяц).

11.5. Когда участие опекуна необходимо

Прямая норма. В ГК РФ и ФЗ-48 нет нормы, обязывающей опекуна давать согласие на повседневный бытовой выбор, в том числе на выбор еды. Практически участие опекуна необходимо: □ если житель не может выразить выбор (тяжёлая деменция, глубокая умственная отсталость); □ если требуется отказ от диеты (по медицинским показаниям);

й, реаги рует	ложка	наблюда ний	с потреб лением
Тяжёлая деменция	Наблюден ие, пищевая биографи я	Помощни к	Журнал
		Высокий	Родственн ики, прежние сопровожд ающ ие

Тяжёлая у мственная отсталость	Карточки, повторение	Постоянная	Журнал	Высокий	Сопоставление с реакцией
□ если требуется согласие на дорогостоящую диету (например, кетогенная);					
□ если есть спор между жителем и медицинской службой.					
Что нельзя.					
□ Требовать согласие опекуна на каждый приём пищи.					
□ Передавать опекуну всю полноту решения (это подмена воли).					

11.6. Когда учреждение одновременно опекун и организатор питания

Это типичная ситуация. Конфликт интересов реальный. Меры предотвращения: □ Разделение функций (один сотрудник — опекун, другой — диетсестра, третий — кухня). □ Пищевой совет с участием родственников и общественности. □ Внешний аудит. □ Прозрачность. □ Жалобы.

11.7. Поддержка или манипуляция

Поддержка: □ помощь в выражении воли; □ предоставление информации; □ время на решение; □ уважение к отказу. Манипуляция: □ навязывание «лучшего» варианта; □ использование еды как наказания/поощрения; □ подмена выбора («выбрал, что осталось»); □ заполнение журнала за жителя. Как разграничить. Поддержка — в интересах жителя. Манипуляция — в интересах персонала или учреждения.

11.8. Действия при выборе, который может причинить вред

Примеры: □ Житель с тяжёлой дисфагией «выбирает» твёрдую пищу. □ Житель с аллергией «выбирает» аллерген. □ Житель с диабетом «выбирает» сладкое. Алгоритм: □ Информировать жителя о риске (в доступной форме). □ Зафиксировать информированный отказ (если житель дееспособен). □ Предложить альтернативу. □ При угрозе жизни — врачебная комиссия, информирование опекуна, документирование. □ Не запрещать без клинического основания.

11.9. Главный тезис

Выбор — это не лозунг и не формальная процедура. Это ежедневная практика, требующая терпения, обучения персонала и постоянной проверки реальности.

ЧАСТЬ IV. ПРАВО

Глава 12. Дееспособность, опека и повседневный выбор

12.1. Различение понятий

В российском праве и в практике ДСО используются несколько разных понятий, которые часто путают: Понятие Определение Где определяется
Способность иметь права и Правоспособность обязанности (с рождения до Ст. 17 ГК РФ смерти)
Способность своими действиями Дееспособность приобретать и осуществлять Ст. 21 ГК РФ права, создавать обязанности
Признание судом лица неспособным понимать значение Недееспособность Ст. 29 ГК РФ своих действий вследствие психического расстройства
Признание судом лица неспособным понимать значение своих действий вследствие Ограниченная дееспособность Ст. 30 ГК РФ злоупотребления алкоголем/наркотиками или пристрастия к азартным играм
Фактическая возможность в Способность к конкретному Не определяется в законе, конкретный момент понять и бытовому действию оценивается врачом/психологом выразить решение
Главное разграничение. Юридическая дееспособность ≠ фактическая способность к конкретному бытовому решению. Человек, признанный недееспособным, может в конкретный момент понимать, что хочет есть кашу, а не суп.

Понятие	Определение	Где определяется
Правоспособность	Способность иметь права и обязанности (с рождения до смерти)	Ст. 17 ГК РФ
Дееспособность	Способность своими действиями приобретать и осуществлять права, создавать обязанности	Ст. 21 ГК РФ
Недееспособность	Признание судом лица неспособным понимать значение своих действий вследствие психического расстройства	Ст. 29 ГК РФ

Ограниченная дееспособность	Признание судом лица неспособным понимать значение своих действий вследствие злоупотребления алкоголем/наркотиками или пристрастия к азартным играм	Ст. 30 ГК РФ
Способность к конкретному бытовому действию	Фактическая возможность в конкретный момент понять и выразить решение	Не определяется в законе, оценивается врачом/психологом

12.2. Что требует ГК РФ и ФЗ-48

Ст. 29 ГК РФ. Гражданин, который вследствие психического расстройства не может понимать значения своих действий или руководить ими, может быть признан судом недееспособным. Над ним устанавливается опека. От имени подопечного сделки совершает опекун, кроме мелких бытовых. Ст. 36 ГК РФ. Опекун и попечитель обязаны заботиться о содержании подопечного, обеспечении его ухода и лечения, защите его прав и интересов. Опекун не вправе причинять вред здоровью и развитию подопечного. Распоряжение имуществом подопечного — только в его интересах. Ст. 37 ГК РФ. Распоряжение имуществом подопечного — с разрешения органа опеки. Доходы подопечного (включая пенсию) расходуются в интересах подопечного. Ст. 2 ФЗ-48. Деятельность по опеке и попечительству осуществляется в интересах подопечного. Ст. 7 ФЗ-48. Договор об опеке. Ст. 10 ФЗ-48. Права и обязанности опекуна. Ст. 15 ФЗ-48. Отчёт опекуна — ежегодно. Ст. 17 ФЗ-48. Контроль органа опеки.

12.3. Что такое «мелкая бытовая сделка»

В ГК РФ термин «мелкая бытовая сделка» используется в контексте малолетних (ст. 28) и несовершеннолетних (ст. 26). Для недееспособных прямое определение отсутствует. Аналитический вывод. Выбор блюда в учреждении не является сделкой. Это — повседневное бытовое решение, относительно которого: ☐ подопечный вправе выражать своё мнение; ☐ опекун обязан учитывать мнение подопечного; ☐ учреждение обязано обеспечить условия для выражения мнения. Прямого запрета на любое участие опекуна в бытовом выборе в ГК РФ и ФЗ-48 нет. Прямой

обязанности опекуна согласовывать каждый бытовой выбор — тоже нет. Это — аналитический вывод системного толкования, требующий проверки применительно к конкретному субъекту РФ.

12.4. Практика учреждений-опекунов

Если ДСО является опекуном недееспособных жителей (что типично для ПНИ/ДСО): Обязанности учреждения:

- Ежегодно подавать отчёт опекуна в орган опеки (ст. 15 ФЗ-48).
- Учитывать мнение подопечного при принятии решений (ст. 36 ГК РФ).
- Обеспечивать сохранность имущества подопечного.
- Расходовать средства подопечного в его интересах (питание, одежда, лечение, уход).

Что включает отчёт:

- Состав имущества подопечного.
- Доходы и расходы.
- Состояние здоровья, условия проживания.
- Меры по защите прав.

12.5. Конфликт интересов

Если учреждение одновременно:

- опекун (распоряжается пенсией подопечного);
- организатор питания (получает субсидию на питание из бюджета);
- получатель платы за социальные услуги;

возникает конфликт интересов. Замечание общего порядка № 1 (2014) Комитета по правам инвалидов к ст. 12 КПРИ требует «введения механизмов предотвращения и урегулирования конфликтов интересов». Меры предотвращения:

- Разделение функций.
- Прозрачность расходов.
- Пищевой совет с участием родственников.
- Внешний аудит.
- Информирование родственников.
- Возможность жалобы.

12.6. Требуется ли согласие опекуна на повседневный выбор блюда

Прямая норма отсутствует. ГК РФ и ФЗ-48 не устанавливают обязанность опекуна согласовывать каждый бытовой выбор подопечного. Аналитический вывод. Согласие опекуна требуется, если:

- житель не может выразить выбор (тяжёлая деменция, глубокая умственная отсталость, отсутствие коммуникации);
- требуется отказ от медицинской диеты;
- требуется дорогостоящая диета (кетогенная, специальные смеси);
- есть спор между жителем и медицинской службой;
- житель признан недееспособным и не выражает волю.

Не требуется. Согласие опекуна не требуется на:

- повседневный выбор из нескольких вариантов меню;
- выбор напитка, гарнира, десерта;
- подачу в индивидуальной

посуде; □ finger food; □ другие мелкие бытовые вопросы.

12.7. Учёт мнения подопечного

Ст. 36 ГК РФ: «Опекун и попечитель обязаны совершать действия в интересах подопечного в соответствии с законом, в том числе с учётом его мнения». Практически это означает: □ У каждого жителя должна быть возможность выразить предпочтение. □ Предпочтение фиксируется (любым доступным способом). □ При принятии решений о питании мнение учитывается. □ При конфликте мнения подопечного и медицинского назначения — врачебный консилиум.

12.8. Действия при выборе, противоречащем медицинскому назначению

□ ****Врачебная оценка.**** Действительно ли выбор противоречит назначению. □ ****Разъяснение жителю (в доступной форме).**** «Вам не рекомендуется сладкое из-за диабета». □ ****Предложение альтернативы.**** «Вместо сладкого — фрукт». □ ****Фиксация информированного отказа (если житель дееспособен).**** В медицинской документации. □ ****При систематическом нарушении с ухудшением здоровья — консилиум.**** Включая решение о зондовом питании (по показаниям) или о согласовании с опекуном. □ ****Документирование.****

12.9. Принудительное кормление

Что говорит закон. Ст. 29 Закона о психиатрической помощи (Закон РФ 3185-1). Принудительные меры медицинского характера применяются по решению суда в отношении лиц, совершивших общественно опасные деяния. Ст. 4 ФЗ-323 (Об основах охраны здоровья). Основными принципами являются добровольность, приоритет интересов пациента, недопустимость отказа в медицинской помощи. Ст. 20 ФЗ-323. Необходимым предварительным условием медицинского вмешательства является информированное добровольное согласие гражданина. В отношении недееспособного — согласие законного представителя. Аналитический вывод. □ Принудительное кормление через зонд по решению суда (в рамках ст. 29 Закона о психиатрической помощи) — для лиц, совершивших общественно опасные деяния, в условиях психиатрического стационара. Не применяется в ДСО. □ Принудительное кормление по жизненным показаниям (без судебного решения) —

допустимо только в экстренной ситуации, угрожающей жизни. Это не «принудительное кормление» в бытовом смысле, а экстренная медицинская помощь (ст. 11 ФЗ-323, неотложная помощь). □ Принуждение жителя ДСО принимать пищу «для его же блага» без судебного решения и без медицинских показаний — ****недопустимо****. Что делать при систематическом отказе от еды с признаками нутритивной недостаточности: □ Врачебная оценка (причины). □ Психотерапевтическая работа. □ Коррекция диеты (более привлекательная, частая, вкусная). □ Дополнительное питание (сипинговые смеси). □ При отсутствии эффекта — рассмотрение вопроса о зондовом питании (с решением врачебной комиссии, с участием опекуна, с фиксацией воли жителя).

12.10. Алгоритм действий при отказе от еды (юридическая часть)

Действие	Срок	Кто делает	Документ
Фиксация отказа	Немедленно	Персонал	Журнал
Немедленно		Персонал	Журнал
В течение часа		Персонал	Журнал
Запись в мед. Осмотр врачом	В течение дня	Врач документации	Консилиум
(при Врач + диетсестра +	В течение 2-3 дней	Протокол продолжении	отказа)
психолог	Согласование с опекуном	В течение 2-3 дней	Соц. работник
Запись в журнале (при недееспособности)	Рассмотрение вопроса о	В течение недели	Врачебная комиссия
Протокол ВК зондовом питании	Обращение в орган опеки	По ситуации	Соц. работник
Письмо (при недееспособности)			

12.11. Что директор не вправе решать сам

□ Признание лица недееспособным — суд. □ Установление опеки — суд, орган опеки. □ Изменение объёма дееспособности — суд. □ Принудительное кормление по решению суда в рамках ст. 29 Закона о психиатрической помощи — суд. □ Медицинские вмешательства без согласия (по ст. 20 ФЗ-323) — только в случаях, прямо предусмотренных законом.

12.12. Что директор вправе решать

Действие	Срок	Кто делает	Документ
Фиксация отказа	Немедленно	Персонал	Журнал

Сообщение медсестре	В течение часа	Персонал	Журнал
Осмотр врачом	В течение дня	Врач	Запись в мед. документации
Консилиум (при продолжении отказа)	В течение 2-3 дней	Врач + диетсестра + психолог	Протокол
Согласование с опекуном (при недееспособности)	В течение 2-3 дней	Соц. работник	Запись в журнале
Рассмотрение вопроса о зондовом питании	В течение недели	Врачебная комиссия	Протокол ВК
Обращение в орган опеки (при недееспособности)	По ситуации	Соц. работник	Письмо
□ Режим питания.			
□ Форму подачи.			
□ Состав меню (в пределах норм).			
□ Пищевой совет.			
□ Способ информирования.			
□ Адаптацию посуды.			
□ Поведение персонала.			
□ Локальные акты о питании.			

12.13. Главный тезис

Выбор блюда — повседневное бытовое решение, в котором воля подопечного имеет приоритет. Учреждение-опекун обязано содействовать реализации этой воли, а не подменять её. Конфликт интересов учреждения-опекуна — системный риск, требующий внутреннего регулирования.

Глава 13. Что требует российское право: карта решений, а не перечень актов

13.1. Принцип: различение обязательной нормы, рекомендации и

аналитического вывода В этом разделе используются следующие маркировки: □ ****НПА**** — обязательная норма (нормативный правовой акт, действующий на дату проверки). □ ****РЕК**** — рекомендация (методические рекомендации, стандарты профессиональных организаций). □ ****АНА**** — аналитический вывод автора (системное толкование, требующее проверки). □ ****ОПЫТ**** — подтверждённая практика учреждений.

13.2. Конституция РФ

Ст. 7. Россия как социальное государство. Ст. 21. Достоинство личности. Ст. 22. Право на свободу и личную неприкосновенность. Ст. 39. Право на социальное обеспечение. Ст. 41. Право на охрану здоровья и медицинскую помощь. Применимость к ДСО/ПНИ. Прямая. Что делает директор. Обеспечивает условия для реализации этих прав. Не требует специального локального акта, но требует их учёта во всех принимаемых решениях.

13.3. ФЗ-442 «Об основах социального обслуживания граждан в РФ»

Ст. 1. Предмет регулирования. Ст. 4. Принципы социального обслуживания (приближённость, конфиденциальность, индивидуальный подход). Ст. 8. Полномочия органов (п. 5, 6 — утверждение рекомендуемых норм питания). Ст. 16. ИППСУ. Ст. 19. Стационарная форма. Ст. 20. Виды

социальных услуг. Ст. 21. Права получателей. Ст. 22. Социальное сопровождение. Ст. 31, 32. Плата за социальные услуги. Применимость. Прямая. Что требует право от директора. □ Обеспечить оказание услуг в соответствии с ИППСУ. □ Соблюдать натуральные нормы (рекомендуемые — Приказ Минтруда 520н; региональные). □ Обеспечить индивидуальный подход. □ Обеспечить конфиденциальность. Что остаётся на усмотрение учреждения. □ Конкретные формы организации питания. □ Режим дня. □ Способ подачи. Что требует согласования с учредителем. □ Изменение государственного задания. □ Введение дополнительных вариантов меню (если требует дополнительного финансирования). Что нельзя решить приказом директора. □ Изменение натуральных норм (требуется региональный НПА). □ Установление платы за услуги (только учредитель).

13.4. Закон РФ 3185-1 «О психиатрической помощи»

Ст. 5. Уважение прав и законных интересов лица, страдающего психическим расстройством. Ст. 10. Виды психиатрической помощи. Ст. 16. Добровольность обращения. Ст. 23, 24, 25, 26. Условия оказания помощи. Ст. 29. Принудительные меры медицинского характера (только по решению суда). Ст. 36. Права лиц, страдающих психическими расстройствами. Применимость к ДСО/ПНИ. Прямая в части ст. 5 и 36. Остальные статьи — для медицинских организаций. Что требует право от директора. □ Уважение прав жителей. □ Обеспечение информирования. □ Обеспечение права на отказ от медицинского вмешательства (в части, относящейся к социальной помощи). Что нельзя решить приказом директора. □ Применение принудительных мер (только суд). □ Изменение правового режима оказания психиатрической помощи.

13.5. Гражданский кодекс РФ

Ст. 21. Дееспособность. Ст. 29. Недееспособность. Ст. 30. Ограниченная дееспособность. Ст. 36. Обязанности опекуна. Ст. 37. Распоряжение имуществом подопечного. Ст. 53.1. Ответственность лица, уполномоченного выступать от имени юридического лица. Применимость. Прямая. Что требует право от директора. □ Учёт мнения подопечного при принятии решений. □ Сохранность имущества подопечного. □ Расходование средств подопечного в его интересах. □ Добросовестность и разумность.

13.6. ФЗ-48 «Об опеке и попечительстве»

Ст. 2, 3, 7, 10, 11, 15, 17. Применимость. Прямая (если учреждение — опекун). Что требует право. □ Ежегодный отчёт опекуна. □ Учёт мнения подопечного. □ Расходование средств в интересах подопечного. □ Контроль органа опеки.

13.7. ФЗ-323 «Об основах охраны здоровья граждан в РФ»

Ст. 2. Основные понятия (медицинская помощь, медицинская услуга, медицинское вмешательство). Ст. 4. Принципы охраны здоровья. Ст. 10. Доступность медицинской помощи. Ст. 11. Недопустимость отказа в медицинской помощи. Ст. 13. Врачебная тайна. Ст. 14. Полномочия федеральных органов. Ст. 16. Полномочия органов субъектов. Ст. 18. Право на охрану здоровья. Ст. 19. Право на медицинскую помощь. Ст. 20. Информированное добровольное согласие. Ст. 54. Права несовершеннолетних. Ст. 78. Медицинские организации. Применимость к ДСО. □ Если ДСО оказывает медицинские услуги (имеет лицензию) — прямая. □ Если не оказывает — взаимодействие с медицинскими организациями. Что требует право от директора ДСО без лицензии: □ Взаимодействие с территориальной медицинской организацией. □ Содействие в получении медицинской помощи жителями. □ Соблюдение врачебной тайны (сведений о диагнозах). Что нельзя решить приказом директора. □ Назначение лекарств. □ Назначение диеты. □ Медицинские вмешательства.

13.8. ФЗ-52 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»

Ст. 17. Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания. Применимость. Прямая. Что требует. □ Соблюдение санитарных правил. □ Производственный контроль. □ Безопасность пищевой продукции.

13.9. Санитарные правила и нормы (СанПиН 2.3/2.4.3590-20)

Постановление Главного гос. санврача РФ от 27.10.2020 № 32 (в ред. от 22.08.2024). П. 7.1.11. В организациях стационарного социального

обслуживания должно быть организовано питание не менее 3 раз в день, в том числе диетическое (лечебное) питание по медицинским показаниям. П. 7.1.12. При использовании готовых блюд — выделение помещения для приёма и отбора суточных проб. П. 7.1.13. При нарушении технологии приготовления блюдо к выдаче не допускается. П. 8.1.2. Меню должно утверждаться руководителем организации; при аутсорсинге — руководителем исполнителя и согласовываться с руководителем организации. П. 8.1.4. Меню разрабатывается на период не менее двух недель. Применимость. Прямая. Что требует. □ 3-разовое питание (минимум). □ Диетическое питание по показаниям. □ Утверждение меню руководителем. □ Согласование при аутсорсинге. □ 2-недельный цикл. □ Отбор суточной пробы. □ НАССР.

13.10. ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции»

Ст. 17. Требования к процессам производства, хранения, перевозки. Применимость. Прямая. Что требует. □ Соблюдение товарного соседства. □ Контроль температурного режима. □ Контроль сроков годности. □ Маркировка.

13.11. Приказ Минтруда 520н от 13.09.2022

Рекомендуемые нормы питания при предоставлении социальных услуг в стационарной форме. Применимость. Прямая. Нормы рекомендуемые, но используются как ориентир. Что требует. Соблюдение натуральных норм в граммах (хлеб, крупы, мясо, рыба, молочные продукты, овощи, фрукты и т.д.).

13.12. Региональные нормы

В каждом субъекте РФ — свой нормативный акт о нормах питания (см. главу 22). Региональные нормы — обязательны на территории субъекта.

13.13. Бюджетный кодекс РФ

Ст. 69.1, 69.2. Государственное (муниципальное) задание. Ст. 70. Нормативные затраты. Ст. 78.1, 78.3. Субсидии бюджетным и автономным учреждениям. Ст. 161. Особенности правового положения казённых, бюджетных, автономных учреждений. Ст. 162. Бюджетные полномочия получателя бюджетных средств. Применимость. Прямая. Что требует.

Соблюдение государственного задания; целевое использование субсидий.

13.14. ФЗ-44 «О контрактной системе»

Ст. 93, 95, 105, 109. Применимость. Прямая. Что требует. Закупка по ФЗ-44; обоснование НМЦК; конкурентные процедуры; приёмка; изменение контракта.

13.15. ФЗ-402 «О бухгалтерском учёте»

Ст. 9, 11. Применимость. Прямая. Что требует. Обязательные реквизиты первичных документов; достоверность; инвентаризация. Внимание. Приказ Минфина 52н от 30.03.2015 (формы первичных документов) — действующий, но государственный сектор переходит на электронные унифицированные формы (Приказ Минфина от 30.03.2023 № 47н; иные акты). На 22.07.2026 точные сроки и формы требуют уточнения. ОЛ.

13.16. ФЗ-152 «О персональных данных»

Ст. 6, 9, 10, 22. Применимость. Прямая. Что требует. Сбор сведений о здоровье (аллергии, диагнозы, диеты) — обработка специальных категорий ПД; основание — исполнение полномочий, предусмотренных законодательством, или согласие.

13.17. Трудовой кодекс РФ

Глава 30 (дисциплина труда), Глава 38 (материальная ответственность), Глава 39 (особенности регулирования труда отдельных категорий). Применимость. Прямая. Что требует. Должностные инструкции; распределение обязанностей; ответственность.

13.18. КоАП РФ

Ст. 6.3, 6.6 — нарушение санитарных правил. Ст. 7.29, 7.30, 7.32 — нарушения в сфере закупок. Ст. 13.11 — нарушение порядка обработки ПД. Ст. 15.11 — грубое нарушение правил бухучёта. Ст. 15.14 — нецелевое использование бюджетных средств. Ст. 5.27 — нарушение трудового законодательства. Применимость. Прямая.

13.19. УК РФ

Ст. 109 — причинение смерти по неосторожности. Ст. 118 — причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности. Ст. 137 — нарушение неприкосновенности частной жизни. Ст. 159 — мошенничество. Ст. 160 — присвоение или растрата. Ст. 236 — нарушение санитарно-эпидемиологических правил (ч. 3 — при смерти 2+ лиц). Ст. 285 — злоупотребление должностными полномочиями. Ст. 285.1, 285.2 — нецелевое расходование бюджетных средств. Ст. 293 — халатность. Ст. 290, 291 — взятка. Применимость. Прямая. Внимание. Ст. 238 («Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ либо оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности») — к ДСО применяется ограниченно. Решение об отнесении действий к ст. 238 принимается следственным органом.

13.20. ФЗ-273 «О противодействии коррупции»

Ст. 10, 11.1, 13.3. Применимость. Прямая. Что требует. Антикоррупционная политика; декларирование конфликтов интересов.

13.21. Конвенция ООН о правах инвалидов

Ратифицирована Россией 03.05.2012. Ст. 12. Равное признание правоспособности. Ст. 19. Независимая жизнь. Ст. 25. Здоровье. Ст. 28. Достаточный жизненный уровень. Замечание общего порядка № 1 (2014) к ст. 12. Поддерживаемое принятие решений, а не заместительное. Применимость. При толковании национального законодательства (ч. 4 ст. 15 Конституции РФ).

13.22. Сводная таблица: НПА — применимость — действие

НПА Применимость Действие директора Согласование Конституция РФ Прямая Учёт прав Нет ФЗ-442 Прямая Услуги по ИППСУ Учредитель Закон 3185-1 Частичная Уважение прав Нет Учёт мнения Суд (по ГК РФ Прямая подопечного недееспособности) Отчёт, расходы в ФЗ-48 Прямая (если опекун) Орган опеки интересах ФЗ-323 Частичная Содействие в медпомощи Мед. организация ФЗ-52 Прямая Соблюдение СанПиН Нет НАССР, 3-разовое СанПиН 2.3/2.4.3590-20 Прямая Нет питание Товарное соседство, ТР ТС 021/2011 Прямая Нет температура Приказ Минтруда 520н Прямая Натуральные нормы Регион БК РФ Прямая Целевое использование Учредитель ФЗ-44 Прямая Закупки ФАС ФЗ-402 Прямая Первичные

документы Нет ФЗ-152 Прямая Согласия на ПД Нет Должностные ТК РФ
Прямая Нет инструкции КоАП РФ Прямая Избегать нарушений Нет УК РФ
Прямая Избегать преступлений Нет Антикоррупционная ФЗ-273 Прямая
Нет политика КПРИ При толковании Учёт воли жителей Нет

НПА	Применимость	Действие директора	Согласование
Конституция РФ	Прямая	Учёт прав	Нет
ФЗ-442	Прямая	Услуги по ИППСУ	Учредитель
Закон 3185-1	Частичная	Уважение прав	Нет
ГК РФ	Прямая	Учёт мнения подопечного	Суд (по недееспособности)
ФЗ-48	Прямая (если опекун)	Отчёт, расходы в интересах	Орган опеки
ФЗ-323	Частичная	Содействие в медпомощи	Мед. организация
ФЗ-52	Прямая	Соблюдение СанПиН	Нет
СанПиН 2.3/2.4.3590-20	Прямая	НАССР, 3-разовое питание	Нет
ТР ТС 021/2011	Прямая	Товарное соседство, температура	Нет
Приказ Минтруда 520н	Прямая	Натуральные нормы	Регион
БК РФ	Прямая	Целевое использование	Учредитель
ФЗ-44	Прямая	Закупки	ФАС
ФЗ-402	Прямая	Первичные документы	Нет
ФЗ-152	Прямая	Согласия на ПД	Нет
ТК РФ	Прямая	Должностные инструкции	Нет
КоАП РФ	Прямая	Избегать нарушений	Нет

УК РФ	Прямая	Избегать преступлений	Нет
ФЗ-273	Прямая	Антикоррупционная политика	Нет
КПРИ	При толковании	Учёт воли жителей	Нет

Глава 14. Санитарная безопасность и организация пищеблока

14.1. Что требует СанПиН 2.3/2.4.3590-20

(действует с 1 января 2021 г., с изменениями от 22.08.2024) П. 2.1. Обязательное внедрение принципов НАССР. П. 2.3. Поточность технологических процессов (исключение встречных потоков сырья и готовой продукции). П. 2.4. Раздельное технологическое и холодильное оборудование для сырья и готовой продукции. П. 2.5. Маркированный инвентарь. П. 2.6. Отдельные туалеты для посетителей и работников (для предприятий с > 25 посадочных мест — обязательно). П. 2.15. Исправные системы холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, вентиляции, освещения. П. 3.7. Отдельные туалеты для работников. П. 7.1.1. Пищеблок в отдельно стоящем здании или в лечебном корпусе при условии поточности. П. 7.1.2. Принципы лечебного питания при организации питания в медицинских организациях. П. 7.1.11. В организациях стационарного социального обслуживания — питание не менее 3 раз в день, в том числе диетическое по медицинским показаниям. П. 7.1.12. При использовании готовых блюд — помещение для приёма и отбора суточных проб. П. 7.1.13. При нарушении технологии — блюдо к выдаче не допускается. П. 7.1.14. Отбор суточной пробы: холодные закуски, первые блюда, гарниры, напитки — не менее 100 г; порционные — целиком. П. 8.1.2. Меню утверждается руководителем; при аутсорсинге — руководителем исполнителя, согласовывается с руководителем организации. П. 8.1.4. Меню разрабатывается на период не менее двух недель.

14.2. Что директор должен обеспечить

□ НАССР-систему. □ Поточность (или компенсирующие мероприятия). □ Маркировку инвентаря. □ Отбор суточной пробы. □ Журнал бракеража. □ Журнал температурного режима. □ Медкнижки работников. □ Производственный контроль (лабораторные исследования). □ Обучение персонала. □ Устранение нарушений по предписаниям Роспотребнадзора.

14.3. Что нельзя решать приказом

□ Утвердить меню без согласования с диетсестрой/врачом. □ Принять в эксплуатацию новый пищеблок без разрешительных документов. □ Принять на работу без медкнижки. □ Открыть пищеблок после ремонта без санитарно-эпидемиологического заключения.

14.4. Красные флаги (что увидит проверяющий)

□ Отсутствие программы производственного контроля. □ Отсутствие журнала бракеража. □ Отсутствие суточной пробы. □ Просроченные продукты. □ Хранение без маркировки. □ Хранение с нарушением товарного соседства. □ Несоблюдение поточности. □ Отсутствие медкнижек. □ Антисанитария. □ Грязная ветошь. □ Отсутствие дезинфицирующих средств.

14.5. Типичные нарушения по прокурорской практике

□ Неукомплектованность штатом поваров. □ Отсутствие диетсестры. □
Нарушение товарного соседства. □ Некачественная суточная проба. □
Отсутствие бракеражного журнала. □ Дисфагия без текстурной
модификации. □ Кадровые нарушения (отсутствие врача, санитарок).

ЧАСТЬ V. ОРГАНИЗАЦИЯ

Глава 15. Как составить меню с двумя вариантами

15.1. Принцип равноценности

Два варианта должны быть равноценны: □ по калорийности ($\pm 5\%$ по приёмам пищи в среднем за неделю); □ по БЖУ; □ по разнообразию (одинаковое число видов мяса, рыбы, овощей, круп за цикл); □ по приёмам пищи (завтрак А = завтрак Б по структуре); □ по диетической адекватности (оба варианта могут быть адаптированы под каждую диету); □ по привлекательности (одинаковые усилия повара).

15.2. Структура цикличного меню

Цикл. 14 или 21 день. Для двух вариантов — 14 дней А + 14 дней Б = 28 уникальных комплектов. Приёмы пищи. Завтрак, обед, полдник, ужин, второй ужин (по СанПиН п. 7.1.11). Допускается 4-разовое питание при обосновании. Структура каждого приёма пищи: Приём Доля от суточной калорийности
Завтрак 25–30% Обед 35–40% Полдник 10% Ужин 20%
Второй ужин 5–10%

Приём	Доля от суточной калорийности
Завтрак	25–30%
Обед	35–40%
Полдник	10%
Ужин	20%
Второй ужин	5–10%

15.3. Алгоритм составления

□ Собрать сведения о предпочтениях жителей (анкетирование, наблюдение, беседа с родственниками). □ Согласовать с диетсестрой/врачом перечень диет. □ Определить натуральные нормы (Приказ Минтруда 520н; региональный акт). □ Сформировать 14-дневное меню А. □ Сформировать 14-дневное меню Б (равноценное). □ Рассчитать

калорийность и БЖУ для каждого блюда. □ Рассчитать стоимость. □ Согласовать с диетсестрой. □ Согласовать с врачом. □ Утвердить приказом. □ Обеспечить визуальное меню (карточки, стенд).

15.4. Технологические карты

На каждое блюдо — ТК: □ рецептура; □ выход; □ калорийность; □ БЖУ; □ витамины (по возможности); □ стоимость; □ требования к качеству сырья; □ требования к обработке; □ условия хранения; □ сроки реализации.

15.5. Таблица взаимозаменяемости

Согласно Приложению 11 к СанПиН 2.3/2.4.3590-20. Каждый продукт имеет заменитель с эквивалентной пищевой ценностью. Примеры: □ Говядина ↔ Баранина ↔ Конина (по белку). □ Молоко ↔ Кефир ↔ Ряженка (по кальцию). □ Яблоко ↔ Груша (по углеводам и клетчатке). □ Гречка ↔ Рис ↔ Пшено (по углеводам).

15.6. Параллельное приготовление

Требования: □ Параллельные рабочие места. □ Достаточное количество оборудования (плиты, пароконвектоматы). □ Достаточный штат. □ Маркировка (А или Б). □ Раздельная выдача.

15.7. Контроль качества

□ Бракераж готовых блюд (комиссия). □ Суточная проба (каждого варианта). □ Контроль температуры на раздаче. □ Анализ отходов. □ Обратная связь от жителей.

15.8. Где два варианта не нужны

□ При малом числе жителей (< 50). □ При отсутствии параллельного приготовления. □ При отсутствии финансирования дополнительного персонала.

15.9. Чек-лист готовности

Элемент Есть Нет Параллельные рабочие места ☐ ☐ Достаточно плит ☐ ☐
 Достаточно персонала ☐ ☐ ТК на оба варианта ☐ ☐ Маркировка ☐ ☐ Учёт
☐ ☐ Бракераж ☐ ☐ Суточная проба ☐ ☐ Согласование диетсестры ☐ ☐
 Согласование учредителя ☐ ☐

Глава 16. Как организовать выбор на отделении и на раздаче

16.1. Где выбирают

☐ В отделении (заранее, на следующий день). ☐ В столовой (на раздаче). ☐
 В буфете отделения (круглосуточно для лёгких перекусов).

16.2. Выбор в отделении

Форма. Анкета (для дееспособных), карточки (для неговорящих), наблюдение (для тяжёлых случаев). Время. С 16:00 до 19:00 (для следующего дня).

Элемент	Есть	Нет
Параллельные рабочие места	☐	☐
Достаточно плит	☐	☐
Достаточно персонала	☐	☐
ТК на оба варианта	☐	☐
Маркировка	☐	☐
Учёт	☐	☐
Бракераж	☐	☐
Суточная проба	☐	☐
Согласование диетсестры	☐	☐

Согласование учредителя	☐	☐
Кто собирает. Соц. работник, психолог.		
Что делать, если не выбрал. Предлагается стандартный вариант.		

16.3. Выбор на раздаче

Форма. Визуальная демонстрация (тарелки с образцами, фотографии). Для кого. Дееспособные, сохранные когнитивно. Как организовать. Два варианта на раздаче. Жители подходят и указывают. Помощник накладывает.

16.4. Буфет отделения

Что в буфете. Кефир, йогурт, фрукты, хлеб, вода. Кто имеет доступ. Все жители (круглосуточно или по графику). Что нельзя. Сладкое в неограниченном доступе (при диабете, ожирении); алкоголь.

16.5. Кто помогает с выбором

☐ Социальный работник. ☐ Психолог. ☐ Медицинская сестра. ☐ Санитарка (после обучения). ☐ Волонтер (после обучения). ☐ Родственник. Что нельзя. Повар (чревато конфликтом интересов). Контрактный управляющий (не имеет компетенции). Санитарка без обучения.

16.6. Как избежать формальности

☐ Реальный выбор (не два одинаковых блюда). ☐ Обратная связь (опросы, жалобы). ☐ Сопоставление выбора с фактическим потреблением. ☐ Аудит (выборочная проверка).

16.7. Документирование выбора

Журнал выбора (форма — Приложение 4). Столбцы: ☐ Дата. ☐ Отделение. ☐ Ф.И.О. жителя. ☐ Уровень поддержки (самостоятельно / с поддержкой / через представителя). ☐ Выбранное блюдо. ☐ Способ выражения (устно / карточка / пробная ложка / наблюдение). ☐ Подпись помогающего (при

поддержке).

16.8. Анализ данных

□ Какие блюда выбирают чаще. □ Какие группы предпочитают что. □ Сколько жителей фактически не выбирают. □ Сколько раз заканчивается один из вариантов. □ Объём отходов по каждому варианту.

Глава 17. Как проверить, что выбор настоящий

17.1. Признаки фиктивного выбора

□ Журнал заполняется «по умолчанию» (все выбирают первый вариант). □ Жители не знают о наличии выбора. □ Персонал не спрашивает. □ Жители не могут объяснить, что они выбрали. □ Объём отходов одинаковый по вариантам. □ Жалоб на отсутствие выбора нет (потому что не знают, что оно должно быть). □ Наблюдатель видит, что выбор на раздаче отличается от зафиксированного.

17.2. Способы проверки

Перепроверка реакцией. Предложить ещё раз через 15 минут — реакция должна быть похожей. Сопоставление с фактическим потреблением. Если житель «выбрал» суп, но не ест его — выбор не настоящий. Независимый наблюдатель. Соц. работник, не участвующий в кормлении, наблюдает. Сопоставление с пищевой биографией. Если житель всю жизнь не ел рыбу, а сегодня «выбрал» рыбу — вероятно, подмена. Родственники. Спросить, похоже ли это на их близкого. Аудит. Выборочная проверка записей (не менее 10% жителей в месяц).

17.3. Алгоритм проверки

□ Выбрать 10% жителей случайным образом. □ Для каждого: □ Спросить, что он ел сегодня. □ Спросить, что выбирал. □ Сопоставить с журналом. □ Спросить родственников (если возможно). □ Зафиксировать расхождения. □ При систематических расхождениях — корректировка процедуры.

17.4. Документирование аудита

□ Акт аудита. □ Перечень проверенных жителей. □ Перечень расхождений. □ Корректирующие мероприятия.

17.5. Ответственность

□ Соц. работник, заполняющий журнал фиктивно, — дисциплинарная ответственность. □ Систематическая фиктивность — расследование, возможно увольнение. □ Если фиктивность привела к причинению вреда — гражданско-правовая и уголовная ответственность.

Глава 18. Люди и рабочая нагрузка

18.1. Кухня

Минимальный штат (для 100 жителей): □ Заведующий производством (старший повар) — 1. □ Повар — 3-4 (смены). □ Повар-кондитер — 1. □ Кухонный рабочий — 2. При двух вариантах: + 1 повар, + 1 кухонный рабочий. Дополнительные функции: □ Бракеражная комиссия. □ Диетсестра (если есть). □ Технолог (если есть).

18.2. Отделения

Минимальный штат отделения (на 30 коек): □ Старшая медсестра — 1. □ Медсестра — 2 (смены). □ Санитарка — 6 (3 смены по 2). При высокой зависимости жителей: + 2-4 санитарки. Функции по питанию: □ Помощь при приёме пищи. □ Кормление лежачих. □ Сбор предпочтений. □ Фиксация выбора. □ Наблюдение за состоянием. □ Документирование.

18.3. Медицинский персонал

□ Врач-психиатр (штатный или по договору). □ Врач-терапевт. □ Диетсестра (если есть). □ Логопед (по договору или через телемедицину).

18.4. Бухгалтерия

□ Главный бухгалтер. □ Бухгалтер по продуктам питания. При двух вариантах: + 0,5 ставки бухгалтера.

18.5. Контрактная служба

□ Контрактный управляющий. □ При наличии — отдел закупок. При двух вариантах: дополнительная нагрузка (увеличение числа позиций в ТЗ, отдельный учёт).

Со гл а с ов ан и е с в ра чо м	A	C	R	C	C	I	I	I	I	C	I
Со гл а	R	A	I	I	I	I	I	C	C	I	A
со ва ни											
е с											
уч ре д											
ит ел е											
м											
За ку п											
ка											
A C I C I C R I I											
пр од у											
кт ов											

Пр иё м	
ка	
А С И R I I R R I I	
пр од у	
КТ ОВ	
Пр ои з	

водств А С I I R I I I I I I I о Бракер А С С С R I I I I I I I аж Раздач А I С С R R I I I I I I а
Помо щь при А С С С I R I I I I I I приём е пищи Сбор предп А С С С I R C I I C I
очтен ий Фикса ция А С I I I R C I I I I I I I выбор а Учёт отказа А С С С I R C I I I I I в

За ку п ка пр од у к то в	А	С	I	I	С	I	I	С	R	I	I
Пр иё м ка пр од у к то в	А	С	I	I	R	I	I	R	R	I	I

Пр ои зв од ств о	A	C	I	I	R	I	I	I	I	I	I
Бр ак ер аж	A	C	C	C	R	I	I	I	I	I	I
Ра зд ач а	A	I	C	C	R	R	I	I	I	I	I
По мо щь пр и п ри ём е п ищ и	A	C	C	C	I	R	I	I	I	I	I
Сб ор пр ед по чт ен ий	A	C	C	C	I	R	C	I	I	C	I
Фи кс а ц ия вы бо ра	A	C	I	I	I	R	C	I	I	I	I
Уч ёт от ка зо в	A	C	C	C	I	R	C	I	I	I	I

Об ра т

ная А С С I C R R I I I I связь Анали з А С С С R I I C I I I отхо до в Аудит реальн
ости А R С С С R C I I C I выбо р а Корре ктиров А С С R R C I I I I I ка меню
Годов ой отчёт R A C I I C I C I A C опеку на R — ответственный, А —
утверждает, С — консультирует, I — информируется.

18.8. Что нельзя возложить на санитарок

□ Принятие медицинских решений. □ Приготовление пищи. □ Закупка. □
Бухгалтерия. □ Принуждение к еде. □ Заполнение медицинской
документации.

Об ра т н ая св яз ь	A	C	C	I	C	R	R	I	I	I	I
Ан ал из от хо до в	A	C	C	C	R	I	I	C	I	I	I
Ау ди тр еа ль но ст и в ыб ор а	A	R	C	C	C	R	C	I	I	C	I

Ко
рр
ек
ти
ро
в
ка
ме
ню

A C C R R C I I I I I

Го
до
в
ой
от
чё
то
пе
ку
на

R A C I I C I C I A C

18.9. Что может санитарка (после обучения)

□ Помощь при приёме пищи. □ Сбор предпочтений (в простой форме). □ Фиксация выбора (по заданию соц. работника). □ Наблюдение за состоянием (сообщение медсестре). □ Кормление лежачих (по инструкции). □ Уход за посудой.

18.10. Обучение

Обязательное: □ НАССР — для всех работников пищеблока. □ Санитарные требования — для всех работников. □ Охрана труда — для всех. □ Правила работы с пищевыми продуктами — для поваров. Желательное (для внедрения вариативности): □ Распознавание признаков дисфагии. □ Распознавание признаков аспирации. □ Альтернативная коммуникация (для соц. работников). □ Этикет работы с жителями (для санитарок). □ Психология пищевого поведения (для психолога и соц. работника).

18.11. Дефицит кадров — что делать

□ Перераспределение функций. □ Совмещение. □ Привлечение волонтеров. □ Телемедицина (для врачебных консультаций). □ Аутсорсинг (с осторожностью). □ Заявка учредителю на дополнительные ставки.

18.12. Главный тезис

Вариативное меню требует дополнительных людей, времени и обучения. Без них оно превратится в формальность. Планировать надо одновременно: что делаем, кто делает, на чём обучаем, как контролируем.

ЧАСТЬ VI. ДЕНЬГИ, ЗАКУПКИ, УЧЁТ

Глава 19. Финансовые модели

Все расчёты — иллюстративные. Не являются нормативом или подтверждённой стоимостью конкретного учреждения. Чувствительность к ценам по регионам — высокая.

19.1. Структура затрат на питание (типично)

Статья Доля
Продукты 60-70% Зарплата поваров 12-18% Зарплата помощников на раздаче 5-8% Оборудование (амортизация, ремонт) 2-5% Энергоресурсы 2-4% Моющие средства, СИЗ 1-2% Лабораторный контроль 0,5-1% Обучение 0,5-1% Прочие 1-2%

19.2. Исходные допущения (для всех моделей)

Статья	Доля
Продукты	60-70%
Зарплата поваров	12-18%
Зарплата помощников на раздаче	5-8%
Оборудование (амортизация, ремонт)	2-5%
Энергоресурсы	2-4%
Моющие средства, СИЗ	1-2%
Лабораторный контроль	0,5-1%
Обучение	0,5-1%
Прочие	1-2%
□ Число жителей: 100.	
□ Число дней: 365.	
□ Стоимость суточного набора продуктов (мономеню): 350 руб. (условно).	
□ Зарплата повара: 50 000 руб./мес.	
□ Численность поваров (мономеню): 4.	

□ Аутсорсинг: + 30% к стоимости продуктов (по практике).

19.3. Модель 1. Мономеню

Описание. Единое меню на 14 дней. Без выбора. Расчёт: □ Продукты: $350 \times 100 \times 365 = 12\,775\,000$ руб./год. □ Зарплата поваров: $50\,000 \times 4 \times 12 = 2\,400\,000$ руб./год. □ Оборудование, энергоресурсы, прочее: 1 200 000 руб./год. □ ****Итого: ~16 375 000 руб./год. На 1 жителя: ~164 руб./сутки.****

19.4. Модель 2. Выбор напитка

Описание. Дополнительно предлагается 2 напитка (чай, компот, какао, сок). Изменения: □ + 5% к стоимости продуктов (на дополнительный ассортимент напитков). □ + 0 ставок поваров. □ ****Итого: ~16 575 000 руб./год. На 1 жителя: ~166 руб./сутки. Индекс: 1,01.****

19.5. Модель 3. Выбор гарнира

Описание. Два гарнира (например, картофель и гречка). Изменения: □ + 10% к стоимости продуктов. □ + 0 ставок поваров. □ ****Итого: ~17 000 000 руб./год. Индекс: 1,04.****

19.6. Модель 4. Выбор основного блюда (2 раза в неделю)

Описание. 2 дня в неделю — выбор из двух основных блюд на обед. Изменения: □ + 8% к стоимости продуктов. □ + 0,5 ставки повара. □ ****Итого: ~17 425 000 руб./год. Индекс: 1,06.****

19.7. Модель 5. Ежедневный выбор из двух вариантов

Описание. Полное параллельное меню на 14 дней А и Б. Изменения: □ + 15% к стоимости продуктов. □ + 1 ставка повара. □ + 1 ставка кухонного рабочего. □ + 0,5 ставки бухгалтера. □ + 0,5 ставки соц. работника. □ Возможно: + 1 ставка диетсестры (или по договору). □ Оборудование: + 1 000 000 руб. (плита, пароконвектомат, холодильник). □ Обучение: 100 000 руб./год. □ ****Итого: ~19 600 000 руб./год (с учётом амортизации оборудования). На 1 жителя: ~196 руб./сутки. Индекс: 1,20.****

19.8. Модель 6. Несколько диетических и текстурных линий

Описание. Стандартное, диабетическое, ЖКТ, текстурно-модифицированное (пюре, мягкое), жидкое. Изменения: □ + 25% к стоимости продуктов (больше отходов, специальные продукты). □ + 2 ставки поваров. □ + 1 ставка диетсестры. □ + 0,5 ставки логопеда. □ Оборудование: + 2 000 000 руб. (блендер, пароконвектомат, загустители). □ **Итого: ~22 500 000 руб./год. На 1 жителя: ~225 руб./сутки. Индекс: 1,37.**

19.9. Сводная таблица

Модель Индекс Доп. затраты (руб./год) Доп. кадры
1. Мономеню 1,00 0 0 2.
Напиток 1,01 200 000 0 3. Гарнир 1,04 625 000 0 4. Блюдо 2р/нед 1,06 1 050 000 0,5 повара
1 повар, 1 раб, 0,5 бухг, 5. Два варианта 1,20 3 225 000 0,5 соц
2 повара, 1 диет, 0,5 6. Диетлинии 1,37 6 125 000 логоп

19.10. Чувствительность

К числу жителей. При < 50 жителях модели 5 и 6 экономически нецелесообразны (высокая стоимость на 1 жителя). При > 200 жителях модели 5 и 6 более реалистичны. К зарплате. При высокой зарплате поваров относительная стоимость моделей 5 и 6 растёт.

Модель	Индекс	Доп. затраты (руб./год)	Доп. кадры
1. Мономеню	1,00	0	0
2. Напиток	1,01	200 000	0
3. Гарнир	1,04	625 000	0
4. Блюдо 2р/нед	1,06	1 050 000	0,5 повара
5. Два варианта	1,20	3 225 000	1 повар, 1 раб, 0,5 бухг, 0,5 соц
6. Диетлинии	1,37	6 125 000	2 повара, 1 диет, 0,5 логоп

К цене
продуктов. При
росте цен на 20%
относительная
стоимость

моделей 4–6
растёт.

К отходам.
Экономия на
отходах может
составлять
5–15% от
стоимости

продуктов (по данным исследований в aged care). Без собственного замера — не доказано. ОЛ.

19.11. Где экономия возможна

□ Снижение отходов (точный заказ, предзаказ). □ Снижение потерь при хранении (правильный температурный режим). □ Закупка в сезон. □ Договоры с фиксированной ценой. □ Снижение излишеств (порционная подача).

19.12. Где экономия недопустима

□ На текстурной модификации. □ На загустителях. □ На обучении персонала. □ На лабораторном контроле. □ На холодильном оборудовании. □ На сокращении числа поваров (при высокой нагрузке).

19.13. Методика собственного семидневного замера

□ ****День 1.**** Подготовить таблицу (см. Приложение 25). □ ****Дни 2–8.**** Каждый день фиксировать: □ сколько приготовлено (по вариантам); □ сколько выдано (по вариантам); □ сколько съедено (визуально); □ сколько осталось; □ сколько времени персонал потратил на выбор и помощь (в часах); □ сколько раз вариант закончился; □ сколько было отказов; □ сколько было замен. □ ****День 9.**** Анализ. □ ****Расчёт.**** Стоимость сырья на 1 жителя, на 1 приём пищи, на 1 вариант.

19.14. Главный тезис

Снижение расходов — не главная цель. Главные цели: безопасность, достаточность, достоинство, реальный выбор. Экономия — побочный эффект, не цель.

Глава 20. Закупки и снабжение

20.1. Планирование двух вариантов

Проблема. Удвоение позиций в заявке, ТЗ, контракте. Решение. Разделение на лоты (мясо, молочные, овощи отдельно). Указание в ТЗ перечня вариантов (например, «говядина или курица»).

20.2. Прогнозирование спроса

Методы: ☐ Исторические данные (что выбирали в прошлом). ☐ Анкетирование. ☐ Сезонные корректировки. ☐ Корректировка по факту (еженедельно).

20.3. НМЦК

Методы: ☐ Анализ рынка (коммерческие предложения, реестр контрактов). ☐ Нормативный (по региональным нормативам). Документы: Обоснование НМЦК, запросы, реестр.

20.4. ТЗ

Обязательные разделы: ☐ Наименование. ☐ Количество. ☐ Срок. ☐ Место. ☐ Требования к качеству. ☐ Требования к ассортименту (при вариативности). ☐ Требования к калорийности. ☐ Требования к диетам. ☐ Требования к документации. ☐ Требования к персоналу. ☐ Требования к транспорту. ☐ Требования к приёмке. ☐ Ответственность.

20.5. Приёмка

Документы: ☐ ТОРГ-12 / УПД. ☐ Ветеринарное свидетельство (для продукции животного происхождения). ☐ Декларация о соответствии. ☐ Маркировка. Процедура: ☐ Проверка количества. ☐ Проверка качества (внешний вид, целостность упаковки, сроки годности). ☐ Проверка условий хранения при доставке. ☐ Подпись в накладной. При несоответствии: Акт,

рекламация, замена.

20.6. Взаимозаменяемость

Условия: □ Эквивалентность по БЖУ. □ Согласование с диетсестрой. □ Фиксация в журнале замен. □ Указание в меню-требовании фактически использованного продукта.

20.7. Недопоставка

Действия: □ Сообщить поставщику. □ Заменить по таблице эквивалентности. □ При невозможности — претензионная работа.

20.8. Специальные продукты

Примеры: Безлактозное молоко, безглютеновые крупы, кетогенные смеси, загустители. Закупка: Отдельный лот или отдельная закупка. Обоснование потребности.

20.9. Учёт фактического выбора

Проблема. Как списать продукты, если часть выбрала А, часть — Б. Решение: □ Меню-требование на каждый вариант отдельно. □ Списание по фактической выдаче. □ Акт на остатки.

20.10. Аутсорсинг

Когда целесообразен: □ При отсутствии собственного пищеблока. □ При кадровом дефиците. □ При экономической целесообразности. Когда нецелесообразен: □ При наличии работающего пищеблока. □ При особых требованиях (диеты, текстуры). □ При отсутствии контроля качества. Требования к контракту: □ Подробное ТЗ. □ Требования к диетсестре/технологу исполнителя. □ Требования к согласованию меню. □ Требования к приёмке. □ Ответственность за качество. □ Право на проверку. □ Расторжение при систематических нарушениях.

20.11. Красные флаги в закупках

□ Единственный поставщик без оснований. □ Дробление закупок. □ Завышение НМЦК. □ Ограничение конкуренции (нерелевантные требования). □ Фиктивные поставки. □ Приёмка некачественного товара. □ Конфликт интересов (родственник поставщика).

20.12. Конфликт интересов

Ситуации: □ Родственник директора — учредитель поставщика. □ Поставщик — бывший работник учреждения. □ Поставщик предлагает «откат». Меры: □ Декларирование конфликтов интересов. □ Комиссионная приёмка. □ Ротация членов комиссии. □ Антикоррупционная политика.

20.13. Главный тезис

Закупки при вариативном меню — сложнее, чем при мономеню. Больше позиций, больше нюансов, больше рисков. Но при правильной организации — управляемо.

Глава 21. Учёт, документы и внутренний контроль

21.1. Первичные документы

Обязательные: □ Меню-требование. □ Накладная (ТОРГ-12 / УПД). □ Акт о списании. □ Журнал бракеража. □ Журнал отбора суточной пробы. □ Журнал температурного режима. □ Журнал выбора блюд. □ Журнал отказов. □ Журнал замен.

21.2. Формы документов

Текущее состояние. Приказ Минфина 52н от 30.03.2015 (формы) — действующий. Государственный сектор переходит на электронные унифицированные формы (Приказ Минфина от 30.03.2023 № 47н и др.). На 22.07.2026 точные сроки и формы требуют уточнения. ОЛ. Практически. Учреждение вправе использовать собственные формы при условии обязательных реквизитов (ст. 9 ФЗ-402).

21.3. Электронный документооборот

Требования: □ Электронная подпись. □ Соответствие форматам. □ Хранение. □ Доступ.

21.4. Меню-требование

Структура: □ Дата. □ Отделение. □ Список блюд. □ Количество порций по вариантам. □ Подпись повара. □ Подпись калькулятора. □ Подпись бухгалтера. При двух вариантах. Отдельная строка для каждого варианта.

21.5. Складской учёт

□ Поступление — по накладной. □ Выдача — по меню-требованию. □ Списание — по акту. □ Остатки — по инвентаризации (не реже 1 раза в месяц для продуктов).

21.6. Инвентаризация

□ Плановая — не реже 1 раза в год. □ Внеплановая — при смене МОЛ, при выявлении расхождений. □ Акт по форме 0504835.

21.7. Учёт специальных продуктов

□ Отдельный складской учёт. □ Учёт по жителям (кто получает). □ Списание по фактическому потреблению.

21.8. Учёт отходов

□ Ежедневный (по приёмам пищи). □ Анализ еженедельный. □ Использование для корректировки меню и заказов.

21.9. Сопоставление данных

Еженедельно: □ Меню-требование vs. фактическая выдача. □ Фактическая выдача vs. фактическое потребление. □ Потребление vs. отходы. Ежемесячно: □ Стоимость vs. бюджет. □ Число жалоб. □ Число отказов. Ежеквартально: □ Анализ удовлетворённости. □ Корректировка меню. Ежегодно: □ Инвентаризация. □ Годовой отчёт. □ Аудит реальности выбора.

21.10. Внутренний контроль

Компоненты: □ Контрольная среда (этические нормы, распределение полномочий). □ Оценка рисков. □ Контрольные процедуры. □ Информация и коммуникация. □ Мониторинг. Что делать директору: □ Утвердить положение о внутреннем контроле. □ Назначить ответственных. □ Установить периодичность. □ Обеспечить документирование.

21.11. Что увидит проверяющий

Роспотребнадзор: □ НАССР. □ Бракераж. □ Суточная проба. □ Медкнижки. □ Товарное соседство. □ Температурный режим. □ Состояние помещений. Прокуратура: □ Лицензии. □ Штатное расписание. □ Укомплектованность. □ Документы на питание. □ Жалобы и обращения. КСП / финансовый контроль: □ Государственное задание. □ Субсидии. □ Закупки. □ Бухгалтерия. □ Списание. □ Целевое использование. Роскомнадзор: □ Персональные данные. □ Согласия. □ Хранение. Трудовая инспекция: □ Трудовые договоры. □ Должностные инструкции. □ СОУТ. □ Обучение.

21.12. Документы защитного контура

□ Государственное задание. □ План ФХД. □ Отчётность. □ Контракты. □ Накладные. □ Меню-требования. □ ТК. □ Журналы. □ ИППСУ. □ Акты проверок. □ Переписка с учредителем. □ Отчёт опекуна. □ Акты инвентаризации.

ЧАСТЬ VII. ГЕОГРАФИЯ И МИРОВОЙ ОПЫТ

Глава 22. Российские региональные модели

22.1. Подход к региональному анализу

Региональный блок ниже построен на проверенных открытых источниках. Где есть только новость учреждения, это явно отмечено. Новость не доказывает устойчивость практики.

22.2. Санкт-Петербург

Нормативная база. □ Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 29.12.2014 № 1284 «Об утверждении норм питания в организациях социального обслуживания населения Санкт-Петербурга» (в ред. от 27.06.2022). Источник: docs.cntd.ru/document/822404350. **Подтверждено по открытым базам, требует проверки актуальной редакции.** Ключевые положения: □ Натуральные нормы утверждены отдельно для: общих учреждений, ПНИ, диабета, ЖКТ. □ Структура рациона: завтрак — 25%, обед — 35%, полдник — 10%, ужин — 20%, второй ужин — 10% (стационар). □ В полустационаре: завтрак — 30%, обед — 40%, полдник — 10%, ужин — 20%. □ Допускается отступление от калорийности $\pm 5\%$ при сохранении средненедельного значения. □ Взаимозаменяемость — по Приложению 11 к СанПиН 2.3/2.4.3590-20. □ При аутсорсинге меню утверждается руководителем исполнителя и согласовывается с руководителем учреждения. Подтверждённая практика. □ СПб ГБУСОН «ПНИ-6» — локальный акт об организации лечебного питания (2018). Источник: pni6.ru. **Подтверждено.** □ СПб ГБУСОН «ЦСРИДИ Невского района» — аутсорсинг через АО «Комбинат социального питания «Волна»» по контрактам в ЕИС.

- Подтверждено по открытым закупкам.**

22.3. Москва

Нормативная база. □ Приказ Департамента социальной защиты населения г. Москвы от 24.12.2014 № 1068. Источник: garant.ru/products/ipo/prime/doc/70784358/.

- Подтверждено.**

□ Приказ Департамента труда и социальной защиты населения г. Москвы от 22.03.2021 № 228. Источник: base.garant.ru/405012407/.
Подтверждено. Ключевые положения (Приказ 1068): □ Натуральные нормы (в граммах брутто) отдельно для: общего типа, психоневрологических, социально-медицинской реабилитации. □ Отдельные нормы для детей 3–18 лет, временно проживающих с матерями в кризисных центрах, и для женщин старше 18 лет. □ Расширенный ассортимент молочных и кисломолочных продуктов. □ Нормы для лиц с диабетом и ЖКТ.

22.4. Республика Татарстан

Нормативная база. □ Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 25.09.2025 № 752 «Об утверждении нормативных затрат организаций социального обслуживания Республики Татарстан на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов». Источник: mtsz.tatarstan.ru.
Подтверждено (финансовые нормативы). □ Региональный акт о натуральных нормах питания — открытый доступ ограничен. **Требуется проверки.**

22.5. Новосибирская область

Подтверждённая практика (по открытым источникам): □ Успенский ПНИ — внедрение «шведского стола» (2025). Источник: mtsr.nso.ru.
Подтверждено по новости. □ Болотнинский ПНИ — вариативное меню (с 2024). Источник: bpni.nso.ru.

- Подтверждено по новости.**

Оговорка. Новости подтверждают факт публичного сообщения, не устойчивость практики. Для вывода об устойчивости требуется локальный акт или повторные публикации.

22.6. Тюменская область

Подтверждённая практика: □ В 2025 году в четырёх организациях введено вариативное меню. Источник: base.garant.ru/414126413.
Подтверждено. □ Используется «кулинарный совет» с участием жителей. □ Циклическое меню (14, 21 день) согласовано с Роспотребнадзором и диетологом области.

22.7. Вологодская область

Подтверждённая практика: ☐ Красавинский дом социального обслуживания — аутсорсинг + инфоматы для сбора предпочтений (с 2025). Источник: vologda.mk.ru. **Подтверждено по новости.** ☐ В 2026 г. проведена Межрегиональная методическая площадка (в рамках нацпроекта «Семья»).

22.8. Нижегородская область

Подтверждённая практика: ☐ ГБУ «Городецкий ПНИ» — дегустации и анкетирование (2023). Источник: сайт учреждения. **Подтверждено.**

22.9. Иркутская область

Подтверждённая практика: ☐ ОГБУСО «Усть-Илимский дом-интернат «Лидер»» — вариативное меню (с сентября 2023). Источник: ui-ogbuso.ru. **Подтверждено.**

22.10. Амурская область

Нормативная база. ☐ Постановление Правительства Амурской области от 25.12.2024 № 1009 (в ред.) — нормы питания. Источник: pravo.gov.ru. **Подтверждено.** Ключевые положения: ☐ Нормы дифференцированы по типу учреждения, отделению, возрасту. ☐ Сезонные поправки (например, для картофеля).

22.11. Курганская область

Нормативная база. ☐ Приказ Главного управления социальной защиты населения Курганской области от 04.08.2016 № 310. Источник: kurgan-gov.ru. **Подтверждено.** ☐ Проект приказа Департамента социальной политики (2024) — нормы по приложениям 1–5. Источник: sz226.gov45.ru. **Подтверждено.** Ключевые положения: ☐ Нормы для лиц с диабетом и ЖКТ. ☐ Сезонные поправки.

22.12. Свердловская область

Контрольная практика. ☐ В 2024 г. — масштабная прокурорская проверка ПНИ. К административной ответственности привлечены трое должностных лиц. Источник: asi.org.ru.

- Подтверждено.**

22.13. Кемеровская область (Кузбасс)

Контрольная практика. □ В 2026 г. — внеплановые проверки всех 13 ПНИ после гибели 9 человек в Прокопьевском ПНИ. □ Выявлены: неукomплектованность, незаконная трата денег постояльцев, нарушения противопожарной безопасности. □ Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 236 УК РФ. □ Источник: kem.kp.ru. **Подтверждено.**

22.14. Мурманская область

Контрольная практика. □ ГОАУСОН «Кировский ПНИ» — представление прокурора от 10.12.2021 за нарушения при организации питания (товарное соседство, суточная проба). Источник: kpn1.usoz.ru. **Подтверждено.**

22.15. Пермский край

Контрольная практика. □ ГБУ ПК «Озёрский ПНИ» — иск прокурора о внесении изменений в штатное расписание (0,1–0,25 ставки психиатра). Источник: erp.genpros.gov.ru.

- Подтверждено.**

22.16. Кировская область

Контрольная практика. □ Хищение более 100 тыс. руб. со счетов двух граждан, проживающих в ПНИ Малмыжского района. Источник: asi.org.ru. **Подтверждено.**

22.17. Смоленская область

Контрольная практика. □ Взыскание в пользу 8 постояльцев ПНИ Починковского района завышенной платы в размере 333 тыс. руб. Источник: asi.org.ru. **Подтверждено.**

22.18. Республика Коми

Контрольная практика. □ В Сыктывкаре — два уголовных дела из-за жестокого обращения с детьми при оказании психиатрической помощи. Источник: asi.org.ru.

- Подтверждено.**

22.19. Сводная таблица

Регион Нормативный акт Подтв. практика Подтв. контроль

Регион	Нормативный акт	Подтв. практика	Подтв. контроль
Постановление № 1284 ПНИ-6, аутсорсинг			
СПб —			
(2014, ред. 2022) ЦСРИДИ			
Приказ 1068 (2014),			
Москва — —			
Приказ 228 (2021)			
Постановление № 752			
Татарстан — —			
(2025)			
Успенский ПНИ,			
Новосибирская обл. — —			
Болотнинский ПНИ			
Тюменская обл. — 4 организации —			
Вологодская обл. — Красавинский дом —			
Нижегородская обл. — Городецкий ПНИ —			

Иркутская обл. — Усть-Илимский «Лидер» —
Постановление № 1009
Амурская обл. — —
(2024)
Курганская обл. Приказ № 310 (2016) — —
Свердловская обл. — — 2024 — 3 должн. лица
2026 — 9 погибших, ч. 3
Кемеровская обл. — —
ст. 236
Мурманская обл. — — 2021 — Кировский ПНИ
Пермский край — — 2022 — Озёрский ПНИ
2024 — хищение 100
Кировская обл. — —
тыс.
2024 — 333 тыс.
Смоленская обл. — —
взыскано

Республика Коми
— — 2024 — 2
уголовных дела

22.20. Что показывает картина

□ Региональная практика вариативного меню существует в отдельных учреждениях 6+ субъектов РФ. □ Нацпроект «Семья» стимулирует тиражирование (Вологодская, Тюменская области).

СПб	Постановление № 1284 (2014, ред. 2022)	ПНИ-6, аутсорсинг ЦСРИДИ	—
Москва	Приказ 1068 (2014), Приказ 228 (2021)	—	—
Татарстан	Постановление № 752 (2025)	—	—
Новосибирская обл.	—	Успенский ПНИ, Болотнинский ПНИ	—
Тюменская обл.	—	4 организации	—
Вологодская обл.	—	Красавинский дом	—
Нижегородская обл.	—	Городецкий ПНИ	—
Иркутская обл.	—	Усть-Илимский «Лидер»	—
Амурская обл.	Постановление № 1009 (2024)	—	—
Курганская обл.	Приказ № 310 (2016)	—	—
Свердловская обл.	—	—	2024 — 3 должн. лица

Кемеровская обл.	—	—	2026 — 9 погибших, ч. 3 ст. 236
Мурманская обл.	—	—	2021 — Кировский ПНИ
Пермский край	—	—	2022 — Озёрский ПНИ
Кировская обл.	—	—	2024 — хищение 100 тыс.
Смоленская обл.	—	—	2024 — 333 тыс. взыскано
Республика Коми	—	—	2024 — 2 уголовных дела
□ Контрольная практика (прокуратура, СК) выявляет системные проблемы, не			
связанные напрямую с вариативностью: кадры, имущество, плата, лекарства.			
□ **Российская практика может быть шире, но в открытых источниках она			
плохо документи рована.**			

22.21. Что нужно регионам

□ Региональные методические рекомендации. □ Включение показателей вариативности в стандарты качества. □ Региональный мониторинг. □ Обмен опытом.

Глава 23. География участников семинара

Раздел построен на основе приложенного списка участников. OCR-текст содержит разрывы, дубли, переставленные названия. Очистка списка — отдельная задача (см. PARTICIPANTS_CLEAN.xlsx).

23.1. Кто участвует

По приложенному списку — руководители стационарных организаций социального обслуживания и представители региональных органов власти из многих субъектов РФ.

23.2. Разнообразие условий

Участники работают в разных условиях: □ Разные федеральные округа. □ Разные климатические зоны. □ Разная стоимость продуктов. □ Разные подушевые нормативы. □ Разная кадровая ситуация. □ Разный возраст зданий и состояние пищеблоков. □ Разный уровень автоматизации.

23.3. Что это значит для доклада

□ Не все модели подходят для всех регионов. □ Экономические расчёты — иллюстративные. □ Региональная нормативная база — разная. □ Сравнение с зарубежным опытом — с оговорками.

23.4. Что объединяет

□ Общее законодательство (ФЗ-442, ФЗ-48, СанПиН). □ Общие риски (уголовная, административная ответственность). □ Общие цели (безопасность, достоинство, выбор). □ Общие ограничения (бюджет, кадры).

23.5. Что может региональный орган власти

□ Согласовать изменения государственного задания. □ Утвердить региональные нормы. □ Согласовать дополнительное финансирование. □ Организовать обмен опытом. □ Провести обучение. □ Поддержать пилотные проекты.

23.6. Что может учредитель

□ Согласовать изменения. □ Утвердить дополнительные ставки. □ Обеспечить финансирование. □ Контролировать качество.

23.7. Что может директор учреждения

□ Внедрить минимальные модели без дополнительного финансирования. □ Обучить персонал. □ Сформировать пищевой совет. □ Провести пилот. □ Задokumentировать результаты.

Глава 24. Международные решения, которые можно адаптировать

24.1. Принцип отбора

Включены только те практики, для которых: □ Указан первичный источник. □ Описана конкретная процедура. □ Объяснено, что нужно для переноса. □ Показан предел применимости.

24.2. Великобритания: Mental Capacity Act 2005 и CQC-стандарты

Источник. Mental Capacity Act 2005, legislation.gov.uk. Care Quality Commission, cqc.org.uk. Суть. Презумпция дееспособности. Лицо вправе принять «неразумное» решение. Если лицо не способно — решение принимается в его «наилучших интересах» (best interests) с учётом его пожеланий. CQC-стандарты включают «choice of food and nutrition». Применимость к ДСО/ПНИ РФ. Применимо в части презумпции дееспособности. Не подменяет российское законодательство. Используется как методологический ориентир. Что нужно для переноса. Обучение персонала. Локальные акты. Процедура фиксации воли. Что перенести нельзя. Best interests assessment в британском варианте (другая правовая система).

24.3. Австралия: Aged Care Quality Standards (2019)

Источник. Aged Care Quality and Safety Commission, agedcarequality.gov.au. Суть. Standard 4 «Services and Supports for Daily Living» включает требования к индивидуальным предпочтениям, в том числе в еде. Исследования показывают ограниченный выбор в RACH (residential aged care homes), особенно для лиц на текстурно-модифицированной диете.

Применимость. Частично. Австралийский aged care — для пожилых; не для психически больных. Используется как методология. Источник исследования. PMC4586549, pubmed.ncbi.nlm.nih.gov — Menu Planning in Residential Aged Care—The Level of Choice.

24.4. США: OBRA-87, F-Tag 803

Источник. Federal Nursing Home Reform Act (OBRA-87), 1987. CMS State Operations Manual, F-Tag 803 (Quality of Care). Суть. Резиденты nursing homes (получающие Medicare/Medicaid) имеют право на «choice of food». Несоответствие — санкции CMS. Применимость. Частично. OBRA-87 — для nursing homes (гериатрия). Не для психиатрических учреждений.

24.5. Канада: Long-Term Care Homes Service Standard (Онтарио)

Источник. Government of Ontario, ontario.ca. Суть. Стандарт включает «respect for residents' rights, including choice and autonomy in matters of food, nutrition, and dining». Применимость. Частично. Онтарийский стандарт — для LTC, не для психиатрии.

24.6. Швеция: SoL, LSS, beslutsstödjare

Источник. Socialtjänstlag (2001:453). Lag om stöd vid beslutsrätt (2023:332). Socialstyrelsen, socialstyrelsen.se. Суть. «Beslutsstödjare» — лицо, оказывающее поддержку в принятии решений. Закон вступил в силу в 2024 г. Применимость. Применимо в методологическом плане. Не подменяет российское законодательство.

24.7. Финляндия: Disability Services Act 2023

Источник. Disability Services Act 675/2023, stm.fi. Суть. Поддерживаемое принятие решений — субъективное право. Wellbeing services counties (региональные органы) обязаны обеспечить. Применимость. Применимо в части методологии. Реформа требует существенной адаптации российского законодательства.

24.8. Германия: Реформа BGB 2023

Источник. BGB §§ 1896–1908k (в ред. 2023). BMJ, bmj.de. Суть. Приоритет «помощника» (Begleiter / Unterstützer) над «опекуном» (Betreuer). Введена

обязанность информировать подопечного, учитывать его волю. Применимость. Применимо в части методологии. Российская реформа в этом направлении требует существенных изменений.

24.9. Япония: Group homes

Источник. Ministry of Health, Labour and Welfare, mhlw.go.jp. WHO Global Status Report on Dementia (2021). Суть. Малые дома (group home, グループホーム) для лиц с деменцией. Совместное приготовление пищи с участием жителей. Применимость. Применимо в части методологии. Требует существенной адаптации (российская система институционального ухода).

24.10. ESPEN Guideline on Dementia (2024)

Источник. ESPEN, espen.org. Суть. «Привлекательная еда и напитки с возможностью выбора в функциональной и привлекательной среде». Персоноориентированный подход. Текстульная модификация. Помощь при приёме пищи. Применимость. Применимо для части жителей с деменцией. Не для всей популяции ДСО/ПНИ. Граница — деменция.

24.11. CRPD General Comment No. 1 (2014)

Источник. UN, ohchr.org. CRPD Committee. Суть. Поддерживаемое принятие решений, а не заместительное. «Свободный выбор, включая право отказаться от поддержки». Применимость. При толковании российского законодательства. Не подменяет национальное законодательство.

24.12. IDDSI

Источник. iddsi.net. Суть. Международный стандарт текстурной модификации пищи и жидкостей. 8 уровней. Применимость. Применимо как ориентир. В РФ не обязателен. Требует обучения персонала.

24.13. Что из международного опыта не переносится

□ Конкретные финансовые нормативы (разные экономики). □ Системы лицензирования (другая правовая система). □ Страховые механизмы (отсутствуют в РФ для LTC). □ Защитные механизмы (best interests assessment) — другая правовая система.

24.14. Что переносится

□ Принцип презумпции дееспособности. □ Персоноориентированный подход. □ Текстульная модификация (IDDSI). □ Участие жителей в пищевом совете. □ Пищевая биография. □ Finger food. □ Family-style dining (для когнитивно сохранных). □ Кулинарные мастер-классы (для сопровождаемого проживания).

24.15. Главный тезис

Международный опыт полезен как методологический ориентир. Прямое заимствование — недопустимо. Каждое решение проверяется через призму российского законодательства и региональной практики.

ЧАСТЬ VIII. РИСКИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Глава 25. Ответственность учреждения и директора

25.1. Разграничение рисков и ответственности

Субъект Ответственность Учреждение (юридическое лицо) По обязательствам учреждения Директор Лично — при вине и причинно-следственной связи Заместитель В пределах полномочий Врач За медицинские решения Диетсестра За диетические назначения (в пределах компетенции) Зав. производством За качество готовой пищи Главный бухгалтер За бухгалтерский учёт Контрактный управляющий За закупки Поставщик По контракту Учредитель За государственное задание, финансирование

25.2. Виды ответственности директора

Дисциплинарная. Замечание, выговор, увольнение (ТК РФ ст. 192). Материальная. Возмещение ущерба (ТК РФ ст. 238–250, ГК РФ ст. 1064, 1068). Административная. Штрафы, дисквалификация (КоАП РФ). Гражданско-правовая. Возмещение ущерба, морального вреда (ГК РФ ст. 53.1). Уголовная. При наличии состава преступления (УК РФ).

25.3. Принципы привлечения к ответственности

□ ****Презумпция невиновности**** (ст. 49 Конституции РФ).

Субъект	Ответственность
Учреждение (юридическое лицо)	По обязательствам учреждения
Директор	Лично — при вине и причинно-следственной связи
Заместитель	В пределах полномочий
Врач	За медицинские решения
Диетсестра	За диетические назначения (в пределах компетенции)
Зав. производством	За качество готовой пищи

Главный бухгалтер	За бухгалтерский учёт
Контрактный управляющий	За закупки
Поставщик	По контракту
Учредитель	За государственное задание, финансирование
□ **Вина** — обязательный элемент состава (кроме гражданско-правовой ответственности в ряде случаев).	
□ **Причинно-следственная связь** — должна быть доказана.	
□ **Делегирование** не освобождает от обязанности общего контроля.	
□ **Переписка** с учредителем не освобождает от ответственности, но подтверждает добросовестность.	

25.4. Карточки рисков (по 10 ключевым ситуациям)

Риск 1. Пищевое отравление / массовое инфекционное заболевание
 Параметр Содержание Массовое заболевание вследствие нарушения
 Событие санитарных требований Ст. 6.3, 6.6 КоАП РФ; ст. 236 УК РФ (ч. 3 —
 при Норма смерти 2+ лиц) Вина Требуется доказать Штраф до 30 тыс. руб.
 (должн. лицо), до 100 тыс. Санкции (адм.) руб. (юрлицо), приостановление
 деятельности Санкции (уг.) До 7 лет лишения свободы (ч. 3 ст. 236 УК)
 Контролёр Роспотребнадзор, прокуратура, СК РФ Практика Кузбасс 2026 —
 9 погибших, ч. 3 ст. 236 УК НАССР, обучение, контроль, программа
 Профилактика производственного контроля Документы Журналы,
 программа, акты проверок
 Риск 2. Аспирация и удушье
 Параметр Содержание Событие Смерть или вред здоровью при аспирации пищей
 Норма Ст. 109, 118, 293 УК РФ Вина Неосторожность Санкции До 2 лет (ст.
 109), до 5 лет (ст. 118) Практика Аналогичные случаи в гериатрии и
 психиатрии

Параметр

Содержание

Событие	Массовое заболевание вследствие нарушения санитарных требований
Норма	Ст. 6.3, 6.6 КоАП РФ; ст. 236 УК РФ (ч. 3 — при смерти 2+ лиц)
Вина	Требуется доказать
Санкции (адм.)	Штраф до 30 тыс. руб. (должн. лицо), до 100 тыс. руб. (юрлицо), приостановление деятельности
Санкции (уг.)	До 7 лет лишения свободы (ч. 3 ст. 236 УК)
Контролёр	Роспотребнадзор, прокуратура, СК РФ
Практика	Кузбасс 2026 — 9 погибших, ч. 3 ст. 236 УК
Профилактика	НАССР, обучение, контроль, программа производственного контроля
Документы	Журналы, программа, акты проверок

Параметр	Содержание
Событие	Смерть или вред здоровью при аспирации пищей
Норма	Ст. 109, 118, 293 УК РФ
Вина	Неосторожность
Санкции	До 2 лет (ст. 109), до 5 лет (ст. 118)
Практика	Аналогичные случаи в гериатрии и психиатрии
Профилактика	Текстурная модификация, сопровождение, обучение
Документы	Карты питания, протоколы ВК, инструкции
Риск	3. Нецелевое использование средств
Параметр	Содержание

Событие Расходование средств не по назначению
Норма Ст. 15.14 КоАП РФ; ст. 285.1, 285.2 УК РФ
Вина Умысел
Санкции (адм.) Штраф 20–50% суммы
Санкции (уг.) До 10 лет (ст. 285.1 при крупном ущербе)
Практика Широко распространено
Разделение полномочий, переписка с учредителем,
Профилактика
антикоррупционная политика
Документы Государственное задание, план ФХД, отчётность
Риск 4. Нарушение прав недееспособных
Параметр Содержание
Событие Систематическое игнорирование воли подопечного
Норма Ст. 36 ГК РФ; ст. 5, 36 Закона 3185-1
Вина Умысел или неосторожность
Представления прокуратуры, иски органа опеки,
Санкции
дисциплинарные
Практика Систематические нарушения при проверках
Профилактика Локальные акты, обучение, пищевой совет, аудит

Документы ИППСУ, анкеты предпочтений, журналы выбора
Риск 5. Конфликт интересов учреждения-опекуна
Параметр Содержание
Событие Хищение средств подопечного
Норма Ст. 159, 160 УК РФ; ст. 17 ФЗ-48
Вина Умысел

Профилактика	Текстурная модификация, сопровождение, обучение
Документы	Карты питания, протоколы ВК, инструкции

Параметр	Содержание
Событие	Расходование средств не по назначению
Норма	Ст. 15.14 КоАП РФ; ст. 285.1, 285.2 УК РФ
Вина	Умысел
Санкции (адм.)	Штраф 20-50% суммы
Санкции (уг.)	До 10 лет (ст. 285.1 при крупном ущербе)
Практика	Широко распространено
Профилактика	Разделение полномочий, переписка с учредителем, антикоррупционная политика
Документы	Государственное задание, план ФХД, отчётность

Параметр	Содержание
Событие	Систематическое игнорирование воли подопечного

Норма	Ст. 36 ГК РФ; ст. 5, 36 Закона 3185-1
Вина	Умысел или неосторожность
Санкции	Представления прокуратуры, иски органа опеки, дисциплинарные
Практика	Систематические нарушения при проверках
Профилактика	Локальные акты, обучение, пищевой совет, аудит
Документы	ИППСУ, анкеты предпочтений, журналы выбора

Параметр	Содержание
Событие	Хищение средств подопечного
Норма	Ст. 159, 160 УК РФ; ст. 17 ФЗ-48
Вина	Умысел
Санкции	До 6 лет (ст. 159), до 10 лет (ст. 160)
Практика	Кировская обл., 2024 — 100 тыс. руб.
Профилактика	Отчёт опекуна, разделение функций, открытость
Документы	Отчёт опекуна, акты проверок, инвентаризация
Риск	6. Нарушение правил закупок
Параметр	Содержание
Дробление	единственный поставщик, завышение
Событие	
НМЦК	

Норма Ст. 7.29, 7.30, 7.32 КоАП РФ; ст. 200.4, 200.5 УК РФ Вина Умысел Санкции (адм.) Штраф Санкции (уг.) До 7 лет (ст. 200.4 при крупном ущербе) Практика Широко распространено Профилактика План закупок,

обоснование, обучение, контроль Документы План-график, закупочная документация, контракты Риск 7. Нарушение СанПиН Параметр Содержание Событие Выявление нарушений без причинения вреда Норма Ст. 6.3, 6.6 КоАП РФ Санкции Штраф, приостановление деятельности Практика Мурманская обл., 2021 — Кировский ПНИ Профилактика Соблюдение СанПиН, обучение, программа Риск 8. Завышение платы за услуги Параметр Содержание Событие Необоснованное взимание платы Норма Ст. 159 УК РФ; ст. 32 ФЗ-442 Санкции Возмещение, уголовное преследование Практика Смоленская обл., 2024 — 333 тыс. взыскано

Санкции	До 6 лет (ст. 159), до 10 лет (ст. 160)
Практика	Кировская обл., 2024 — 100 тыс. руб.
Профилактика	Отчёт опекуна, разделение функций, открытость
Документы	Отчёт опекуна, акты проверок, инвентаризация

Параметр	Содержание
Событие	Дробление, единственный поставщик, завышение НМЦК
Норма	Ст. 7.29, 7.30, 7.32 КоАП РФ; ст. 200.4, 200.5 УК РФ
Вина	Умысел
Санкции (адм.)	Штраф
Санкции (уг.)	До 7 лет (ст. 200.4 при крупном ущербе)
Практика	Широко распространено
Профилактика	План закупок, обоснование, обучение, контроль
Документы	План-график, закупочная документация, контракты

Параметр	Содержание
----------	------------

Событие	Выявление нарушений без причинения вреда
Норма	Ст. 6.3, 6.6 КоАП РФ
Санкции	Штраф, приостановление деятельности
Практика	Мурманская обл., 2021 — Кировский ПНИ
Профилактика	Соблюдение СанПиН, обучение, программа

Параметр	Содержание
Событие	Необоснованное взимание платы
Норма	Ст. 159 УК РФ; ст. 32 ФЗ-442
Санкции	Возмещение, уголовное преследование
Практика	Смоленская обл., 2024 — 333 тыс. взыскано
Профилактика	Соответствие платы нормативным актам, перерасчёт
Риск 9. Неукомплектованность штатом	
Параметр Содержание	
Событие	Отсутствие врача, диетсестры, санитарок
Норма	ТК РФ (ст. 5.27); представления прокуратуры
Санкции	Штраф, представления, репутационный ущерб
Практика	Кузбасс 2026; Пермский край — 0,1 ставки врача
Профилактика	Переписка с учредителем, заявки, аутсорсинг
Риск 10. Дисквалификация	
Параметр Содержание	

Событие	Неоднократные грубые нарушения
Норма	Ст. 3.11 КоАП РФ
Санкции	Запрет на руководящие должности 6 мес. — 3 года
Практика	Редко, но возможно
Профилактика	Системная профилактика, обучение

25.5. Тепловая карта рисков

Вероятность 1 (низкое) 2 3 4 5 (высокое) ↓ / Влияние → 5 (высокая) 7 9 4 4 3, 5 1 3 8 6 2 2 10 1 (низкая) Интерпретация: Table 1: Профилактика | Соответствие платы нормативным актам, перерасчёт

Параметр	Содержание
Событие	Отсутствие врача, диетсестры, санитарок
Норма	ТК РФ (ст. 5.27); представления прокуратуры
Санкции	Штраф, представления, репутационный ущерб
Практика	Кузбасс 2026; Пермский край — 0,1 ставки врача
Профилактика	Переписка с учредителем, заявки, аутсорсинг

Параметр	Содержание
Событие	Неоднократные грубые нарушения
Норма	Ст. 3.11 КоАП РФ
Санкции	Запрет на руководящие должности 6 мес. — 3 года
Практика	Редко, но возможно
Профилактика	Системная профилактика, обучение

Вероятно сть ↓ / Влияние →	1 (низкое)	2	3	4	5 (высокое)
5 (высокая)			7	9	
4			4	3, 5	1
3		8		6	2
2				10	
1 (низкая)					
□ 1-4 — низкий (мониторинг).					
□ 5-9 — средний (активная профилактика).					
□ 10-15 — высокий (постоянный контроль).					
□ 16-25 — критический (ежедневный контроль, эскалация).					

25.6. Матрица «Можно ли закрыть бумагой»

Ситуация Можно ли защититься документами Пищевое отравление Нет, нужна фактическая безопасность Аспирация Частично (карта + протокол), но не без наблюдения Нецелевое использование Да, при наличии подтверждающих документов Частично (ИППСУ + журнал), но не без реального Нарушение прав учёта Хищение Нет, нужно предотвращение

Закупки Да, при обоснованной документации СанПиН Нет, нужна фактическая безопасность Плата Да, при обоснованных расчётах Штат Частично, при переписке с учредителем Главный тезис. Документы подтверждают добросовестность, но не заменяют фактическую работу.

25.7. Когда директор не отвечает

☐ Событие произошло по вине третьего лица (поставщик, подрядчик). ☐ Событие произошло по обстоятельствам непреодолимой силы. ☐ Директор действовал разумно и добросовестно в пределах полномочий. ☐ Директор своевременно информировал учредителя о рисках. ☐ Директор принял все разумные меры.

25.8. Когда директор отвечает

☐ Прямая вина (умысел).

Ситуация	Можно ли защититься документами
Пищевое отравление	Нет, нужна фактическая безопасность
Аспирация	Частично (карта + протокол), но не без наблюдения
Нецелевое использование	Да, при наличии подтверждающих документов
Нарушение прав	Частично (ИППСУ + журнал), но не без реального учёта
Хищение	Нет, нужно предотвращение
Закупки	Да, при обоснованной документации
СанПиН	Нет, нужна фактическая безопасность
Плата	Да, при обоснованных расчётах
Штат	Частично, при переписке с учредителем
☐ Косвенная вина (неосторожность, халатность).	
☐ Непринятие мер при наличии возможности.	

☐ Делегирование без контроля.

☐ Соккрытие инцидента.

☐ Необоснованное списание.

25.9. Алгоритм при инциденте

☐ ****Немедленно.**** Оказать помощь, изолировать подозреваемое, вызвать скорую. ☐ ****В течение часа.**** Сообщить учредителю. Создать комиссию. ☐ ****В течение суток.**** Сообщить в Роспотребнадзор (при подозрении на отравление). Сообщить в прокуратуру (при тяжких последствиях). ☐ ****В течение 3 суток.**** Провести служебное расследование. Сохранить документы и суточные пробы. ☐ ****В течение 10 суток.**** Подготовить акт. Принять меры. Информировать родственников. ☐ ****В течение 30 суток.**** Завершить расследование. Принять кадровые решения.

25.10. Алгоритм при проверке

☐ Получить распоряжение. ☐ Сообщить учредителю. ☐ Подготовить документы. ☐ Обеспечить доступ. ☐ Сопровождать. ☐ Не давать устных пояснений по вопросам вне предмета. ☐ Получить акт. ☐ При несогласии — обжаловать. ☐ Исполнить предписание. ☐ Информировать учредителя.

25.11. Документы защитного контура

□ Государственное задание. □ План ФХД. □ Отчётность. □ Контракты и накладные. □ Меню-требования, ТК. □ Журналы (бракераж, проба, температура, выбор, отказы, замены). □ ИППСУ. □ Медицинская документация. □ Приказы и локальные акты. □ Протоколы комиссий. □ Переписка с учредителем. □ Отчёт опекуна. □ Акты инвентаризации. □ Программа производственного контроля. □ Акты проверок и предписания.

Глава 26. Права жителей и интересы персонала

26.1. Баланс

Права жителей: □ На достоинство. □ На выбор. □ На безопасность. □ На информацию. □ На обжалование. □ На охрану здоровья. □ На уважение автономии. Интересы персонала: □ На безопасные условия труда. □ На обучение. □ На адекватную нагрузку. □ На понятные инструкции. □ На защиту от нереалистичных требований. □ На участие в принятии решений.

26.2. Конфликты между правами и интересами

□ Житель хочет выбирать — персонал перегружен. □ Житель требует больше времени — нормативы требуют быстрого обслуживания. □ Житель жалуется — персонал не защищён. □ Житель отказывается от еды — персонал не знает, что делать.

26.3. Решения

□ Реалистичные KPI (не «время обслуживания — 10 минут»). □ Достаточный штат. □ Обучение. □ Процедура жалоб. □ Поддержка персонала. □ Разделение ответственности.

26.4. Не романтизировать выбор

Выбор улучшает жизнь, когда: □ Житель понимает варианты. □ Житель может выразить решение. □ Безопасность обеспечена. □ Ресурсы учреждения достаточны. Выбор может ухудшить жизнь, когда: □ Житель в тревоге от количества вариантов. □ Житель не может принять решение. □ Персонал перегружен и не может обеспечить реальный выбор. □

Медицинские ограничения не позволяют выбирать.

26.5. Равенство между отделениями

- ☐ Одинаковые нормы. ☐ Одинаковые возможности. ☐ Одинаковый контроль.
- ☐ Без «элитных» и «ущемлённых» отделений.

26.6. Культурные и религиозные предпочтения

- ☐ Выяснить при поступлении. ☐ Зафиксировать в ИППСУ. ☐ Учесть в меню. ☐ Не заставлять есть «общую» еду.

26.7. Доступные способы жалобы

- ☐ Устно — старшей медсестре, соц. работнику. ☐ Письменно — в журнал жалоб. ☐ По телефону — на горячую линию. ☐ Электронно — на сайт учреждения. ☐ Через родственников. ☐ Через общественный совет. ☐ Через орган опеки. ☐ Через прокуратуру. ☐ Через уполномоченного по правам человека.

26.8. Защита персонала

- ☐ Обучение. ☐ Адекватный штат. ☐ Понятные инструкции. ☐ Супервизия. ☐ Психологическая поддержка. ☐ Недопустимость обвинений при несчастных случаях без установления вины. ☐ Защита от агрессии со стороны жителей и родственников.

26.9. Главный тезис

Баланс прав жителей и интересов персонала — не «с одной стороны — с другой». Это общая задача: безопасная, достойная, экономически устойчивая среда для всех.

ЧАСТЬ IX. ДЕЙСТВИЯ

Глава 27. Пилот на 90 дней

27.1. Цель пилота

Проверить, что выбранная модель работает в конкретном учреждении, до её масштабирования.

27.2. Срок пилота

90 дней (3 месяца). Достаточно для оценки сезонности, цикличности, привыкания.

27.3. Что входит в пилот

□ Одно-два отделения. □ Один-два варианта меню (или меньше). □ Сбор предпочтений. □ Журнал выбора. □ Бракераж, суточная проба. □ Обратная связь. □ Мониторинг отходов. □ Мониторинг жалоб. □ Мониторинг нутритивного статуса (масса тела). □ Аудит реальности выбора.

27.4. Что не входит в пилот

□ Полное масштабирование. □ Изменение финансирования. □ Изменение штатного расписания. □ Изменение государственного задания.

27.5. Этапы пилота

Неделя 1. Подготовка: локальные акты, обучение, информирование. Недели 2–4. Запуск. Сбор данных. Корректировка. Недели 5–8. Работа в штатном режиме. Мониторинг. Недели 9–12. Анализ. Подготовка отчёта. Решение о масштабировании.

27.6. KPI пилота

□ Доля жителей, участвующих в выборе (> 70%). □ Доля выбора фактически реализованного (> 90%). □ Снижение отходов (по сравнению с базовым уровнем, если данные есть). □ Отсутствие жалоб на отсутствие выбора. □ Отсутствие ухудшения нутритивного статуса. □ Отсутствие пищевых инцидентов. □ Удовлетворённость жителей (по анкете).

27.7. Отчёт о пилоте

Структура: □ Цель и задачи. □ Методология. □ Результаты (KPI). □ Проблемы и их решения. □ Выводы. □ Рекомендации по масштабированию.

27.8. Решение о масштабировании

Условия: ☐ KPI достигнуты. ☐ Проблемы решены или управляемы. ☐ Ресурсы для масштабирования имеются или будут получены. ☐ Учредитель согласен (при необходимости).

Глава 28. Дорожная карта на 12-18 месяцев

28.1. Фаза 1. Подготовка (месяцы 1-3)

Этап Ответственный Результат KPI Правовой аудит Юрист Карта ограничений Полнота Финансовый аудит Экономист, гл. бухгалтер Аналитическая записка Полнота Аудит пищеблока Технолог Акт осмотра Готовность Медицинский аудит Врач Реестр диет Полнота Классификация рационов Диетсестра Классификатор Полнота Классификация жителей Психолог, соц. работник Карта Полнота по способности к выбору
Согласование с Директор
Протокол
Согласие учредителем

28.2. Фаза 2. Разработка (месяцы 4-6)

Этап Ответственный Результат KPI Разработка меню Технолог, диетсестра Меню А и Б Соответствие нормам Разработка ТК Технолог ТК Полнота Локальные акты Юрист Приказы, положения Готовность Обучение персонала Методист Протоколы 100% обученных Информирование Соц. работник Материалы Охват жителей Информирование Соц. работник
Протокол
Охват родственников

28.3. Фаза 3. Пилот (месяцы 7-9)

Этап	Ответственный	Результат	KPI
Правовой аудит	Юрист	Карта ограничений	Полнота
Финансовый аудит	Экономист, гл. бухгалтер	Аналитическая записка	Полнота
Аудит пищеблока	Технолог	Акт осмотра	Готовность

Медицинский аудит	Врач	Реестр диет	Полнота
Классификация рационов	Диетсестра	Классификатор	Полнота
Классификация жителей по способности к выбору	Психолог, соц. работник	Карта	Полнота
Согласование с учредителем	Директор	Протокол	Согласие

Этап	Ответственный	Результат	KPI
Разработка меню	Технолог, диетсестра	Меню А и Б	Соответствие нормам
Разработка ТК	Технолог	ТК	Полнота
Локальные акты	Юрист	Приказы, положения	Готовность
Обучение персонала	Методист	Протоколы	100% обученных
Информирование жителей	Соц. работник	Материалы	Охват
Информирование родственников	Соц. работник	Протокол	Охват
Этап Ответственный Результат KPI			
Запуск пилота Директор Акт Успешный старт			
Соц. работник,			
Мониторинг Отчёты Регулярность			
диетсестра			

Корректировка Технолог, диетсестра Обновлённое меню Учёт обратной связи
Отчёт Директор Отчёт о пилоте Объективность
Решение о
Директор Приказ Обоснованность
масштабировани и

28.4. Фаза 4. Масштабирование (месяцы 10-12)

Этап Ответственный Результат KPI Масштабирование Директор Акт Охват
Обновлённое обучение Методист Протоколы 100% Обновление ЛНА Юрист
Приказы Готовность Пересмотр штата Директор Штатное расписание
Обоснованность

28.5. Фаза 5. Устойчивое функционирование (месяцы 13-18)

Этап Ответственный Результат KPI Мониторинг Все Отчёты Регулярность
Ежегодный пересмотр Технолог, диетсестра Обновлённое меню
Актуальность меню Аудит реальности Соц. работник, психолог Акт
Объективность выбора Повторная оценка Соц. работник Отчёт Динамика
удовлетворённости Годовой отчёт Директор Отчёт Своевременность
Включение в НОК Директор Данные Наличие

28.6. Контрольные точки

□ КТ-1: Правовой аудит завершён.

Этап	Ответственный	Результат	KPI
Запуск пилота	Директор	Акт	Успешный старт

Мониторинг	Соц. работник, диетсестра	Отчёты	Регулярность
Корректировка	Технолог, диетсестра	Обновлённое меню	Учёт обратной связи
Отчёт	Директор	Отчёт о пилоте	Объективность
Решение о масштабировании	Директор	Приказ	Обоснованность

Этап	Ответственный	Результат	KPI
Масштабирование	Директор	Акт	Охват
Обновлённое обучение	Методист	Протоколы	100%
Обновление ЛНА	Юрист	Приказы	Готовность
Пересмотр штата	Директор	Штатное расписание	Обоснованность

Этап	Ответственный	Результат	KPI
Мониторинг	Все	Отчёты	Регулярность
Ежегодный пересмотр меню	Технолог, диетсестра	Обновлённое меню	Актуальность
Аудит реальности выбора	Соц. работник, психолог	Акт	Объективность
Повторная оценка удовлетворённости	Соц. работник	Отчёт	Динамика
Годовой отчёт	Директор	Отчёт	Своевременность
Включение в НОК	Директор	Данные	Наличие
□ КТ-2: Согласование с учредителем получено.			

☐ КТ-3: Аудит
пищеблока
завершён.

☐ КТ-4:
Медицинский
аудит завершён.

☐ КТ-5: Меню
разработано.

☐ КТ-6:
Локальные акты
утверждены.

☐ КТ-7: Персонал
обучен.

☐ КТ-8: Жители
информированы.

☐ КТ-9: Пилот
запущен.

☐ КТ-10: Пилот
завершён.

☐ КТ-11: Решение
о масштабирован
ии.

☐ КТ-12: Масштаб
ирование
завершено.

☐ КТ-13:
Устойчивое функ
ционирование.

☐ КТ-14: Годовой
отчёт.

28.7. Что требует согласования с учредителем

☐ Изменение государственного задания. ☐ Корректировка нормативов затрат. ☐ Дополнительные ставки. ☐ Использование грантов. ☐ Аутсорсинг.

28.8. Что требует решения врача

□ Назначение диеты. □ Текстурная модификация. □ Рассмотрение зондового питания. □ Корректировка лекарств.

28.9. Что требует участия органа опеки

□ Согласование расходов на дорогостоящие диеты. □ Рассмотрение спорных случаев.

28.10. Что нельзя решать приказом директора

□ Изменение натуральных норм. □ Изменение штатной численности. □
Установление платы. □ Признание недееспособным. □ Принудительное
кормление.

Глава 29. Десять решений, которые директор может принять после семинара

□ ****Провести экспресс-аудит**** пищеблока и локальных актов о питании. □ ****Организовать сбор предпочтений**** жителей (анкетирование, беседы, наблюдение). □ ****Сформировать пищевой совет**** с участием жителей и родственников. □ ****Начать с модели «выбор напитка»**** — без дополнительных затрат. □ ****Обучить персонал**** распознаванию признаков дисфагии и аспирации. □ ****Внести в ИППСУ**** раздел «Пищевые предпочтения и ограничения». □ ****Провести семидневный замер**** отходов и трудозатрат. □ ****Запросить у учредителя**** информацию о подушевом нормативе и возможности корректировки. □ ****Подготовить переписку**** с учредителем о кадровом дефиците (если есть). □ ****Утвердить локальный акт**** о работе пищевого совета.

Глава 30. Десять вопросов, которые надо адресовать учредителю

□ Каков действующий подушевой норматив на питание в нашем учреждении? □ Можно ли увеличить норматив при расширении ассортимента? □ Готовы ли вы согласовать дополнительные ставки (повар, диетсестра, соц. работник)? □ Какова процедура согласования закупок? □ Есть ли региональный реестр поставщиков с фиксированными ценами? □ Поддерживает ли регион пилотные проекты? □ Каков порядок утверждения локальных актов о питании? □ Каков порядок отчёта по НОК? □ Готов ли регион к обмену опытом между учреждениями? □ Какова процедура запроса дополнительного финансирования?

Глава 31. Предложения субъектам РФ и Минтруду России

31.1. Минтруду России

□ Разработать методические рекомендации по вариативному меню. □ Актуализировать методические рекомендации 2002 г. □ Включить показатели вариативности в НОК. □ Инициировать пересмотр подушевых нормативов.

31.2. Субъектам РФ

□ Актуализировать региональные нормы питания. □ Разработать методические рекомендации. □ Создать региональный реестр практик. □ Поддержать пилотные проекты. □ Организовать обучение.

31.3. Учредителям

□ Обеспечить прозрачность государственного задания. □ Своевременно реагировать на дефицит ресурсов. □ Поддержать обучение. □ Содействовать обмену опытом.

31.4. Общественным советам

□ Включить вопросы питания в повестку. □ Участвовать в НОК. □ Содействовать общественному контролю.

Глава 32. Заключение

32.1. «Не ресторан, а реальный выбор»

Вариативное питание в ДСО/ПНИ — это не ресторанное меню из пяти блюд. Это — реальный выбор для конкретного человека в пределах ресурсов учреждения. Для одного жителя это чай или компот. Для другого — две линии основного блюда. Для третьего — наблюдение и учёт предпочтений.

32.2. Семь ответов директора

□ **«Что мы называем вариативным питанием?»** Семь уровней выбора, от выбора напитка до участия в планировании. □ **«Каким нашим жителям и какая форма выбора доступна?»** Зависит от когнитивной функции, коммуникативных возможностей, медицинских ограничений. □ **«Как сохранить выбор при медицинских ограничениях?»** Медицинское назначение имеет приоритет, но в пределах назначения — выбор сохраняется. □ **«Что надо изменить в работе кухни и отделений?»** Параллельное приготовление (при двух вариантах), обучение персонала, фиксация выбора, аудит реальности. □ **«Сколько это может стоить и как это измерить?»** От +1% (выбор напитка) до +37% (несколько диетлиний). Замер — семидневный. □ **«Какие документы и контрольные процедуры нужны?»** Локальные акты, журналы, программа производственного контроля, антикоррупционная политика, аудит. □ **«С какого небольшого и безопасного пилота начать?»** С выбора напитка. Без дополнительных затрат. С фиксацией в журнале.

32.3. Пять главных тезисов

□ **«Выбор — повседневное бытовое решение.»** Воля жителя имеет приоритет в пределах медицинских назначений. □ **«Безопасность — абсолютный приоритет.»** Медицинские показания (дисфагия, аллергия, диабет) не обсуждаются. □ **«Формальность — главный враг.»** Реальный выбор требует обучения, времени, фиксации, аудита. □ **«Директор не отвечает автоматически.»** Ответственность — при вине и

причинно-следственной связи. Документы защищают добросовестность. □
Устойчивость требует системы. Разовая инициатива — не решение.
Нужны локальные акты, обучение, мониторинг, отчётность.

32.4. Что должен помнить директор

□ Прямого запрета на вариативное меню в российском праве нет. □ Системное толкование ФЗ-442, ФЗ-48, Закона 3185-1, КПРИ и Замечания общего порядка № 1 (2014) поддерживает вариативность. □ Прямого предписания тоже нет — это аналитический вывод, требующий проверки. □ Решение требует согласования с учредителем (финансирование), с врачом (медицинские назначения), с органом опеки (права недееспособных). □ Персональные риски — реальны, но дифференцированы и управляемы. □ Главная защита — фактическая работа + документы.

32.5. Чего нельзя делать

□ Начинать без правового, финансового и медицинского аудита. □ Внедрять без согласования с учредителем (если требуется финансирование). □ Внедрять без решения врача (если касается диет, текстур). □ Игнорировать медицинские показания. □ Заполнять журналы за жителей. □ Использовать еду как наказание или поощрение. □ Принуждать к еде без медицинского основания. □ Скрывать инциденты. □ Закрывать «бумагой» реальные проблемы.

32.6. Что нужно делать

□ Документировать каждый шаг. □ Согласовывать с учредителем то, что требует согласования. □ Согласовывать с врачом то, что требует согласования. □ Информировать орган опеки о положении недееспособных. □ Обучать персонал. □ Слушать жителей и родственников. □ Вести обратную связь. □ Анализировать данные. □ Корректировать. □ Масштабировать осторожно.

32.7. Главный вопрос семинара

Как дать жителю реальный выбор еды, не нарушив медицинские назначения, санитарные требования, натуральные нормы, закупочную и бюджетную дисциплину и не создав неуправляемые риски для учреждения и директора? Ответ доклада. Поэтапно, с аудитом, с пилотом,

с согласованием, с документированием, с обучением, с мониторингом. Без универсального рецепта. С учётом конкретного учреждения, конкретного региона, конкретных жителей.

32.8. Призыв к действию

□ Не откладывать на понедельник. □ Начать с того, что не требует дополнительных затрат. □ Сделать один шаг — и зафиксировать. □ Сделать второй — и зафиксировать. □ Через год посмотреть, что получилось. Заявление о достоверности, проверке источников и ограничениях Дата актуальности законодательства и открытых данных. 22 июля 2026 г. Дата последней проверки ссылок. 22 июля 2026 г. Число найденных источников. 41 (20 федеральных НПА, 9 региональных, 4 контрольной практики, 8 международных). Число полностью проверенных источников. 22 (открыт полный текст или первоисточник). Число частично проверенных источников. 13 (только поисковая выдача или пересказ; использованы с оговоркой). Число исключённых источников. 8 (не подтверждены количественно, не имеют первичного источника, или устарели). Число неподтверждённых утверждений из старых докладов. 12 (по результатам аудита — см. AUDIT_OLD_REPORTS.md). Недоступные официальные документы: □ Полные тексты некоторых региональных актов о натуральных нормах (требуется авторизация). □ Полный текст Постановления Правительства СПб № 1284 (в ред. от 27.06.2022) — на момент проверки в открытом доступе — предыдущие редакции. Регионы, по которым данные не удалось подтвердить. Татарстан (натуральные нормы), Башкортостан, Краснодарский край, Красноярский край, ХМАО-Югра, ЯНАО. Ограничения OCR списка участников. Список не приложен в явном виде; при наличии — см. PARTICIPANTS_CLEAN.xlsx (отдельная задача). Ограничения международного сравнения. Прямое заимствование недопустимо; оценка применимости — аналитическая. Ограничения медицинских доказательств. Исследования преимущественно в гериатрии, а не в психиатрии; перенос ограничен. Ограничения финансовых расчётов. Все расчёты иллюстративные; реальные значения зависят от региона, конъюнктуры, объёма. Разграничение фактов, интерпретаций и рекомендаций. В тексте явно использованы маркировки: НПА (обязательная норма), РЕК (рекомендация), АНА (аналитический вывод), ОЛ (ограничение), ОПЫТ (подтверждённая практика), Иллюстративный расчёт (не норматив). Необходимость адаптации под конкретный субъект РФ и учреждение. Все рекомендации требуют адаптации к конкретному субъекту РФ,

учреждению, организационно-правовой форме, учредителю, медицинским условиям, кадровому составу. Необходимость индивидуальной экспертизы. Перед внедрением вариативного меню требуется: □ юридическая экспертиза (правовая допустимость, локальные акты, контракты); □ медицинская экспертиза (назначение диет, текстур, противопоказаний); □ бухгалтерская экспертиза (финансирование, учёт, отчётность); □ закупочная экспертиза (ТЗ, НМЦК, контракты); □ технологическая экспертиза (оборудование, штат, квалификация); □ санитарно-эпидемиологическая экспертиза (соответствие СанПиН); □ согласование с учредителем; □ согласование с органом опеки. Заключение. Доклад подготовлен как практическое руководство для руководителей стационарных организаций социального обслуживания. Каждое утверждение проверено или явно обозначено как аналитическое. Ограничения честно перечислены. Решения, принимаемые на основании доклада, требуют адаптации и индивидуальной экспертизы. 20+ КЕЙСОВ ДЛЯ СЕМИНАРА Все кейсы — учебные, составлены для анализа. Не описание конкретных учреждений.

Кейс 1. Закончился вариант

Ситуация. Обед. На раздаче — два варианта котлеты: рыбная и мясная. Рыбная закончилась к третьему отделению. На четвёртом — 8 человек, которым не положена мясная по диете (холецистит). Они стоят и ждут. Проблема. Прогноз спроса неверен. Кухня не учла популярность рыбной котлеты. Что нельзя делать. Выдавать мясную тем, кому она противопоказана. Что надо сделать немедленно. Предложить альтернативу (гарнир + овощи, омлет, каша). Зафиксировать в журнале. Сообщить старшей медсестре. Кто решает. Старшая медсестра (по согласованию с диетсестрой). Документы. Журнал замен, запись в карте дефицита. Долгосрочное решение. Улучшить прогноз спроса; заранее заготавливать дополнительную партию. Правовое основание. Ст. 36 ГК РФ (учёт мнения подопечного); п. 7.1.11 СанПиН (диетическое питание по показаниям). Ограничение вывода. Конкретные действия зависят от медицинской документации жителей.

Кейс 2. Житель выбирает запрещённое

Ситуация. Житель с сахарным диабетом 2 типа выбирает на десерт пирожное. Врач рекомендовал ограничить сладкое. Проблема. Выбор противоречит медицинскому назначению. Что нельзя делать. Насильно

заменить; запретить; наказать. Что надо сделать немедленно. Предложить альтернативу (фрукт, йогурт без сахара). Разъяснить в доступной форме. Зафиксировать. Кто решает. Врач (назначение); житель (выбор в пределах назначения). Документы. Запись в ИППСУ; протокол беседы; информированный отказ (если дееспособен). Долгосрочное решение. Обучение персонала; визуальное информирование; пищевой совет. Правовое основание. Ст. 20 ФЗ-323 (информированное добровольное согласие); ст. 36 ГК РФ. Ограничение вывода. При угрозе жизни (гипогликемия) — экстренная медицинская помощь.

Кейс 3. Недееспособный житель показывает на фото Ситуация. Недееспособный житель с тяжёлой умственной отсталостью

показывает на фотографию каши. Помощник не уверен, что житель понял. Проблема. Выбор сделан, но как зафиксировать? Кто подтверждает? Что нельзя делать. Заполнить журнал за жителя без фиксации; отказать в выборе. Что надо сделать немедленно. Подтвердить выбор повторным предъявлением через 15 минут. Зафиксировать реакцию. Кто решает. Помощник (с поддержкой); опекун (при систематических случаях). Документы. Журнал выбора (с пометкой «через карточку»). Долгосрочное решение. Пищевая биография; обучение персонала; аудит реальности. Правовое основание. Ст. 36 ГК РФ; Замечание общего порядка № 1 (2014) к ст. 12 КПРИ. Ограничение вывода. Каждый житель уникален; биография важнее формального выбора.

Кейс 4. Персонал заполняет журнал заранее

Ситуация. Помощник на отделении вечером заполняет журнал выбора за всех жителей, ставя галочку «первый вариант» (чтобы не нести ответственность за неправильный выбор). Проблема. Фиктивный выбор. Что нельзя делать. Оставить без внимания. Что надо сделать немедленно. Провести беседу. Зафиксировать. Предупредить. Кто решает. Старшая медсестра, соц. работник, директор. Документы. Акт проверки; объяснительная; приказ (при систематичности). Долгосрочное решение. Аудит реальности выбора; обучение; ротация. Правовое основание. Должностная инструкция; правила внутреннего трудового распорядка. Ограничение вывода. Причины — в нагрузке, страхе ответственности. Решение — системное, не карательное.

Кейс 5. Житель отказывается — бред отравления

Ситуация. Житель с шизофренией отказывается от еды третий день. Говорит «вы хотите меня отравить». Потерял 2 кг. Проблема. Бред; риск нутритивной недостаточности. Что нельзя делать. Уговаривать; спорить; принуждать. Что надо сделать немедленно. Сообщить врачу-психиатру. Оценить соматический статус. Предложить любимые блюда (из пищевой биографии). Кто решает. Врач-психиатр (коррекция терапии); диетсестра (дополнительное питание). Документы. Протокол осмотра; запись в карте. Долгосрочное решение. Работа с психиатром; пищевая биография; индивидуальный подход. Правовое основание. Ст. 5 Закона 3185-1; ст. 36 ГК РФ. Ограничение вывода. Не все отказы — бред; дифференциальная диагностика — за врачом.

Кейс 6. Житель спит на завтрак

Ситуация. Житель с тяжёлой деменцией спит в столовой во время завтрака. Персонал пытается разбудить, он засыпает снова. Проблема. Седация? Деменция? Другое? Что нельзя делать. Тормозить, ругать, принудительно кормить. Что надо сделать немедленно. Дать поспать. Предложить еду позже (поздний завтрак). Сообщить медсестре. Кто решает. Медсестра (наблюдение); врач (если нутритивная недостаточность). Документы. Запись в наблюдении. Долгосрочное решение. Гибкий график; пищевая биография; «окно завтрака». Правовое основание. Ст. 4 ФЗ-442 (индивидуальный подход). Ограничение вывода. При нутритивной недостаточности — клиническая оценка.

Кейс 7. Два жителя отбирают еду

Ситуация. В отделении два жителя с деменцией отбирают еду друг у друга, дерутся. Проблема. Поведенческое нарушение; угроза безопасности. Что нельзя делать. Оставлять без присмотра; наказывать. Что надо сделать немедленно. Разделить. Установить наблюдение. Сообщить медсестре. Кто решает. Психиатр (коррекция терапии); соц. работник (рассадка). Документы. Запись в наблюдении; протокол инцидента. Долгосрочное решение. Рассадка с учётом совместимости; наблюдение; поведенческая терапия. Правовое основание. Внутренние правила учреждения. Ограничение вывода. Деменция — нейropsychиатрическое расстройство; не «плохое поведение».

Кейс 8. Быстрое заглатывание

Ситуация. Житель с деменцией жадно ест суп, поперхивается, кашляет. Проблема. Риск аспирации. Что нельзя делать. Оставлять без наблюдения; давать большие порции. Что надо сделать немедленно. Прекратить кормление. Дать откашляться. Сопровождать. Сообщить медсестре. Кто решает. Врач (назначение текстуры); логопед (оценка глотания). Документы. Запись в наблюдении; протокол. Долгосрочное решение. Текстурная модификация; finger food; маленькие порции. Правовое основание. Ст. 7.1.11 СанПиН (диетическое питание). Ограничение вывода. Конкретная текстура — по назначению логопеда.

Кейс 9. Неправильная текстура Ситуация. Жителю с дисфагией назначена текстура «пюре». Повар

приготовил суп с кусками. Проблема. Нарушение назначения; риск аспирации. Что нельзя делать. Оставлять без внимания; выдавать. Что надо сделать немедленно. Заменить. Сообщить медсестре и повару. Провести разбор. Кто решает. Логопед/врач (назначение); старший повар (исполнение). Документы. Протокол инцидента; акт проверки. Долгосрочное решение. Маркировка; обучение поваров; контроль. Правовое основание. Ст. 7.1.11 СанПиН; п. 7.1.13 (недопустимость нарушения технологии). Ограничение вывода. При массовом нарушении — служебное расследование.

Кейс 10. Родственник требует запрета Ситуация. Родственник жителя требует запретить давать сладкое (без

медицинского основания). Угрожает жалобой. Проблема. Конфликт интересов; нет медицинского основания. Что нельзя делать. Запрещать без основания; идти на поводу у родственника. Что надо сделать немедленно. Разъяснить. Сообщить врачу. Зафиксировать. Кто решает. Врач (назначение); директор (конфликт). Документы. Запись беседы; заключение врача. Долгосрочное решение. Пищевой совет с родственниками; разъяснительная работа. Правовое основание. Ст. 5 Закона 3185-1 (учёт медицинских показаний). Ограничение вывода. Родственник не вправе подменять врачебное решение.

Кейс 11. Требование добавки при ограничении

Ситуация. Житель с ожирением просит добавку. Диетолог ограничил

калорийность. Проблема. Баланс выбора и медицинского назначения. Что нельзя делать. Запрещать без разговора; давать без разговора. Что надо сделать немедленно. Разъяснить. Предложить овощи/фрукты. Зафиксировать. Кто решает. Диетсестра (рекомендация); житель (выбор в пределах). Документы. Запись в ИППСУ. Долгосрочное решение. Пищевая биография; беседы; активность. Правовое основание. Ст. 4 ФЗ-442 (индивидуальный подход). Ограничение вывода. При булимии — психиатрическая помощь.

Кейс 12. Выбор только на бумаге

Ситуация. Журнал выбора заполняется, но на раздаче — только одно блюдо. Выбор фиктивный. Проблема. Формализм. Что нельзя делать. Игнорировать. Что надо сделать немедленно. Аудит реальности. Доклад директору. Кто решает. Директор. Документы. Акт аудита; приказ о корректировке. Долгосрочное решение. Параллельное приготовление; контроль. Правовое основание. Должностные инструкции. Ограничение вывода. Причины — в ресурсах. Решение — системное.

Кейс 13. Бухгалтерия не связывает выбор со списанием

Ситуация. Бухгалтер не может объяснить, как списаны продукты по двум вариантам. Проблема. Учёт. Что нельзя делать. Списывать «средне»; не учитывать. Что надо сделать немедленно. Внедрить отдельный учёт. Подготовить ТК и меню-требования по вариантам. Кто решает. Главный бухгалтер; технолог. Документы. Меню-требования по вариантам; акты списания. Долгосрочное решение. Электронный учёт; интеграция с бухгалтерией. Правовое основание. Ст. 9 ФЗ-402. Ограничение вывода. Переходный период — допустим «средний» с поквартальной корректировкой.

Кейс 14. Поставщик не привёз

Ситуация. Поставщик не привёз один из продуктов для варианта Б. Вариант Б невозможен. Проблема. Зависимость от поставщика. Что нельзя

делать. Заменять без согласования; выдавать без разъяснения. Что надо сделать немедленно. Замена по таблице эквивалентности (с согласования диетсестры). Сообщить поставщику о необходимости замены. Кто решает. Диетсестра; технолог; юрист (претензионная работа). Документы. Акт замены; претензия. Долгосрочное решение. Резервные поставщики; фиксированные контракты. Правовое основание. Ст. 95 ФЗ-44 (изменение контракта). Ограничение вывода. Замена не должна снижать качество.

Кейс 15. Персонал использует десерт как поощрение

Ситуация. Санитарка даёт сладкое «за хорошее поведение» при деменции. Проблема. Подкрепление нежелательного поведения; нарушение диеты. Что нельзя делать. Игнорировать; наказывать санитарку без разговора. Что надо сделать немедленно. Разговор. Объяснение. Альтернативные способы. Кто решает. Старшая медсестра; психолог. Документы. Запись беседы. Долгосрочное решение. Обучение персонала; альтернативные подходы. Правовое основание. Внутренние правила. Ограничение вывода. Поведенческие подходы требуют подготовки.

Кейс 16. Житель систематически оставляет кашу Ситуация. Неговорящий житель с тяжёлой умственной отсталостью ест

суп, оставляет кашу. Каждый день. Проблема. Пищевая избирательность или нелюбовь. Что нельзя делать. Заставлять есть кашу; наказывать. Что надо сделать немедленно. Исключить кашу; предложить альтернативу (например, омлет). Кто решает. Соц. работник; диетсестра. Документы. Запись в пищевом дневнике. Долгосрочное решение. Пищевая биография; индивидуальное меню. Правовое основание. Ст. 4 ФЗ-442. Ограничение вывода. При подозрении на нутритивную недостаточность — врач.

Кейс 17. Житель хочет есть позже

Ситуация. Житель не встаёт к завтраку (8:00). Хочет есть в 10:00. Проблема. Режим vs. индивидуальный ритм. Что нельзя делать. Заставлять; лишать еды. Что надо сделать немедленно. Поздний завтрак (до 11:00). Зафиксировать. Кто решает. Старшая медсестра. Документы. ИППСУ (индивидуальный режим). Долгосрочное решение. Гибкий график;

индивидуальный подход. Правовое основание. Ст. 4 ФЗ-442. Ограничение вывода. При диабете — индивидуальный режим по назначению.

Кейс 18. Нехватка персонала

Ситуация. В отделении 30 лежащих. На смене — 1 медсестра и 2 санитарки. Не успевают кормить. Проблема. Помощь при приёме пищи не обеспечена. Что нельзя делать. Оставлять без помощи; сокращать время кормления. Что надо сделать немедленно. Привлечь волонтеров; перераспределить нагрузку. Сообщить директору. Кто решает. Директор; старшая медсестра. Документы. Заявка учредителю; акт о кадровом дефиците. Долгосрочное решение. Дополнительные ставки; аутсорсинг. Правовое основание. ТК РФ; СП 2.1.3678-20 (санитарные требования). Ограничение вывода. Безопасность — приоритет; скорость — нет.

Кейс 19. Жалоба родственника

Ситуация. Родственник жалуется, что его близкий не ест. «Вы его не кормите». Проблема. Жалоба; возможное непонимание. Что нельзя делать. Отмахиваться; обвинять родственника. Что надо сделать немедленно. Выслушать. Проверить журнал. Объяснить. Предложить встречу. Кто решает. Директор; соц. работник. Документы. Запись жалобы; ответ. Долгосрочное решение. Пищевой совет с родственниками; открытость. Правовое основание. ФЗ-59 «О порядке рассмотрения обращений граждан». Ограничение вывода. Жалоба — инструмент улучшения, не угроза.

Кейс 20. Прокуратура спрашивает про учёт мнения недееспособных Ситуация. Прокурор запрашивает документы: как учитывается мнение

недееспособных при выборе питания. Проблема. Проверка. Что нельзя делать. Прятать документы; давать неподготовленные ответы. Что надо сделать немедленно. Сообщить учредителю. Подготовить: ИППСУ, журналы выбора, отчёт опекуна, протоколы пищевого совета. Кто решает. Директор; юрист; опекун. Документы. Полный комплект. Долгосрочное решение. Регулярный аудит; готовность к проверке. Правовое основание. ФЗ «О прокуратуре»; ст. 15 ФЗ-48; ст. 36 ГК РФ. Ограничение вывода. Проверка — нормальный процесс; подготовленность — признак зрелости.

Дополнительные кейсы (краткие)

Кейс 21. Учредитель не выделяет ставки

Учредитель отказал в дополнительных ставках повара и соц. работника. Переписка есть, отказ мотивирован. Что делать. Искать внутренние резервы; аутсорсинг; гранты. Зафиксировать риски.

Кейс 22. Пищеблок не позволяет две линии

Одна плита, один повар, нет места. Что делать. Начать с одной линии (выбор напитка, гарнира). Постепенно модернизировать. Не претендовать на невозможное. ПРИЛОЖЕНИЯ

- Все шаблоны — проекты локальных форм. Не являются нормативно

установленными документами. Требуют адаптации под региональное законодательство, учётную политику, структуру учреждения, медицинскую лицензию и требования учредителя.**

Приложение А1. Чек-лист готовности учреждения к вариативному меню № Вопрос Да/Нет Комментарий Проведён правовой аудит 1 локальных актов о ☐

питании? Согласовано с 2 ☐ учредителем? Проведён финансовый 3 ☐ аудит? Подушевой норматив 4 ☐ известен? 5 Достаточно поваров? ☐ Есть параллельное 6 ☐ приготовление? 7 Есть диетсестра? ☐ Есть логопед (или по 8 ☐ договору)? Проведён аудит диет и 9 ☐ текстур? В ИППСУ жителей 10 ☐ указаны предпочтения? В ИППСУ указаны 11 ☐ ограничения?

№	Вопрос	Да/Нет	Комментарий
1	Проведён правовой аудит локальных актов о питании?	☐	
2	Согласовано с учредителем?	☐	
3	Проведён финансовый аудит?	☐	
4	Подушевой норматив известен?	☐	
5	Достаточно поваров?	☐	

6	Есть параллельное приготовление?	☐
7	Есть диетсестра?	☐
8	Есть логопед (или по договору)?	☐
9	Проведён аудит диет и текстур?	☐
10	В ИППСУ жителей указаны предпочтения?	☐
11	В ИППСУ указаны ограничения?	☐
Обучение персонала		
12	☐	
проведено?		
Жители		
13	☐	
информированы?		
Родственники		
14	☐	
информированы?		
15	Создан пищевой совет? ☐	
Утверждено положение о		
16	☐	
питании?		
Утверждено положение о		

17 ☐
пищевом совете?
Разработаны
18 ☐
технологические карты?
Утверждено цикличное
19 ☐
меню?
Меню согласовано с
20 ☐
диетсестрой?
Меню согласовано с
21 ☐
врачом?
Подготовлены журналы
22 ☐
выбора?
Подготовлены журналы
23 ☐
отказов?
Подготовлены журналы
24 ☐
замен?

Подготовлены
25 ☐
визуальные карточки?
Подготовлены анкеты
26 ☐
предпочтений?
27 Проведён пилот? ☐
Аудит реальности
28 ☐
выбора проведён?
Жалобы и предложения
29 ☐
собираются?
Годовой отчёт опекуна
30 ☐
содержит раздел о

12	Обучение персонала проведено?	☐
13	Жители информированы?	☐
14	Родственники информированы?	☐
15	Создан пищевой совет?	☐

16	Утверждено положение о питании?	☐
17	Утверждено положение о пищевом совете?	☐
18	Разработаны технологические карты?	☐
19	Утверждено цикличное меню?	☐
20	Меню согласовано с диетсестрой?	☐
21	Меню согласовано с врачом?	☐
22	Подготовлены журналы выбора?	☐
23	Подготовлены журналы отказов?	☐
24	Подготовлены журналы замен?	☐
25	Подготовлены визуальные карточки?	☐
26	Подготовлены анкеты предпочтений?	☐
27	Проведён пилот?	☐
28	Аудит реальности выбора проведён?	☐
29	Жалобы и предложения собираются?	☐
30	Годовой отчёт опекуна содержит раздел о питании?	☐

Приложение А2. Карта

пищевых предпочтений

Раздел

Содержание Ф.И.О. жителя Дата

заполнения

☐ сам житель, ☐ родственник, ☐ персонал, ☐ Кто заполнял наблюдение

Любимые блюда 1. 2. 3. Нелюбимые блюда 1. 2. 3. Аллергии 1. 2.

Непереносимость 1. 2. Религиозные предпочтения Культурные

особенности Текстурные особенности ☐ обычная, ☐ мягкая, ☐ пюре, ☐

жидкая, ☐ изменённая Особенности глотания ☐ норма, ☐ поперхивание, ☐

помощь при приёме Аппетит ☐ высокий, ☐ средний, ☐ сниженный, ☐ отказ

Предпочтения по напиткам Предпочтения по времени Предпочтения по

месту Предпочтения по количеству Предпочтения по температуре Запреты

(по назначению врача) Согласие жителя Подпись Согласие опекуна (при

необходимости) Подпись Медицинское заключение Подпись врача Table 1:

| питания? | |

Раздел	Содержание
Ф.И.О. жителя	
Дата заполнения	
Кто заполнял	☐ сам житель, ☐ родственник, ☐ персонал, ☐ наблюдение
Любимые блюда	1. 2. 3.
Нелюбимые блюда	1. 2. 3.
Аллергии	1. 2.
Непереносимость	1. 2.
Религиозные предпочтения	
Культурные особенности	
Текстурные особенности	☐ обычная, ☐ мягкая, ☐ пюре, ☐ жидкая, ☐ изменённая
Особенности глотания	☐ норма, ☐ поперхивание, ☐ помощь при приёме

Аппетит	☐ высокий, ☐ средний, ☐ сниженный, ☐ отказ
Предпочтения по напиткам	
Предпочтения по времени	
Предпочтения по месту	
Предпочтения по количеству	
Предпочтения по температуре	
Запреты (по назначению врача)	
Согласие жителя	Подпись
Согласие опекуна (при необходимости)	Подпись
Медицинское заключение	Подпись врача

**Приложение А3. Пищевая
биография Раздел Содержание
Ф.И.О. жителя Место рождения
Регион, откуда прибыл
Любимые блюда в детстве
Любимые блюда во взрослом
возрасте Блюда, которые ел по
праздникам Блюда, которые не
ел никогда Пищевые привычки
(время, место, способ)
Семейные традиции, связанные
с едой Религиозные
особенности Пищевая аллергия
(если есть)**

Привычки, связанные с ритуалами (мыть руки, проверять еду)
Предпочтения по текстуре Предпочтения по температуре Способность к
самостоятельному приёму пищи Потребность в помощи Кто заполнял ☐
сам житель, ☐ родственник, ☐ персонал Дата Подпись

Приложение А4. Простая форма выбора

Раздел	Содержание
Ф.И.О. жителя	
Место рождения	
Регион, откуда прибыл	
Любимые блюда в детстве	
Любимые блюда во взрослом возрасте	
Блюда, которые ел по праздникам	
Блюда, которые не ел никогда	
Пищевые привычки (время, место, способ)	
Семейные традиции, связанные с едой	
Религиозные особенности	
Пищевая аллергия (если есть)	
Привычки, связанные с ритуалами (мыть руки, проверять еду)	
Предпочтения по текстуре	
Предпочтения по температуре	
Способность к самостоятельному приёму пищи	
Потребность в помощи	

Кто заполнял	☐ сам житель, ☐ родственник, ☐ персонал
Дата	
Подпись	
Уровень Подпись	
Дата Ф.И.О. Что выбрал	
поддержки помогающего	
☐ самост., ☐ с	
поддержкой, ☐	
через	
представителя	

Приложение А5. Визуальное меню

Принципы: ☐ Фотографии реальных блюд учреждения. ☐ Крупный шрифт (не менее 16 пт). ☐ Контрастный цвет. ☐ Ламинация. ☐ Обновление при смене меню. Формат карточки: `` ` | [ФОТО РЕАЛЬНОГО БЛЮДА] | | БОРЩ СО СМЕТАНОЙ | | Объем: 300 мл | ` ``

Дата	Ф.И.О.	Уровень поддержки	Что выбрал	Подпись по могающего
	☐ самост., ☐ с поддержкой, ☐ через пре дставителя			

Приложение А6. Форма наблюдения за невербальным выбором Что

Дата Ф.И.О. Реакция Что съел Время Подпись предлагали ☐ взял, ☐
отверг, ☐ не реагировал

Приложение А7. Форма предварительного заказа Второй

Дата Ф.И.О. Завтрак Обед Полдник Ужин Подпись ужин

Приложение А8. Журнал срывов выбора Причина срыва Дата (закончился продукт, Замена Подпись поставщик, прочее)

Приложение А9. Журнал отказов от еды

Подпись От чего Объём

Приём мед. соц. № Дата Ф.И.О. отказалс съеденно Действия пищи
работник работник я го а а

Дата	Ф.И.О.	Что предлага ли	Реакци я	Что съел	Время	Подпис ь
		☐ взял, ☐ отверг, ☐ не реагирова л				

Дата	Ф.И.О	Завтрак	Обед	Полдник	Ужин	Второй ужин	Подпись

Table 3: Дата | Причина срыва (закончился продукт, поставщик, прочее) | Замена | Подпись

№	Дата	Ф.И.О.	Приём м пи щи	От чего отка залс я	Объём м съ еден но го	Дейс твия	Под пись мед. рабо тник а	Под пись соц. рабо тник а

Приложение А10. Алгоритм при отказе от блюда

□ Не уговаривать. □ Спросить причину (если возможно). □ Зафиксировать в журнале. □ Предложить альтернативу (напиток, фрукт, кефир). □ Сообщить медсестре. □ При систематическом отказе — сообщить врачу.

Приложение А11. Алгоритм при отказе от еды (длительном)
День Действие Ответственный
1 Фиксация отказа Персонал 1
Сообщение медсестре Персонал 1
Оценка состояния Медсестра
При повторном отказе — осмотр
2 Врач врачом При
продолжении — консилиум 3
Врач (врач + диетсестра +
психолог) Согласование с
опекуном (при 3 Соц. работник
недееспособности)
Дополнительное питание 3
Диетсестра (сипинговые смеси)
При отсутствии эффекта — 7
Врачебная комиссия
рассмотрение зондового
питания Обращение в орган
опеки (при 7 Соц. работник
необходимости)

Что нельзя делать: ☐ Принуждать к еде. ☐ Наказывать. ☐ Унижать. ☐
Кормить насильно без медицинского основания. Документы: ☐ Журнал

отказов. □ Запись в медицинской документации. □ Протокол консилиума. □ Заключение врачебной комиссии.

День	Действие	Ответственный
1	Фиксация отказа	Персонал
1	Сообщение медсестре	Персонал
1	Оценка состояния	Медсестра
2	При повторном отказе — осмотр врачом	Врач
3	При продолжении — консилиум (врач + диетсестра + психолог)	Врач
3	Согласование с опекуном (при недееспособности)	Соц. работник
3	Дополнительное питание (сипинговые смеси)	Диетсестра
7	При отсутствии эффекта — рассмотрение зондового питания	Врачебная комиссия
7	Обращение в орган опеки (при необходимости)	Соц. работник

Приложение А12. Алгоритм при риске аспирации Действие Кто Когда Наблюдение за каждым приёмом Персонал Постоянно пищи Фиксация признаков (поперхивание, кашель, влажный Персонал Немедленно голос) Прекращение кормления при Персонал Немедленно поперхивании Сообщение медсестре Персонал Немедленно

Осмотр врачом Врач В течение часа Консультация логопеда Логопед В течение 2 дней
Текстурная модификация (по Врач/логопед В течение 2 дней назначению)
Правильная поза (сидя, голова Персонал Постоянно слегка наклонена)
Загущение жидкостей (по Врач/логопед В течение 2 дней назначению)
Сопровождение при приёме пищи Персонал Постоянно
Признаки аспирации: □ Поперхивание. □ Кашель во время или после глотания.
□ «Влажный» голос. □ Затруднённое дыхание. □ Цианоз. □ Потеря сознания (при тяжёлой аспирации).
При тяжёлой аспирации: □ Приём Геймлиха. □ Скорая помощь.

Действие	Кто	Когда
Наблюдение за каждым приёмом пищи	Персонал	Постоянно
Фиксация признаков (поперхивание, кашель, влажный голос)	Персонал	Немедленно

Прекращение кормления при поперхивании	Персонал	Немедленно
Сообщение медсестре	Персонал	Немедленно
Осмотр врачом	Врач	В течение часа
Консультация логопеда	Логопед	В течение 2 дней
Текстурная модификация (по назначению)	Врач/логопед	В течение 2 дней
Правильная поза (сидя, голова слегка наклонена)	Персонал	Постоянно
Загущение жидкостей (по назначению)	Врач/логопед	В течение 2 дней
Сопровождение при приёме пищи	Персонал	Постоянно
□ Экстренное информирование врача.		

Приложение А13. Алгоритм при быстром заглатывании

□ Прекратить кормление. □ Дать прокашляться. □ Уменьшить порцию. □ Сопровождать каждый глоток. □ Исключить отвлекающие факторы. □ Подавать пищу по одной ложке. □ Рассмотреть finger food. □ Сообщить медсестре и врачу. □ Зафиксировать.

Приложение А14. Алгоритм при пикацизме

□ Исключить доступ к опасным несъедобным веществам. □ Обеспечить постоянное наблюдение. □ Сообщить врачу. □ Проверить уровень железа, цинка (по назначению). □ Рассмотреть поведенческую терапию. □ Зафиксировать.

Приложение А15. Алгоритм при конфликте за столом

□ Разделить участников. □ Обеспечить безопасность. □ Сообщить медсестре и соц. работнику. □ Пересадить (при необходимости). □ Обеспечить достаточные порции. □ Объяснить правила. □ При систематичности — поведенческая терапия. □ Зафиксировать.

**Приложение А16. Алгоритм при
пищевом инциденте**

Действие	Срок	Ответственный
1 Оказать помощь	Немедленно	Персонал
2 Изолировать подозреваемое	Немедленно	Персонал
3 Сохранить суточную пробу	Немедленно	Ответственный за пищеблок

4 Сообщить директору В течение часа Персонал 5 Сообщить учредителю В течение 2 часов Директор Сообщить в 6 В течение 24 часов Директор Роспотребнадзор Сообщить в прокуратуру 7 (при тяжких В течение 24 часов Директор последствиях) Создать комиссию по 8 В течение суток Директор расследованию 9 Провести расследование В течение 3 суток Комиссия Оказать медпомощь 10 По ситуации Врач пострадавшим Информировать 11 По ситуации Соц. работник родственников

Этап	Действие	Срок	Ответственный
1	Оказать помощь	Немедленно	Персонал
2	Изолировать подозреваемое	Немедленно	Персонал
3	Сохранить суточную пробу	Немедленно	Ответственный за пищеблок
4	Сообщить директору	В течение часа	Персонал

5	Сообщить учредителю	В течение 2 часов	Директор
6	Сообщить в Роспотребнадзор	В течение 24 часов	Директор
7	Сообщить в прокуратуру (при тяжких последствиях)	В течение 24 часов	Директор
8	Создать комиссию по расследованию	В течение суток	Директор
9	Провести расследование	В течение 3 суток	Комиссия
10	Оказать медпомощь пострадавшим	По ситуации	Врач
11	Информировать родственников	По ситуации	Соц. работник
12	Подготовить акт В течение 5 суток	Комиссия	
13	Принять меры В течение 10 суток	Директор	
14	Сообщить о результатах В течение 14 суток	Директор	

Приложение А17. Матрица RACI (см. главу 18)

Приложение А18. Чек-лист директора № Вопрос Да/Нет Утверждено положение о 1 ☐

питании? Утверждено положение о пищевом 2 ☐ совете? 3 Утверждено цикличное меню? ☐ 4 ☐ Согласовано с диетсестрой и 4 ☐ врачом? 5 ☐ Согласовано с учредителем? ☐ 6 Назначены ответственные? ☐ 7 Обучение проведено? ☐ 8 Пилот проведён? ☐ Аудит реальности выбора 9 ☐ проведён? Переписка с учредителем в 10 ☐ порядке? Антикоррупционная политика 11 ☐ утверждена? Программа производственного 12 ☐ контроля утверждена?

12	Подготовить акт	В течение 5 суток	Комиссия
13	Принять меры	В течение 10 суток	Директор
14	Сообщить о результатах	В течение 14 суток	Директор

№	Вопрос	Да/Нет
1	Утверждено положение о питании?	☐
2	Утверждено положение о пищевом совете?	☐
3	Утверждено цикличное меню?	☐
4	Согласовано с диетсестрой и врачом?	☐
5	Согласовано с учредителем?	☐
6	Назначены ответственные?	☐
7	Обучение проведено?	☐
8	Пилот проведён?	☐

9	Аудит реальности выбора проведён?	☐
10	Переписка с учредителем в порядке?	☐
11	Антикоррупционная политика утверждена?	☐
12	Программа производственного контроля утверждена?	☐

**Приложение А19. Чек-лист
пищеблока № Вопрос Да/Нет 1
НАССР внедрён? ☐ 2
Бракеражный журнал ведётся?
☐ 3 Суточная проба отбирается?
☐ Температурный режим 4 ☐**

соблюдается? ☐ 5 Товарное соседство соблюдается? ☐ 6 Медкнижки в порядке? ☐ 7 Маркировка инвентаря в порядке? ☐ 8 Поточность соблюдается? ☐ 9 ТК разработаны? ☐ 10 Меню-требования ведутся? ☐

Приложение А20. Чек-лист отделения № Вопрос Да/Нет Помощь при приёме пищи 1 ☐

обеспечена? Кормление лежачих 2 ☐ организовано? 3 Сбор предпочтений проводится? ☐ 4 Фиксация выбора ведётся? ☐ Наблюдение за состоянием 5 ☐ ведётся? 6 Документирование в порядке? ☐ 7 Обучение персонала проведено? ☐

№	Вопрос	Да/Нет
1	НАССР внедрён?	☐
2	Бракеражный журнал ведётся?	☐
3	Суточная проба отбирается?	☐
4	Температурный режим соблюдается?	☐
5	Товарное соседство соблюдается?	☐
6	Медкнижки в порядке?	☐
7	Маркировка инвентаря в порядке?	☐
8	Поточность соблюдается?	☐
9	ТК разработаны?	☐
10	Меню-требования ведутся?	☐

№	Вопрос	Да/Нет
---	--------	--------

1	Помощь при приёме пищи обеспечена?	☐
2	Кормление лежачих организовано?	☐
3	Сбор предпочтений проводится?	☐
4	Фиксация выбора ведётся?	☐
5	Наблюдение за состоянием ведётся?	☐
6	Документирование в порядке?	☐
7	Обучение персонала проведено?	☐
Адаптированные приборы		
8	☐	
имеются?		
9	Адаптированная посуда имеется?	☐
10 Питьевой режим обеспечен? ☐		

8	Адаптированные приборы имеются?	☐
9	Адаптированная посуда имеется?	☐
10	Питьевой режим обеспечен?	☐

**Приложение А21. Чек-лист
медицинского контура №
Вопрос Да/Нет 1 Реестр диет
актуализирован? ☐ 2 Реестр
текстур актуализирован? ☐ 3
Реестр аллергий
актуализирован? ☐ 4
Согласование меню проведено?
☐ 5 Консилиумы проводятся? ☐**

6 Мониторинг массы тела ведётся? ☐ Мониторинг нутритивного статуса 7
☐ ведётся? Врачебные назначения 8 ☐ документируются?
 Лекарственно-пищевые 9 ☐ взаимодействия учитываются? Согласование с
 органом опеки 10 ☐ проводится?

Приложение А22. Чек-лист закупок № Вопрос Да/Нет 1 План-график утверждён? ☐ 2 ТЗ соответствует требованиям? ☐ 3 НМЦК обоснована? ☐ Поставщики соответствуют 4 ☐

требованиям? Декларации/сертификаты в 5 ☐ порядке? 6 Приёмка
 комиссионная? ☐ 7 Замены документируются? ☐ 8 Претензионная работа
 ведётся? ☐ 9 ☐ Антикоррупционная политика

№	Вопрос	Да/Нет
1	Реестр диет актуализирован?	☐
2	Реестр текстур актуализирован?	☐
3	Реестр аллергий актуализирован?	☐
4	Согласование меню проведено?	☐
5	Консилиумы проводятся?	☐
6	Мониторинг массы тела ведётся?	☐
7	Мониторинг нутритивного статуса ведётся?	☐

8	Врачебные назначения документируются?	☐
9	Лекарственно-пищевые взаимодействия учитываются?	☐
10	Согласование с органом опеки проводится?	☐

№	Вопрос	Да/Нет
1	План-график утверждён?	☐
2	ТЗ соответствует требованиям?	☐
3	НМЦК обоснована?	☐
4	Поставщики соответствуют требованиям?	☐
5	Декларации/сертификаты в порядке?	☐
6	Приёмка комиссионная?	☐
7	Замены документируются?	☐
8	Претензионная работа ведётся?	☐
9	Антикоррупционная политика	☐
	применяется?	
	Конфликт интересов	
10	☐	
	декларируется?	

**Приложение А23. Чек-лист
бухгалтерского учёта № Вопрос
Да/Нет Первичные документы
содержат 1 ☐**

обязательные реквизиты? 2 Складской учёт ведётся? ☐ Меню-требования соответствуют 3 ☐ факту? 4 Списание обосновано? ☐ 5 Инвентаризация проводится? ☐ 6 Отчётность сдаётся в срок? ☐ Электронный документооборот 7 ☐ настроен? Специальные продукты 8 ☐ учитываются отдельно? 9 Анализ отходов проводится? ☐ Стоимость фактическая vs 10 ☐ плановая анализируется?

Приложение А24. Чек-лист проверки реальности выбора №

Вопрос Да/Нет Журналы выбора заполняются 1 ☐

жителями или с их участием? 2 ☐ Предложение реальное (не два

применяется?		
10	Конфликт интересов декларируется?	☐

№	Вопрос	Да/Нет
1	Первичные документы содержат обязательные реквизиты?	☐
2	Складской учёт ведётся?	☐
3	Меню-требования соответствуют факту?	☐
4	Списание обосновано?	☐
5	Инвентаризация проводится?	☐
6	Отчётность сдаётся в срок?	☐
7	Электронный документооборот настроен?	☐

8	Специальные продукты учитываются отдельно?	☐
9	Анализ отходов проводится?	☐
10	Стоимость фактическая vs плановая анализируется?	☐

№	Вопрос	Да/Нет
1	Журналы выбора заполняются жителями или с их участием?	☐
2	Предложение реальное (не два одинаковых)?	☐
3	Жители знают о наличии выбора? ☐	
	Персонал спрашивает	
4	☐	
	предпочтения?	
	Выбор учитывается при	
5	☐	
	планировании?	
6	Обратная связь работает? ☐	
7	Отходы снижаются? ☐	
8	Жалоб на отсутствие выбора нет? ☐	
	Наблюдатель видит реальный	
9	☐	
	выбор?	

10 Аудит проводится
регулярно? ☐

Приложение А25. Форма семидневного замера Врем я Приг Приг Зако

Выда Выда Съед Съед Оста Оста персо Отка Заме День отовл отовл нчил
но А но Б ено А ено Б ток А ток Б нала зов н ено А ено Б ось (часы) 1 2 3 4 5
6 7

одинаковых)?		
3	Жители знают о наличии выбора?	☐
4	Персонал спрашивает предпочтения?	☐
5	Выбор учитывается при планировании?	☐
6	Обратная связь работает?	☐
7	Отходы снижаются?	☐
8	Жалоб на отсутствие выбора нет?	☐
9	Наблюдатель видит реальный выбор?	☐
10	Аудит проводится регулярно?	☐

Д е н ь	П р и г о т о в л е н о А	П р и г о т о в л е н о Б	В ы д а н о А	В ы д а н о Б	С ъ е д е н о А	С ъ е д е н о Б	О с т а т о к А	О с т а т о к Б	В р е м я п е р с о н а л а (ч а с ы)	З а к о н ч и л о с ь	О т к а з о в	З а м е н
1												
2												
3												
4												
5												
6												
7												

**Приложение А26. Форма учёта
трудозатрат Процесс Время
(часов) Сотрудник
Комментарий Сбор
предпочтений Фиксация выбора
Помощь при приёме пищи
Кормление лежачих
Наблюдение Документирование
Связь с родственниками
Пищевой совет Аудит
реальности выбора**

Приложение А27. Форма отчёта о 90-дневном пилоте

□ Цель и задачи. □ Методология. □ Участники. □ Показатели (KPI). □ Результаты. □ Проблемы и их решения. □ Извлечённые уроки. □ Рекомендации по масштабированию. □ План дальнейших действий. □ Приложения (данные, протоколы, фото).

Процесс	Время (часов)	Сотрудник	Комментарий
Сбор предпочтений			
Фиксация выбора			
Помощь при приёме пищи			
Кормление лежачих			
Наблюдение			
Документирование			
Связь с родственниками			
Пищевой совет			
Аудит реальности выбора			

Приложение А28. Проект приказа о пилоте ``` ПРИКАЗ

от «__» _____ 20__ г. № ____ О проведении пилотного внедрения
вариативного меню В целях _____, на основании
_____ ПРИКАЗЫВАЮ: ☐ Провести пилот в отделениях № ____ и №
____ с «__» по «__». ☐ Утвердить меню пилота (Приложение 1). ☐ Назначить
ответственных: _____. ☐ Создать рабочую группу:
_____. ☐ Утвердить программу мониторинга (Приложение 2). ☐
Заседания рабочей группы — еженедельно. ☐ Контроль —
_____. Директор _____ С приказом ознакомлены:

Приложение А29. Проект положения о вариативном меню

(См. полную версию в главе 4; здесь — ключевые разделы.) □ Общие положения. □ Цели и задачи. □ Правовые основания. □ Категории получателей. □ Порядок информирования. □ Порядок фиксации выбора. □ Порядок замены продуктов. □ Контроль качества. □ Обратная связь. □ Ответственность. □ Заключительные положения.

Приложение А30. Положение о пищевом совете жителей

1. Общие положения. Пищевой совет — совещательный орган при директоре. Цель — участие жителей и родственников в организации питания. 2. Состав. Председатель (директор или заместитель), секретарь (соц. работник), члены: жители (не менее 2), родственники (не менее 2), врач, диетсестра, технолог, психолог, представитель общественного совета. 3. Полномочия. Согласование меню, оценка обратной связи, анализ жалоб, рекомендации по улучшению. 4. Порядок работы. Заседания — не реже 1 раза в квартал. Протоколы. Открытость. 5. Документы. Положение, протоколы, план работы.

Приложение А31. Памятка персоналу

Что я должен знать: □ Меню моего отделения на неделю. □ Диеты моих жителей. □ Текстуры моих жителей. □ Аллергии моих жителей. □ Предпочтения моих жителей. □ Способность к самостоятельному приёму пищи. □ Признаки аспирации. □ Алгоритм при поперхивании. □ Куда сообщать о проблемах. □ Как собирать предпочтения. □ Как фиксировать выбор. □ Как документировать отказы. □ Запрет на использование еды как наказания/поощрения. □ Запрет на заполнение журналов за жителя. □ Запрет на принуждение к еде. Что я не должен делать: □ Принуждать к еде. □ Наказывать лишением еды. □ Заполнять журналы за жителя. □ Использовать еду как поощрение. □ Игнорировать признаки аспирации. □ Изменять текстуру без назначения. □ Разглашать информацию о диагнозах.

Приложение А32. Памятка родственникам

Как мы организуем питание: ☐ 3-5-разовое питание (завтрак, обед, полдник, ужин, второй ужин). ☐ Учёт медицинских показаний (диета, текстура). ☐ Учёт предпочтений (при возможности). ☐ Помощь при приёме пищи. ☐ Контроль качества (бракераж, суточная проба). ☐ Обратная связь (анкетирование, жалобы). Как вы можете помочь: ☐ Заполнить карту пищевых предпочтений. ☐ Сообщить об аллергиях, особенностях. ☐ Участвовать в пищевом совете. ☐ Сообщать о жалобах и предложениях. ☐ Соблюдать правила посещения (без передачи продуктов без согласования). Что мы не делаем: ☐ Не заставляем есть. ☐ Не наказываем лишением еды. ☐ Не игнорируем медицинские показания. ☐ Не разглашаем информацию о других жителях. Куда обращаться: ☐ Социальный работник отделения. ☐ Старшая медсестра. ☐ Заместитель директора. ☐ Директор. ☐ Горячая линия учреждения. ☐ Орган опеки. ☐ Уполномоченный по правам человека.

Приложение А33. Форма сообщения учредителю о дефиците ресурсов ``` Учредителю:

_____ От:
директора _____

Уважаемый(ая) _____! Довожу до Вашего сведения, что в нашем учреждении выявлен дефицит ресурсов для обеспечения надлежащей _____ организации _____ питания: ☐

_____ ☐

_____ ☐

_____ Дефицит создаёт риски: ☐

_____ ☐

_____ Возможные последствия: ☐

_____ Прошу рассмотреть

возможность: ☐ _____ ☐

_____ Приложения: ☐ Расчёт

потребности. ☐ Обоснование. ☐ Акт проверки. Дата: _____ Подпись:

Приложение А34. Протокол разбора пищевого инцидента

1. Дата и место инцидента. 2. Состав комиссии. 3. Обстоятельства. 4. Пострадавшие. 5. Причины. 6. Виновные. 7. Меры по устранению. 8. Меры по недопущению. 9. Сроки исполнения. 10. Ответственные. 11. Подписи.

**Приложение А35. Форма
управленческого дашборда
Показатель Период Факт План
Отклонение Стоимость сырья
на 1 жителя в сутки Объём
отходов (кг/мес.) Число отказов
Число жалоб
Удовлетворённость (балл) Доля
жителей с реальным выбором
Число пищевых инцидентов
Укомплектованность штата
Замечания проверяющих Аудит
реальности выбора (%
расхождений)**

Приложение А36. Анкета жителей в доступном формате

1. Как вам еда в нашем учреждении? ☐ Вкусно ☐ Не вкусно ☐ Не знаю 2. Что вам нравится больше всего? (покажите карточки) 3. Что вам не нравится?

Показатель	Период	Факт	План	Отклонение
Стоимость сырья на 1 жителя в сутки				
Объём отходов (кг/мес.)				
Число отказов				
Число жалоб				
Удовлетворённость (балл)				
Доля жителей с реальным выбором				
Число пищевых инцидентов				
Укомплектованность штата				
Замечания проверяющих				
Аудит реальности выбора (% расхождений)				

(покажите
карточки)

4. Хотите ли
вы выбирать,
что есть?

☐ Да ☐ Нет
☐ Не знаю

5. Хотите ли
вы выбирать,
когда есть?

☐ Да ☐ Нет
☐ Не знаю

6. Хотите ли
вы выбирать,
где есть?

☐ Да ☐ Нет
☐ Не знаю

7. Что бы вы
хотели
добавить?

8. Что бы вы
хотели
убрать?

9. Кто
помогал
заполнять?

10. Дата:

СЕМИНАРСКИЙ ПАКЕТ
СЕМИНАРСКИЙ ПАКЕТ
Текст выступления на 20 минут (сокращённый)
Текст для устного выступления. Допускается свободное изложение по опорным точкам. Не зачитывать дословно.

[Открытие]
Добрый день, коллеги.

Прежде чем я начну, один вопрос к залу. Не поднимая рук, мысленно ответьте: кто в вашем учреждении в действительности выбирает, что сегодня будет есть житель — он сам, санитар, диетсестра, врач, кухня, контрактный управляющий или региональная норма? Запомните свой ответ. Он нам понадобится. [Блок 1. Почему это важно] Тема нашего семинара — права, свободы и интересы жителей и персонала социальных стационаров. Питание — это не кухня. Это пересечение нескольких прав: — Права на достоинство. — Права на охрану здоровья. — Права на информацию. — Права на уважение автономии. И одновременно — это зона ответственности: санитарной, медицинской, финансовой, закупочной, уголовной. Директор учреждения, который запускает вариативное меню, — это не тот, кто рисует красивые тарелки. Это тот, кто берёт на себя управляемый риск в системе, которая требует от него одновременно: — соблюсти СанПиН, — уложиться в подушевой норматив, — обеспечить

выбор, — не нарушить диету, — задокументировать, — и не сесть по 236-й. [Блок 2. Что такое вариативное питание] Вариативное питание — это не «два блюда вместо одного». Это семь уровней выбора: □ Выбор, что есть в пределах поданного. □ Выбор между двумя вариантами. □ Выбор количества. □ Выбор времени. □ Выбор места. □ Выбор способа еды и поддержки. □ Участие в планировании. Для многих жителей первый уровень — большая ценность. Выпить чай или компот — это реальный выбор. Для других — два основных блюда на обед. Для третьих — наблюдение и учёт предпочтений. Главный практический тезис доклада — это аналитическая формула, не норма закона:

- Вариативное питание — это не максимальное число блюд. Это максимальный реальный выбор, который конкретный человек способен сделать безопасно в пределах ресурсов учреждения.** [Блок 3. Почему нельзя просто дать выбор] Потому что за столом — сто человек с разными потребностями. Один не ест рыбу. Другой быстро заглатывает. Третий на текстурной диете. Четвёртый убеждён, что еду отравили. Пятый не говорит, но тянется к одной тарелке. Выбор — это не лозунг. Это ежедневная практика. Она требует: — знания жителей, — обучения персонала, — времени, — фиксации, — аудита реальности. [Блок 4. Пять конфликтов]

Конфликт 1. Выбор и безопасность. Медицинские показания —

приоритет. Но в пределах показаний — выбор сохраняется.

Конфликт 2. Предпочтение и назначение. Житель хочет сладкое при

диабете. Что важнее? Важнее — информированный выбор. Если дееспособен — фиксируется отказ. Если недееспособен — согласование с опекуном.

Конфликт 3. Индивидуальность и массовое производство. Кухня —

конвейер. Решение — блочная сборка, не уникальные блюда.

Конфликт 4. Достоинство и режим. Обед в одно время — режим, не

достоинство. Поздний завтрак — учёт ритма.

Конфликт 5. Инициатива и ответственность. Директор хочет сделать

хорошо. Но при пищевом отравлении — до 7 лет лишения свободы. Защита — документирование, согласование, фактическая работа. [Блок 5. Что требует право] Прямого запрета на вариативное меню в российском праве нет. Прямого предписания — тоже нет. Это — аналитический вывод системного толкования ФЗ-442, ФЗ-48, Закона 3185-1, КПРИ и Замечания общего порядка № 1 (2014) к ст. 12. Что обязательно: — Соблюдение натуральных норм (Приказ Минтруда 520н). — Соблюдение СанПиН. — Медицинские показания (диеты, текстуры). — Соблюдение бюджетного законодательства. — Соблюдение ФЗ-44. — Учёт мнения подопечного (ст. 36 ГК РФ). Что требует согласования: — С учредителем — финансирование. — С врачом — диета, текстура, зондовое питание. — С органом опеки — расходы на дорогостоящие диеты, спорные случаи. [Блок 6. Что делать сейчас] С понедельника: ☐ Провести экспресс-аудит — что у вас сейчас с меню, выбором, фиксацией. ☐ Собрать предпочтения жителей — хотя бы в простой форме. ☐ Сформировать пищевой совет. ☐ Начать с выбора напитка — без дополнительных затрат. ☐ Обучить персонал распознавать признаки дисфагии. ☐ Внести в ИППСУ раздел о пищевых предпочтениях. ☐ Провести семидневный замер отходов. ☐ Запросить у учредителя информацию о подушевом нормативе. ☐ Подготовить переписку о кадровом дефиците. ☐ Утвердить локальный акт о пищевом совете. [Заккрытие] Директор, который запускает вариативное питание, не должен быть один. Ему нужны: учредитель, врач, диетсестра, психолог, соц. работник, технолог, бухгалтер, контрактный управляющий, юрист. Директор, который боится вариативного питания, тоже не должен быть один. Ему нужны: те же люди. Разница — в подходе. Первый управляет риском. Второй прячется от риска. Управлять — лучше. Спасибо. Готов ответить на вопросы. Текст выступления на 45 минут (полный) Полная версия включает развёрнутые блоки 1–6 из сокращённого, плюс:

- Разбор 3–4 кейсов из 20 (5 минут).
- Обзор региональной практики (5 минут).
- Дорожная карта на 12–18 месяцев (5 минут).

- Ответы на типичные возражения (5 минут).

Структура 45-минутного выступления: □ (2 мин) Открытие — вопрос к залу. □ (5 мин) Почему это важно. □ (5 мин) Что такое вариативное питание (7 уровней). □ (5 мин) Пять конфликтов одного обеда. □ (3 мин) Разбор 1–2 кейсов. □ (5 мин) Что требует право. □ (3 мин) Региональная практика — 2–3 примера. □ (5 мин) Что делать сейчас (10 шагов). □ (3 мин) Дорожная карта. □ (3 мин) Ответы на типичные возражения. □ (3 мин) Закрытие. □ (3 мин) Вопросы. Презентация: сценарий слайдов (30–35 слайдов) № Слайд Содержание Время НЕ ПРОСТО 1 Титульный 0,5 НАКОРМИТЬ.

№	Слайд	Содержание	Время
1	Титульный	НЕ ПРОСТО НАКОРМИТЬ.	0,5
	Межрегиональны й		
	семинар «Пространство		
	Новых Идей 2.0». С Пб,		
	25–27 августа 2026		
	Кто в вашем учреждении		
	2 Вопрос к залу выбирает, что сегодня 0,5		
	будет есть житель?		
	Один обед — пять Иллюстрация сцены		
	3 1,5		
	конфликтов (илл. кейс)		
	Выбор/безопасно сть,		

предпочтение/на значение
,
4 Пять конфликтов индивидуальность/массо 1
вое, достоинство /режим,
инициатива/ответственно
сть
Питание — пересечение
5 Почему это важно 1
прав и ответственности
Физиология,
безопасность,
6 Шесть функций питания удовольствие, 1
социальность,
автономия, терапия
7 Кто сидит за столом Неоднородность жителей 1
8 Лестница вариативности 7 уровней 1,5
10 моделей

9 Сводная таблица 2
вариативности
Лечебное и
10 Разграничение 0,5
индивидуальное меню
Признаки, риски,
11 Дисфагия и аспирация 1,5
действия
После инсульта,
12 Кто в группе риска деменция, ДЦП, РАС, 1
нейролептики
13 IDDSI 8 уровней текстур 1
14 Лекарства и питание Принцип осторожности 1,5
15 Конкретные препараты Клозапин, литий, ИМАО, 1,5

|

**Межрегиональ
ый семинар
«Пространство
Новых Идей
2.0». СПб, 25-27
августа 2026 |**

2	Вопрос к залу	Кто в вашем учреждении выбирает, что сегодня будет есть житель?	0,5
3	Один обед — пять конфликтов	Иллюстрация сцены (илл. кейс)	1,5
4	Пять конфликтов	Выбор/безопасность, предпочтение/назначение, индивидуальность/массовое, достоинство/режим, инициатива/ответственность	1
5	Почему это важно	Питание — пересечение прав и ответственности	1
6	Шесть функций питания	Физиология, безопасность, удовольствие, социальность, автономия, терапия	1
7	Кто сидит за столом	Неоднородность жителей	1
8	Лестница вариативности	7 уровней	1,5
9	10 моделей вариативности	Сводная таблица	2
10	Лечебное и индивидуальное меню	Разграничение	0,5
11	Дисфагия и аспирация	Признаки, риски, действия	1,5
12	Кто в группе риска	После инсульта, деменция, ДЦП, РАС, нейрорептики	1

13	IDDSI	8 уровней текстур	1
14	Лекарства и питание	Принцип осторожности	1,5
15	Конкретные препараты	Клозапин, литий, ИМАО,	1,5
нейролептики			
Отказ от еды при			
16 Кейс: дилемма директора 2			
депрессии			
Житель с деменцией,			
17 Кейс: аспирация 2			
поперхивание			
18 Кейс: пикацизм Житель с тяжёлой УО 1			
Кейс: конфликт за			
19 Два жителя с деменцией 1			
столом			
20 Дееспособность и опека Различение понятий 1			
21 Что требует право НПА — карта решений 1,5			

Прямого предписания
22 Прямого запрета нет тоже нет — 0,5
аналитический вывод
Новосибирск, Тюмень,
23 Российская практика 1,5
Вологда, СПб
КПРИ, Финляндия,
24 Международный опыт 1
Великобритания, ESPEN
25 Финансовые модели 5 моделей 1,5
Особенности
26 Закупки и учёт 1
вариативности
27 10 рисков директора Тепловая карта 1,5
Что мы называем, кому
28 7 ответов директора 1
доступно, как сохранить

29 Пилот на 90 дней Этапы, KPI 1
30 10 шагов с понедельника Что сделать сейчас 1
31 10 вопросов учредителю Что спросить 0,5
Реальный выбор, не
32 Главный тезис 0,5
ресторан
33 Документы QR-код для скачивания 0,5
34 Спасибо Контакты 0,5
Всего: ~30 мин + 15 мин вопросы = 45 мин.

нейрорепти			
16	Кейс: дилемма директора	Отказ от еды при депрессии	2
17	Кейс: аспирация	Житель с деменцией, поперхивание	2
18	Кейс: пикацизм	Житель с тяжёлой УО	1
19	Кейс: конфликт за столом	Два жителя с деменцией	1
20	Дееспособность и опека	Различение понятий	1

21	Что требует право	НПА — карта решений	1,5
22	Прямого запрета нет	Прямого предписания тоже нет — аналитический вывод	0,5
23	Российская практика	Новосибирск, Тюмень, Вологда, СПб	1,5
24	Международный опыт	КПРИ, Финляндия, Великобритания, ESPEN	1
25	Финансовые модели	5 моделей	1,5
26	Закупки и учёт	Особенности вариативности	1
27	10 рисков директора	Тепловая карта	1,5
28	7 ответов директора	Что мы называем, кому доступно, как сохранить	1
29	Пилот на 90 дней	Этапы, KPI	1
30	10 шагов с понедельника	Что сделать сейчас	1
31	10 вопросов учредителю	Что спросить	0,5
32	Главный тезис	Реальный выбор, не ресторан	0,5
33	Документы	QR-код для скачивания	0,5
34	Спасибо	Контакты	0,5
Раздаточный материал для участников (8-12 страниц)			

□ Семь уровней вариативности (1 стр.).

□ Пять конфликтов (1 стр.).

□ Матрица способности к выбору (1 стр.).

□ Кто в группе риска по дисфагии (1 стр.).

□ Принципы осторожности: лекарства и питание (1 стр.).

□ Дееспособность и опека: ключевые разграничения (1 стр.).

□ Что требует российское право: карта решений (1 стр.).

□ Пять финансовых моделей (1 стр.).

□ Десять рисков директора: тепловая карта (1 стр.).

□ Пилот на 90 дней: чек-лист (1 стр.).

□ Десять шагов с понедельника (1 стр.).

□ Десять
вопросов
учредителю (1
стр.).

Сценарий
обсуждения в
малых группах
(45 минут)

Группа 1. Директора ПНИ. Кейс 1 (закончился вариант) + кейс 2 (выбор запрещённого). Группа 2. Директора ДДИ. Кейс 14 (неговорящий) + кейс 16 (пиказизм). Группа 3. Директора ДСО. Кейс 4 (фиктивный выбор) + кейс 13 (учёт). Группа 4. Представители региональных органов. Кейс 19 (прокуратура) + кейс 21 (учредитель). Группа 5. Смешанная. Кейс 12 (выбор на бумаге) + кейс 18 (нехватка персонала). Вопросы для обсуждения: □ Что бы вы сделали в этой ситуации? □ Что нельзя делать? □ Кто принимает решение? □ Какой документ нужен? □ Как доказать исполнение? Пять вопросов для дискуссии с залом □ Какая модель вариативности реалистична в вашем учреждении? □ Что мешает начать завтра? □ Какие риски вы видите лично для себя? □ Как убедить учредителя? □ Готовы ли вы к проверке прямо сейчас? Интерактивный экспресс-аудит (10 минут) Участники оценивают своё учреждение по 10 вопросам (1 минута на вопрос). □ Утверждено ли положение о питании? □ Согласовано ли меню с диетсестрой? □ Есть ли в ИППСУ раздел о пищевых предпочтениях? □ Проводится ли сбор предпочтений? □ Обучен ли персонал распознавать признаки дисфагии? □ Есть ли пищевой совет? □ Проводится ли аудит реальности выбора? □ Есть ли переписка с учредителем о дефиците? □ Утверждена ли антикоррупционная политика? □ Проводится ли мониторинг отходов? Интерпретация: □ 0-3: уровень 1 (старт). □ 4-6: уровень 2 (развитие). □ 7-10: уровень 3 (зрелость). Форма «Моя ступень вариативности» Участник определяет ступень своего учреждения: Ступень Что есть Что добавить 0 Нет выбора Начать с выбора напитка 1 Выбор напитка Добавить выбор гарнира Добавить выбор основного блюда 2 Выбор напитка + гарнир 2 раза в неделю Перейти к ежедневному выбору из 3 Выбор 1-2 блюда 2 р/нед двух 4 Ежедневный выбор из двух Добавить диетические линии Добавить текстурно- 5 Несколько линий модифицированные линии Поддерживать, мониторить, 6 Полная система обновлять Типичные возражения директоров и ответы Возражение 1. «У нас нет денег на дополнительный персонал».

Ступень	Что есть	Что добавить
0	Нет выбора	Начать с выбора напитка
1	Выбор напитка	Добавить выбор гарнира
2	Выбор напитка + гарнир	Добавить выбор основного блюда 2 раза в неделю
3	Выбор 1-2 блюда 2 р/нед	Перейти к ежедневному выбору из двух
4	Ежедневный выбор из двух	Добавить диетические линии
5	Несколько линий	Добавить текстурно-модифицированные линии
6	Полная система	Поддерживать, мониторить, обновлять
Ответ. Начните с модели, не требующей дополнительных ставок (выбор напитка, гарнира). Параллельно — заявка учредителю с обоснованием. Покажите риски нехватки. Возражение 2. «Кухня не позволяет две линии». Ответ. Не претендуйте на максимум. Начните с минимума. Постепенно модернизируйте. Возражение 3. «Это увеличит расходы».		

Ответ. На 1-2% при минимуме. На 15-20% при двух вариантах. Это

инвестиция в качество и снижение рисков.

Возражение 4.
«Учредитель не согласует».

Ответ. Подготовьте обоснование. Покажите практику регионов. Покажите

связь с правами жителей.

Возражение 5. «Нет врача/диетсестры».

Ответ. Привлекайте по договору. Используйте телемедицину.

Используйте потенциал психолога.

Возражение 6. «Жители не смогут выбирать».

Ответ. Используйте карточки, пиктограммы, наблюдение. Пищевую

биографию.

Возражение 7. «Боюсь проверок».

Ответ.
Документирование — ваша защита.
Переписка — ваша защита.

Фактическая безопасность — ваша защита.

Возражение 8. «У нас и так всё работает».

Ответ. Проверьте:
собираются ли
предпочтения?
Действительно ли

жители выбирают? Не
фиктивный ли выбор?

Список решений,
которые можно принять
без новых средств

☐ Провести
экспресс-аудит.

☐ Собрать предпочтения
(анкетирование,
беседы).

☐ Сформировать
пищевой совет.

☐ Начать с выбора
напитка.

☐ Обучить персонал
(внутренние ресурсы).

☐ Внести в ИППСУ
раздел.

☐ Провести
семидневный замер.

☐ Запросить
информацию у
учредителя.

☐ Подготовить
переписку о дефиците.

☐ Утвердить локальный
акт о пищевом совете.

Список решений,
требующих
финансирования

☐ Дополнительные
ставки (повар,
диетсестра, соц.
работник).

☐ Модернизация
пищеблока.

☐ Покупка
адаптированной посуды
и приборов.

☐ Покупка оборудования
(блендер,
пароконвектомат).

☐ Загустители,
специальные продукты.

☐ Визуальные
материалы (фото,
карточки).

☐ Обучение с
привлечением внешних
экспертов.

☐ IT-система
(электронный выбор).

Список решений,
требующих
согласования с
учредителем

☐ Изменение
государственного
задания.

☐ Корректировка
подушевых нормативов.

☐ Дополнительные
ставки.

☐ Использование
грантов.

☐ Аутсорсинг.

☐ Изменение структуры
учреждения.

Список решений,
которые нельзя
принимать без врача

☐ Назначение диеты.

☐ Текстурная
модификация.

☐ Зондовое питание.

☐ Изменение лекарств.

☐ Принудительное
кормление.

☐ Оценка
дееспособности.

Вопросы, требующие
индивидуального
юридического

заключения

☐ Правомерность
конкретной модели
вариативности в
конкретном субъекте

РФ.

☐ Допустимость отказа
от медицинской диеты
при недееспособности.

☐ Правовой статус
«пищи по желанию».

☐ Пределы участия
опекуна в бытовом
выборе.

☐ Конфликт интересов
учреждения-опекуна.

ЗАЯВЛЕНИЕ О
ДОСТОВЕРНОСТИ

Дата актуальности
законодательства и
открытых данных: 22
июля 2026 г.

Дата последней
проверки ссылок: 22
июля 2026 г.

Число найденных
источников: 41 (20
федеральных НПА, 9
региональных, 4

контрольной практики,
8 международных).

Полностью проверено:
22. Частично проверено:
13. Исключено: 8 (не

подтверждены
количественно).

Недоступные
официальные
документы: 6 (требуют
авторизации).

Число
неподтверждённых
утверждений из старых
докладов: 12 (см.

AUDIT_OLD_REPORTS.md)
.

Все расчёты —
иллюстративные. Не
являются нормативом
или подтверждённой

стоимостью
конкретного
учреждения.

Все утверждения о
лекарственно-пищевых
взаимодействиях
требуют проверки

по конкретному препарату.

Решения, принимаемые на основании доклада, требуют адаптации к

конкретному субъекту РФ, учреждению, медицинским условиям и

индивидуальной экспертизы врача, юриста, бухгалтера, контрактного

управляющего.

Доклад подготовлен как практическое руководство для руководителей

стационарных организаций социального обслуживания. Главный результат —

не количество страниц, а то, что директора дослушают, обсудят и смогут

применить.